

Capitolato Tecnico

Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della
Regione Veneto

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	6
1.1.	Scopo e organizzazione del documento	6
1.2.	Acronimi e glossario	7
2.	ELEMENTI GENERALI DELL'INIZIATIVA	13
2.1.	Contesto di riferimento.....	13
2.2.	Obiettivi e contenuti dell'iniziativa	16
2.3.	Estensione complessiva e orizzonte temporale dell'iniziativa	18
2.4.	Modello di approvvigionamento ed Enti sanitari interessati	19
3.	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	20
3.1.	Descrizione del sistema.....	22
4.	REQUISITI FUNZIONALI	25
4.1.	Generazione di documenti	25
4.2.	Fruibilità dati storici	26
4.4.	Flussi informativi e produzione del debito informativo	26
4.4.1.	SIAD	27
4.4.2.	ODC-URT	27
4.4.3.	SIAR	28
4.4.4.	Hospice.....	28
4.4.5.	SISM.....	29
4.4.6.	SICOF.....	29
4.4.1.	ICR.....	29
4.5.	Auditing.....	30
4.6.	Dizionari, Cataloghi, Codifiche.....	31
4.7.	Autenticazione	32
4.8.	Profilazione, autorizzazione e visibilità del dato	32
4.9.	Notifiche e alert.....	34
4.10.	Acquisizione documenti e oggetti multimediali esterni	34
4.11.	Visualizzazione dei documenti clinici e amministrativi	34

4.12. Gestione privacy e consensi	34
4.13. Requisiti specifici – Sistema Centrale Operativa Territoriale (COT)	35
4.13.1. Percorso di dimissione protetta.....	35
4.13.2. Percorso di ammissione protetta	35
4.13.3. Gestione di una scheda di segnalazione da parte della COT	36
4.13.4. Erogazione di una segnalazione	37
4.14. Requisiti specifici – Sistema Strutture di Ricovero a Carattere Intermedio: OdC e URT 37	
4.14.1. Diario e comunicazioni.....	37
4.14.2. Terapia informatizzata	37
4.14.3. Monitoraggio dei parametri vitali	38
4.14.4. Fatturazione.....	38
4.15. Requisiti specifici – Sistema Strutture di Ricovero a Carattere Intermedio: Hospice 39	
4.15.1. Diario e comunicazioni.....	40
4.15.2. Terapia informatizzata	40
4.15.3. Monitoraggio dei parametri vitali	41
4.15.4. Ulteriori strumenti a supporto	41
4.16. Requisiti specifici – Sistema Cure Domiciliari	41
4.16.1. Attività.....	41
4.16.2. PAI	41
4.16.3. Order Entry	42
4.16.4. Terapia informatizzata	42
4.16.5. Diario e comunicazioni.....	43
4.16.6. Calendario e scadenze	43
4.16.7. Report attività domiciliari.....	43
4.16.8. Ulteriori strumenti a supporto	43
4.17. Requisiti specifici – Sistema Consultori, Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile 44	
4.17.1. Apertura cartella	44
4.17.2. Apertura percorso	44

4.17.3.	Accessi/Visite.....	45
4.17.4.	Gestione percorso	45
4.17.5.	Chiusura percorso	46
4.18.	Requisiti specifici – Sistema Centro Salute Mentale (CSM).....	46
4.18.1.	Accoglienza	46
4.18.2.	Trattamento	47
4.18.3.	Conclusione	48
4.19.	Requisiti specifici – Sistema di Prescrizione Elettronica	48
4.19.1.	Prescrizione farmaceutica.....	48
4.19.2.	Prescrizione specialistica.....	49
5.	REQUISITI NON FUNZIONALI	50
5.1.	Interoperabilità e integrazioni.....	50
5.2.	Accessibilità e usabilità.....	53
5.3.	Efficienza ed Efficacia.....	56
5.4.	Disponibilità	57
5.5.	Estendibilità e scalabilità.....	58
5.6.	Tracciabilità ed esibizione.....	59
5.7.	Gestione utenze.....	60
5.8.	Affidabilità e Sicurezza	60
5.9.	Reporting, monitoraggio e stampe	61
5.10.	Garanzie di performance	61
6.	ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO	62
6.1.	Contesto Azienda Zero	62
6.2.	Architettura del sistema	62
6.2.1.	Modello architetturale.....	62
6.2.2.	Elementi software	62
6.2.3.	Connettori e interfacce.....	62
6.2.4.	Infrastruttura tecnologica e caratteristiche dimensionali	63
6.3.	Il contesto organizzativo - geografico	63
6.3.1.	Elementi software (es. moduli, componenti, servizi, DB, etc.)	63

6.3.2.	Integrazioni con altri software già presenti nel contesto di riferimento	63
6.3.2.1.	Sistemi di firma digitale	64
6.3.2.2.	Ambienti tecnologici	64
6.4.	Requisiti e Vincoli	67
7.	SERVIZI PROFESSIONALI	68
7.1.	Servizi gestionali e applicativi	68
7.2.	Profili professionali	69
8.	GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	70
8.1.	Protezione dei dati personali	70
8.1.1.	Obblighi generali del Fornitore in materia di protezione dei dati personali	73
8.1.2.	Previsioni specifiche materia di protezione dei dati personali	75
8.2.	Gestione della sicurezza delle informazioni	77
8.2.1.	Requisiti generali	77
8.2.2.	Requisiti di riservatezza	78
8.2.3.	Gestione del personale del Fornitore	79
8.2.4.	Accesso agli ambienti ed ai sistemi	79
8.2.5.	Modalità e specifiche di connessione	81
8.2.6.	Infrastruttura del Fornitore	82
8.2.7.	Analisi e gestione dei rischi	84
8.2.8.	Gestione degli eventi anomali, degli incidenti e della Business Continuity	84
8.2.9.	Rispetto delle procedure di sicurezza	85
8.2.10.	Report da parte del Fornitore	86
8.2.11.	Attività di verifica e controllo	86
8.2.12.	Deroghe	86
8.2.13.	Reperibilità	87
9.	REALIZZAZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DELIVERY DEL SISTEMA	88
9.1.	Generalità	88
9.2.	Fasi progettuali e relative tempistiche	89
9.2.1.	Assessment e definizione del Piano di Lavoro di Obiettivo	90
9.2.2.	Sviluppo del sistema e personalizzazione di soluzioni	91

9.2.3.	Test e collaudo del sistema	91
9.2.4.	Formazione, Avviamento e completamento della diffusione del sistema in tutti gli ES	92
9.2.5.	Gestione a regime	93
9.3.	Gestione della Fornitura	94
9.3.1.	Governo della Fornitura	94
9.3.2.	Gestione del contratto con il Fornitore e relative tempistiche.....	95
9.3.3.	Ruoli di Governo	97
9.3.4.	I processi di Governo	98
9.4.	Manutenzione, Assistenza e Conduzione Applicativa.....	99
9.4.1.	Manutenzione	99
9.4.2.	Assistenza	100
9.4.3.	Conduzione applicativa.....	102
9.4.3.1.	Presidio on site	103
9.5.	Exit Strategy	104
9.6.	Rendicontazione	106
10.	LIVELLI DI SERVIZIO	107
11.	GESTIONE DEI CORRISPETTIVI.....	109
11.1.	Organizzazione dei corrispettivi	109
12.	ELEMENTI DIMENSIONALI	112

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo e organizzazione del documento

Il presente documento ha lo scopo di presentare al Fornitore proponente l'oggetto e l'articolazione della fornitura richiesta da Azienda Zero, nonché gli elementi per articolare l'offerta tecnica richiesta per l'aggiudicazione della procedura di acquisizione.

Tale documento fa riferimento alla DGR n° 72 del 29/01/2024, con cui la Regione del Veneto ha assegnato ad Azienda Zero l'obiettivo di realizzare una proposta di Sistema Informativo Territoriale (SI.Ter), determinando gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2024, e nello specifico, l'obiettivo "Q.8 - Efficientamento dei processi amministrativi attraverso sistemi informativi centralizzati", tra il quale rientra l'indicatore "Q.8.3 - Analisi e proposta del sistema informativo territoriale".

Successivamente, mediante la DGR n° 64 del 27/01/2025, sono stati determinati gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2025, e nello specifico, l'obiettivo "02.S - Perseguimento interventi strategici di informatica", tra il quale rientra l'indicatore. "25.S.S.04.2 - Sistema Informativo Territoriale. Rispetto indicazioni per attuazione cronoprogramma".

Ulteriore elemento di riferimento è l'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi in ambito "SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino per Le Pubbliche Amministrazioni del SSN" - ID-2365 Lotto 3.

Nella prima parte del documento (Capitolo 2) vengono presentati gli elementi generali dell'iniziativa in termini di contesto, schema logico, strategia di sourcing e architettura di riferimento.

Viene poi (Capitolo 3) specificato l'oggetto della Fornitura richiesta.

In seguito (Capitolo 4 e Capitolo 5) viene delineato il modello di riferimento che dovrà indirizzare la proposta da parte del Fornitore proponente in termini di requisiti funzionali e non funzionali, esigenze di supporto ai processi e vincoli tecnologici che dovranno essere rispettati per garantire le integrazioni necessarie con le altre componenti dei Sistemi Informativi delle Enti Sanitari (di seguito anche ES) della Regione Veneto.

Nel Capitolo 6 viene definita l'Architettura di riferimento del sistema.

Sono poi descritte le caratteristiche dei servizi professionali (Capitolo 7) compresi all'interno del perimetro di gara.

Successivamente (Capitolo 8) vengono elencati i requisiti e i processi che il Fornitore dovrà eseguire al fine di garantire la privacy e la sicurezza delle informazioni.

In seguito (Capitolo 9) sono indicate le specifiche di realizzazione, gestione, assistenza, manutenzione e delivery in termini di: organizzazione complessiva, tempistiche di massima attese, strumenti di coordinamento tra i referenti degli Enti Sanitari (ES) e le risorse del Fornitore, altri servizi specialistici richiesti. Sono inoltre riportati gli obiettivi specifici e le linee guida circa gli

interventi a livello di singolo Ente Sanitario, per quanto riguarda in particolare l'introduzione del nuovo sistema.

Successivamente (Capitolo 10) vengono riportati i Livelli di servizio che verranno monitorati dagli ES nell'esecuzione della Fornitura. Questi riguardano sia gli aspetti gestionali sia gli aspetti tecnici dell'erogazione dei servizi descritti nelle precedenti sezioni del presente Capitolato Tecnico. Rispetto a questi si articolerà lo schema delle penali contrattuali che potranno essere applicate dagli ES al Fornitore in caso di inadempienza.

Viene poi (Capitolo 11) riportata l'organizzazione dei corrispettivi che sarà messa in atto durante il progetto.

Sono infine descritti (Capitolo 12) gli elementi dimensionali di riferimento del servizio.

1.2. Acronimi e glossario

Tabella 1 – Significato e descrizione degli acronimi

Acronimo	Significato	Descrizione
ACN	Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale	-
ADI	Assistenza Domiciliare Integrata	-
ADL	Activities of Daily Living	È uno strumento utilizzato per valutare la capacità di una persona di svolgere le attività di base della vita quotidiana.
ADT	Ammissione, Dimissione e Trasferimento	È un sistema informativo che gestisce tutti i processi relativi ai ricoveri e ai movimenti dei pazienti (degenze ordinarie ecc.).
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale	-
AIFA	Agenzia Italiana del Farmaco	-
API	Application Programming Interface	Sono meccanismi che consentono a due componenti software di comunicare tra loro usando una serie di definizioni e protocolli.
APMS	Application Profile Management System	È un sistema di cui si è dotata Azienda Zero per la gestione dell'autenticazione e profilazione degli utenti per le architetture applicative su cloud AWS del tipo descritto nel documento Reference Architecture.
ATNA	Audit Trail and Node Authentication	Rappresenta il profilo di integrazione che stabilisce le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza e la confidenzialità dei dati sanitari, attraverso audit, autenticazione nodale e altre misure.
BARTHEL	Scala di Barthel	È uno strumento di valutazione utilizzato per misurare il grado di autonomia di un paziente nelle attività della vita quotidiana (ADL).
BC	Business Continuity	Rappresenta un insieme di procedure documentate che guidano le organizzazioni a rispondere, recuperare, riavviare e ripristinare un livello predefinito di operazioni dopo le interruzioni.
BMI	Body Mass Index	-
BRASS	Blaylock Risk Assessment Screening Score	È uno strumento utilizzato per identificare i pazienti a rischio di ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficile.
CA	Continuità Assistenziale	-
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale	È un insieme di norme italiane che regolano l'uso delle tecnologie digitali nella Pubblica Amministrazione.
CD	Cure Domiciliari	-
CEE	Comunità Economica Europea	-

AZIENDA ZERO – Appalto Specifico ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della Regione Veneto – ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2365 - LOTTO 3 Capitolato Tecnico

Acronimo	Significato	Descrizione
CERT	Computer Emergency Response Team	È una struttura specializzata nella prevenzione, rilevazione e risposta a incidenti di sicurezza informatica, con funzioni di supporto tecnico e diffusione di allerta.
CMMI	Capability Maturity Model Integration	È un processo e un modello comportamentale che aiuta le organizzazioni a ottimizzare il miglioramento dei processi e incoraggiare comportamenti produttivi ed efficienti che riducono i rischi nello sviluppo di software, prodotti e servizi.
COBIT	Control Objectives for Information and related Technology	È un framework di governance che fornisce principi, modelli e best practice per aiutare le organizzazioni a controllare e ottimizzare l'uso delle tecnologie digitali, assicurando allineamento con gli obiettivi aziendali, sicurezza e valore.
COT	Centrale Operativa Territoriale	-
CP	Cure Palliative	-
CSIRT	Computer Security Incident Response Team	È un team organizzato per gestire in modo coordinato gli incidenti di sicurezza informatica, garantendo la continuità operativa e la protezione delle informazioni.
CSM	Centro Salute Mentale	-
CTS	Capitolato Tecnico Speciale	È un documento contrattuale che definisce in dettaglio le specifiche tecniche, i requisiti, le modalità di esecuzione e le prestazioni attese relative a una fornitura o un servizio nell'ambito di una gara d'appalto o contratto pubblico.
CUP	Centro Unico di Prenotazione	-
CVP	Catalogo Veneto del Prescrivibile	È un sistema che permette di codificare in maniera univoca le prestazioni specialistiche e di laboratorio erogate dal SSR e permette di garantire la corrispondenza tra prestazioni prescritte ed erogate.
DB	Database	-
DEA	Dipartimenti di Emergenza Accettazione	Rappresenta il modello organizzativo multidisciplinare che prevede l'integrazione funzionale delle unità operative e servizi sanitari necessari ad affrontare questioni diagnostiche e terapeutiche.
DPIA	Data Protection Impact Assessment	È una valutazione che mira a garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme al GDPR, identificando e gestendo i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
DR	Disaster Recovery	È un insieme di azioni, strategie e misure tecnologiche e organizzative necessarie al ripristino di infrastrutture, sistemi e singoli dati, a fronte di emergenze o accadimenti che ne hanno intaccato la normale operatività.
DWH	Data Warehouse	È un repository centralizzato che archivia dati strutturati e dati semi-strutturati per la creazione di report e l'analisi.
DSM	Dipartimento di Salute Mentale	-
ES	Enti Sanitari	-
FSE	Fascicolo Sanitario Elettronico	-
FTE	Full Time Equivalent	-
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	È uno standard che descrive i formati e gli elementi dei dati, nonché un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) per lo scambio di informazioni mediche.
FUT	Foglio Unico di Terapia	È uno strumento che raccoglie in un unico documento tutte le informazioni sul processo terapeutico farmacologico applicato alle persone assistite nei servizi sanitari e socio-sanitari.



Acronimo	Significato	Descrizione
GDPR	General Data Protection Regulation	Rappresenta il Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, avente ad oggetto la protezione delle sole persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati all'interno dell'Unione Europea.
GF	Green Field	È un servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo.
HL7	Health Level Seven	Rappresenta lo standard XML per lo scambio di informazioni cliniche e amministrative.
HSP11 bis	Dati anagrafici degli istituti facenti parte della struttura di ricovero	Rappresenta il modello di rilevazione dei dati anagrafici degli istituti facenti parte della struttura di ricovero.
IADL	Instrumental Activities of Daily Living	È uno strumento per valutare i gradi di autonomia nelle attività strumentali di un paziente.
IAF	Infanzia, Adolescenza e Famiglia	Rappresenta l'area sociosanitaria che ha lo scopo di tutelare la salute della donna, della persona, della coppia e della famiglia, e i soggetti in età evolutiva, inclusa l'assistenza psichiatrica in età evolutiva.
IAN	Incontri di Accompagnamento alla Nascita	-
IAP	Identity and Assertion Provider	È una forma specifica di provider di autenticazione che consente agli utenti o ai processi di sistema di affermare la propria identità tramite token (autenticazione perimetrale).
ICD9-CM	International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification	È una classificazione che descrive in codici numerici o alfa-numerici i termini medici in cui sono espressi le diagnosi di malattia o di traumatismo, gli altri problemi di salute, le cause di traumatismo e le procedure diagnostiche e terapeutiche.
ICR	Istituti e Centri di Riabilitazione	-
ICT	Information and Communication Technology	-
IEC	International Electrotechnical Commission	-
IOV	Istituto Oncologico Veneto	-
ISAC	Information Sharing & Analysis Centre	-
ISO	International Organization for Standardization	Sono un insieme di standard internazionali che forniscono linee guida, specifiche e requisiti su vari ambiti, come la qualità, l'ambiente, la sicurezza e la gestione delle risorse umane.
IVG	Interruzione volontaria di gravidanza	-
KARNOFSKY	Scala di Karnofsky	È uno strumento di valutazione che misura le capacità funzionali di un paziente e le sue condizioni generali.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	Sono un insieme di protocolli open usati per accedere alle informazioni conservate centralmente attraverso una rete.
LEA	Livelli Essenziali di Assistenza	Rappresentano le prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket.
MMG	Medico di Medicina Generale	-
NPI	Neuropsichiatria Infantile	-

Acronimo	Significato	Descrizione
NSIS	Nuovo Sistema Informativo Sanitario	Rappresenta l'infrastruttura informatica atta al supporto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quale raccoglie e centralizza i dati sui servizi sanitari e garantisce misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
OdC	Ospedale di Comunità	-
OSS	Operatore socio-sanitario	-
PAI	Piano Assistenziale Informatizzato	È un progetto documentato, compilato da una équipe multidisciplinare e garantito da un referente del piano che riassume la pianificazione assistenziale e gli obiettivi di promozione della salute che l'assistito dovrà ricevere e raggiungere in un determinato intervallo di tempo.
PMO	Project Management Office	È una struttura organizzativa interna che ha il compito di definire, mantenere e assicurare gli standard di gestione dei progetti all'interno di un'organizzazione.
PDTA	Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali	Sono uno strumento di gestione clinica per la definizione del processo assistenziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni di salute, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili sull'argomento, adattate al contesto locale.
PI	Piano Individuale	È un progetto personalizzato di intervento assistenziale.
PLS	Pediatra di Libera Scelta	-
PMBok	Project Management Body of Knowledge	È un insieme di standard, linee guida e pratiche comunemente accettate nel project management, pubblicato dal Project Management Institute.
PMIS	Project Management Information System	Consiste in una o più applicazioni software e un processo metodico per raccogliere e utilizzare le informazioni sul progetto.
PP	Parametrizzazione e Personalizzazione	Rappresenta il servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso.
PRI	Piano Riabilitativo Individuale	È un piano personalizzato che definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di intervento riabilitativo per una persona, volto a migliorare la sua autonomia, partecipazione sociale e qualità della vita.
PRINCE	PRojects IN Controlled Environments	È una metodologia di gestione, controllo e organizzazione dei progetti.
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	-
PSN	Polo Strategico Nazionale	Rappresenta l'infrastruttura cloud pubblica italiana che ospita i dati relativi ai servizi digitali strategici della Pubblica Amministrazione.
PSR	Piano Sanitario Regionale	-
PUA	Punto Unico di Accesso	-
RPD	Responsabile della Protezione dei Dati	È una figura prevista dal Regolamento (UE) 2016/679, designata dal titolare o dal responsabile del trattamento per sovrintendere all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Imprese	-
RSA	Residenze Sanitarie Assistenziali	-
SAL	Stato Avanzamento Lavori	-

Acronimo	Significato	Descrizione
SIAD	Sistema Informativo Assistenza Domiciliare	Rappresenta il flusso che raccoglie informazioni relative all'assistenza domiciliare ovvero al complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone presso il proprio domicilio.
SIAR	Sistema informativo Socio-Assistenziale e Riabilitativo	Rappresenta il flusso finalizzato alla raccolta dei dati relativi ai trattamenti socio-assistenziali e riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di recupero e mantenimento, erogati, nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale,
SICOF	Sistema informativo consultori familiari	Rappresenta il flusso che rileva le prestazioni consultoriali in ambito di assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie.
SIO	Sistema Informativo Ospedaliero	Rappresenta un unico Sistema Informativo Ospedaliero, ovvero un insieme di applicativi per la gestione delle attività cliniche, sanitarie e amministrative legate alle strutture ospedaliere.
SIOC	Sistema informativo Ospedali di Comunità	Rappresenta il flusso per il monitoraggio delle attività relative agli Ospedali di Comunità.
SISM	Sistema informativo Salute Mentale	Rappresenta il flusso relativo all'attività territoriale, residenziale e semiresidenziale, erogata all'assistito nell'ambito della salute mentale.
SI.Ter	Sistema Informativo Territoriale	-
SLA (LdS)	Service Level Agreement (Livelli di Servizio)	Sono strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio (es. qualità di servizio) che devono essere rispettate da un fornitore di servizi (provider) nei confronti dei propri clienti/utenti.
SPOC	Single Point of Contact	È una funzione o figura organizzativa designata a rappresentare l'unico canale ufficiale di comunicazione tra gli utenti (interni o esterni) e un'organizzazione, servizio o reparto specifico; ha il compito di ricevere, registrare, indirizzare e monitorare tutte le richieste, segnalazioni o comunicazioni.
S.Va.M.A.	Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano	È uno strumento utilizzato per valutare le condizioni sanitarie, socio-assistenziali e le abilità residue di una persona adulta/anziana, al fine di determinare i suoi bisogni assistenziali.
TS	Tessera Sanitaria	-
TTS	Trouble Ticketing System	È un sistema informatico utilizzato per la registrazione, il tracciamento, la gestione e la risoluzione di segnalazioni relative a guasti, malfunzionamenti, richieste di supporto tecnico o altri eventi anomali all'interno di un'infrastruttura IT o di telecomunicazioni.
ULSS	Unità Locale Socio-Sanitaria	-
UNI EN	Ente Italiano di Normazione Comitato Europeo di Normazione	La normativa UNI EN identifica un insieme di norme tecniche, applicate secondo la normativa Europea, che mirano a definire requisiti e standard comuni tra i paesi membri dell'Unione Europea.
U.O.	Unità Operativa	-
URT	Unità Riabilitativa Territoriale	-
UVMD	Unità di Valutazione Multidimensionale	È una struttura operativa del sistema sanitario territoriale che valuta le esigenze di una persona in particolari condizioni di bisogno sanitario, sociale, relazionale e ambientale, allo scopo di individuare interventi personalizzati e appropriati.

Acronimo	Significato	Descrizione
VAOR	Valutazione Anziano Ospite in Residenza	È uno strumento di valutazione multidimensionale utilizzato in Italia per valutare la salute e i bisogni degli anziani che vivono presso residenze sanitarie.
VMD	Valutazione multidimensionale	-
VPN	Virtual Private Network	-

2. ELEMENTI GENERALI DELL'INIZIATIVA

2.1. Contesto di riferimento

Il Sistema Sanitario Regionale, con l'obiettivo di mantenere un'organizzazione virtuosa, rivolge da sempre particolare attenzione all'aggiornamento di strumenti e modalità di programmazione sanitaria. A partire dal 2018, al vertice del governo del Sistema socio-sanitario veneto troviamo l'Area Sanità e Sociale, per la definizione di sistemi e procedure di coordinamento tra Area Sanità e Sociale e Azienda Zero, istituita nel 2016 (L.R. 25 ottobre 2016, n. 19), nell'ottica di garantire razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari regionali. L'Area Sanità e Sociale, attraverso i dati, le analisi, le informazioni e il supporto tecnico fornito da Azienda Zero, assume decisioni o propone provvedimenti, alla Giunta regionale. In questo contesto si riconosce l'importanza di tendere verso una "nuova sanità", passaggio possibile solo attraverso l'introduzione della digitalizzazione in modo trasversale a tutti i processi sanitari, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza e della produttività. Sono già state avviate molteplici progettualità a livello Regionale (come ad esempio il Sistema Informativo Ospedaliero unico) aventi tale finalità, le quali hanno come obiettivo parallelo l'armonizzazione ed omogeneizzazione dei prodotti e dei processi.

La presente iniziativa si colloca nel contesto di attuazione, da parte della Regione del Veneto, delle progettualità definite sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche PNRR).

Il PNRR stabilisce due obiettivi primari nell'ambito della missione 6 "Salute":

- la **missione M6C1** - Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l'assistenza territoriale: gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della Telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
- la **missione M6C2** - Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale: le misure incluse in questa componente hanno l'obiettivo di garantire il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti (con particolare attenzione alla digitalizzazione delle strutture sanitarie sede di Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello), il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci Sistemi Informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del Sistema Sanitario Nazionale (di seguito anche SSN) anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

L'attuazione della missione M6C1 intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario. Essa prevede due attività principali:

- la definizione di **standard strutturali, organizzativi e tecnologici** omogenei per l'assistenza territoriale e l'identificazione delle strutture a essa deputate;
- la **definizione di un nuovo assetto istituzionale** per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health".

In questo senso, costituiscono elementi chiave:

- la creazione delle **Case di Comunità** e degli **Ospedali di Comunità**;
- la diffusione della **Telemedicina**;
- il **potenziamento dei servizi domiciliari**.

L'iniziativa si inserisce all'interno di un percorso di transizione digitale per la Sanità Veneta, individuato non solo dal PNRR, ma anche all'interno del Piano Sanitario Regionale (PSR) che indica strategie e priorità di intervento per favorire una migliore governance del sistema, servizi più vicini a bisogni dei cittadini, ricerca e sviluppo per l'evoluzione del SSR e integrazione sociosanitaria. Nell'ambito del SSR sono state messe a punto un insieme di iniziative progettuali coerenti con le norme nazionali ed Europee e la strategia nazionale per la sanità digitale. In particolare, l'Amministrazione, come previsto dal PNRR "M6C1 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario" e come meglio specificato dal DM 77/2022 "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale", si è posta, tra gli altri, i seguenti obiettivi generali:

- la pianificazione, il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali, garantendo la condivisione e la disponibilità dei dati sanitari in maniera sicura e tempestiva, evitando duplicazioni e inconsistenza dei dati stessi;
- migliorare l'efficienza delle cure primarie attraverso l'integrazione in rete dei professionisti sanitari al fine di agevolare i processi di continuità assistenziale;
- supportare l'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito del territorio al fine di agevolare i processi di assistenza domiciliare, l'integrazione tra presidi, distretti e professionisti;
- l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di équipe multi-professionali che prendano in carico la persona in modo olistico, con particolare attenzione alle condizioni di maggiore fragilità.

Tali obiettivi sono stati perseguiti tramite:

- l'Implementazione dell'uso di soluzioni informatiche e tecnologiche all'avanguardia e conformi con le recenti linee di indirizzo fornite da AgID;
- la dematerializzazione dei processi e dei dati clinici, con un trattamento delle informazioni conforme alle normative vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
- la gestione della multidimensionalità dei percorsi assistenziali e di cura, specie in ambito territoriale, mediante un sistema in linea con l'approccio "Once Only" in grado di tracciare contemporaneamente, in modo organico, tutte le valenze e dimensioni che li compongono;
- la realizzazione di percorsi assistenziali e di cura sempre più interattivi e "patient-centered".

Nell'ambito della digitalizzazione del SSR Veneto sopra descritta, tra le priorità regionali si individuano quindi il miglioramento della presa in carico del paziente, l'efficientamento della gestione dei servizi e la promozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance

che agevoli la programmazione regionale dell'assistenza. In tale contesto, tramite la DGR n. 72 del 29/01/2024, la Regione del Veneto ha assegnato ad Azienda Zero un obiettivo relativo all'efficientamento dei processi amministrativi attraverso l'implementazione di sistemi informativi centralizzati. Tale obiettivo si declina nell'implementazione di un **Sistema Informativo Territoriale (SI.Ter)** che mira a colmare le carenze delle infrastrutture esistenti e superare l'organizzazione a silos dei servizi territoriali. Il progetto prevede infatti l'integrazione armoniosa dei nuovi sistemi con quelli già in essere, garantendo completa interoperabilità tra le attuali piattaforme ed eventualmente l'ammodernamento di alcuni servizi esistenti.

L'**assistenza territoriale nel contesto veneto** è articolata in **26 Distretti** che garantiscono i servizi di livello primario e costituiscono il polo di integrazione e coordinamento tra i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Inoltre, rivestono un ruolo fondamentale, in ottica sinergica con le attività erogate dal distretto, anche i servizi offerti dalla **rete ospedaliera** e dalle **reti regionali**. In tale contesto, il **potenziamento dei servizi offerti dall'assistenza territoriale**, in ottica di **digitalizzazione** e in coerenza con quanto previsto dal DM 77/2022, rappresenterà un obiettivo imprescindibile per poter garantire la prossimità delle cure e promuovere un modello uniforme di erogazione dei servizi.

L'iniziativa in oggetto è stata preceduta – nel 2024 - da un'attività di **ricognizione AS IS** dello stato dell'arte dei servizi e relativi applicativi adottati a livello territoriale, a cui è seguita la **pianificazione TO BE** orientata alla declinazione di un piano di intervento e strategie di attuazione future. Le due analisi hanno restituito un **quadro territoriale in trasformazione**, orientato alla **convergenza verso sistemi informativi uniformi**, funzionali alla **riduzione delle eterogeneità tra le Aziende** e al **rafforzamento della governance regionale**.

Le analisi AS IS e TO BE hanno permesso di evidenziare il livello di omogeneità dei Sistemi Informativi in uso nei singoli ambiti, come rappresentato nella figura di seguito riportata.

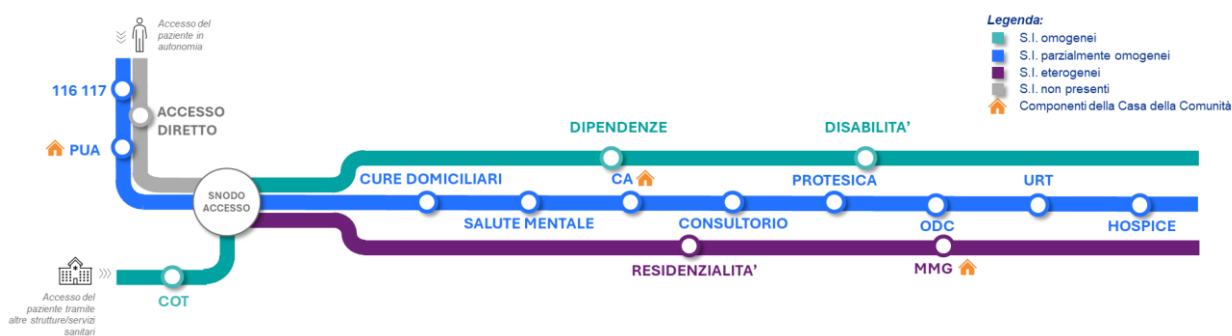


Figura 1 – Grado di uniformità dei Sistemi Informativi rilevato a novembre 2024

Le analisi condotte hanno consentito di delineare l'attuale livello di digitalizzazione del territorio, evidenziando gli ambiti in cui è necessario un ulteriore sforzo di omogeneizzazione.

La Regione del Veneto intende potenziare la copertura digitale dei seguenti ambiti:

- Centrale Operativa Territoriale (COT);
- Ospedale di Comunità (OdC);
- Unità Riabilitativa Territoriale (URT);

AZIENDA ZERO – Appalto Specifico ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della Regione Veneto – ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2365 - LOTTO 3 Capitolato Tecnico

- Centrale Operative 116117;
- Unità di Continuità Assistenziale (CA);
- Cure Domiciliari (Assistenza Domiciliare Integrata - ADI e Cure Palliative Domiciliari);
- Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie (in particolare Consultorio e Salute Mentale);
- Casa della Comunità (in particolare per il PUA – Punto Unico di Accesso);
- Telemedicina.

Come anticipato, nell'ambito dei progetti di trasformazione ed innovazione digitale del Sistema Sanitario, con la DGR n.72 del 29/01/2024 Regione del Veneto ha assegnato ad Azienda Zero l'obiettivo di realizzare una proposta di Sistema Informativo Territoriale regionale (SI.Ter), al fine di rendere possibile, agevole e veloce il dialogo tra sistemi informativi diversi per dare accesso e utilizzo, nella pratica, ai dati necessari alla programmazione e garantire una gestione efficiente ed efficace dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Pertanto, Azienda Zero - in sinergia con la strategia regionale - ha avviato la predisposizione della documentazione di gara per un rilancio competitivo rivolto agli aggiudicatari dell'accordo quadro Consip SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino" per Le Pubbliche Amministrazioni del SSN" - ID-2365 Lotto 3", mediante apposito Appalto Specifico per la stipula di un Contratto Esecutivo della durata massima di 48 mesi.

2.2. Obiettivi e contenuti dell'iniziativa

La presente iniziativa ha l'obiettivo di strutturare un progetto regionale per dotare gli Enti Sanitari (ES) di Regione del Veneto di un Sistema Informativo Territoriale (SI.Ter).

La diffusione del Sistema in tutto il territorio regionale rappresenta un elemento strategico e imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento della digitalizzazione previsti dal PNRR, per incrementare il patrimonio informativo regionale di ambito sanitario e per implementare i nuovi scenari di integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali e tra i singoli servizi territoriali.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di accelerare il processo di trasformazione digitale in ambito territoriale, favorire l'innalzamento della qualità dei servizi e ottimizzare i principali processi clinico-amministrativi. Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono i seguenti:

- implementare gradualmente una nuova architettura dei sistemi informativi regionali che superino l'attuale eccessivo frazionamento dei sistemi di livello locale e favoriscano l'interoperabilità e la valorizzazione dei dati in tutta la Regione;
- promuovere la completa e nativa digitalizzazione dei processi territoriali con eliminazione del supporto cartaceo e produzione di dati e documenti digitali originali a pieno valore legale;
- favorire l'ottimizzazione dei processi territoriali e abilitare una maggiore integrazione dei percorsi di cura e assistenza tra l'ambito territoriale e quello ospedaliero;
- supportare la progressiva standardizzazione dei processi territoriali a livello interaziendale e favorire l'adozione e l'ampia diffusione delle best practice;

- incrementare il livello di sicurezza dei processi territoriali e ridurre il più possibile il rischio per i pazienti in ambito territoriale;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni compiute in ottica di massima trasparenza e tutela per la sicurezza e la salute dei pazienti;
- abilitare lo scambio strutturato di dati tra le diverse organizzazioni in diversi contesti;
- abilitare e promuovere l'analisi strutturata dei dati raccolti durante i percorsi di cura dei pazienti nel territorio con l'utilizzo delle informazioni raccolte sia a livello locale sia regionale;
- condividere i dati di interesse regionale e nazionale in modo nativo e semplificato.

Il contesto regionale sopra descritto è caratterizzato da un'importante eterogeneità nella gestione dei percorsi di cura relativi ai diversi ambiti che compongono il territorio, nonché da notevoli differenze fra le aziende del SSR.

Emerge pertanto l'opportunità di migliorare l'efficienza e la qualità dell'assistenza socio-sanitaria, attraverso un lavoro volto alla promozione dell'omogeneizzazione sia dei processi che dei sistemi informativi in utilizzo negli ambiti chiave dell'assistenza territoriale. L'obiettivo è rendere possibile, agevole e veloce il dialogo tra sistemi informativi diversi per dare accesso e utilizzo, nella pratica, ai dati necessari alla programmazione e garantire una gestione efficiente dei servizi sociali e socio-sanitari.

L'obiettivo, a tendere, è quello di ottenere un unico sistema informativo per la gestione clinico-organizzativa dell'assistenza sul territorio, composto dai seguenti moduli integrati, in base all'ES di riferimento:

- per **tutte le Aziende ULSS**: moduli per **COT, Cure Domiciliari, URT, OdC, Hospice, Consultorio** (Consultorio, Minori, Età evolutiva, Neuropsichiatria Infantile, Affidi, ecc.), **Salute Mentale**;
- per le **Aziende Ospedaliere**: moduli per **Ospedale di Comunità, COT, Hospice e Salute Mentale**;
- per lo **IOV**, gli stessi moduli per **Ospedale di Comunità, COT e Hospice**.

È inoltre prevista la progettazione di **un sistema unico di monitoraggio**, nativamente integrato con i sistemi informativi del territorio, in grado di offrire una visione unitaria e condivisa dei dati territoriali attraverso un cruscotto intuitivo e accessibile. Il sistema dovrà inoltre permettere l'elaborazione di flussi e indicatori, in conformità ai nuovi tracciati e le nuove regole sui flussi informativi, derivanti dal progetto NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) nazionale.

La presente fornitura si articola quindi in 3 distinti interventi, per garantire il raggiungimento di quanto prefissato a livello Regionale:

- **intervento n°1**: Implementazioni moduli per la gestione clinico-gestionale della Riabilitazione Territoriale, dell'Ospedale di Comunità, del Consultorio e dell'Assistenza Domiciliare, e per la generazione dei relativi flussi informativi;
- **intervento n°2**: Completamento, diffusione, formazione, import dati dai precedenti applicativi, supporto di presidio locale e sviluppi evolutivi di tutti i moduli COT, ADI, OdC, URT, HOSPICE, CONSULTORIO, SALUTE MENTALE per tutte le Aziende;

- **intervento n°3:** Servizio di Help-Desk dedicato + Canoni di Manutenzione Ordinaria per tutti i moduli COT, ADI, OdC, URT, HOSPICE, CONSULTORIO, SALUTE MENTALE per tutte le Aziende.

La diffusione di questo ecosistema di applicativi a livello territoriale in tutte le strutture regionali rappresenta un elemento strategico e imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento della digitalizzazione previsti dal PNRR, per facilitare lo scambio di informazioni tra setting e professionisti all'interno della rete regionale, e in generale per incrementare il patrimonio informativo regionale sanitario e per implementare i nuovi scenari di integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali.

2.3. Estensione complessiva e orizzonte temporale dell'iniziativa

Il progetto è rivolto, con le modalità descritte nei Capitoli successivi, ai seguenti Enti Sanitari Veneti:

- Azienda ULSS 1 Dolomiti;
- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
- Azienda ULSS 3 Serenissima;
- Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;
- Azienda ULSS 5 Polesana;
- Azienda ULSS 6 Euganea;
- Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- Azienda ULSS 8 Berica;
- Azienda ULSS 9 Scaligera;
- Azienda Ospedale-Università di Padova;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- Istituto Oncologico Veneto (IOV).

La presente iniziativa, con le modalità descritte nei Capitoli successivi, prevede una durata complessiva indicativamente di 48 mesi, a partire dalla data di stipula del contratto della presente fornitura. In particolare:

- **intervento n°1:** 10 mesi;
- **intervento n°2:** 40 mesi;
- **intervento n°3:** 36 mesi più eventuale opzione di rinnovo di 12 mesi.

In dettaglio, si prevedono due milestone:

- il completamento della migrazione in cloud dei progetti multi-misura entro il 31/03/2026, come da Decreto n. 39/2025 – PNRR “Di approvazione del termine massimo per il completamento dei progetti dei Soggetti Attuatori finanziati dagli Avvisi a lump sum pubblicati a valere sulle misure della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale” del 14/02/2025;
- la conclusione delle iniziative relative ai flussi NSIS prevista al 30/06/2026, come da milestone PNRR M6C2 | 1.3.2.2.1 “Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale”.

AZIENDA_ZERO – Appalto Specifico ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della Regione Veneto – ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2365 - LOTTO 3 Capitolato Tecnico

Il raggiungimento delle milestone di progetto di sopra potrà essere conseguito attraverso uno dei tre percorsi alternativi che verrà definito dal Committente:

- avvio progressivo per ES, secondo una sequenza predefinita dal Committente, che prevede l'attivazione completa dei sistemi per ciascun ES prima di procedere con l'avvio della successiva;
- avvio per moduli, con l'attivazione simultanea del medesimo modulo presso tutti gli ES coinvolti, e successiva estensione agli altri moduli, adottando il medesimo approccio sequenziale;
- avvio in modalità "ibrida", con la possibilità sia di attivare un singolo modulo in simultanea presso tutti o parte degli ES, sia di definire l'attivazione progressiva di più moduli nello stesso ES, in base alle necessità.

2.4. Modello di approvvigionamento ed Enti sanitari interessati

Azienda Zero, in attuazione dell'incarico conferitole dalla **Regione del Veneto** con **Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 29/01/2024**, ha avviato le attività propedeutiche all'attivazione dell'iniziativa oggetto del presente capitolato, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione da **Consip**, ed in particolare dell'**Accordo Quadro CONSIP "Servizi applicativi in ambito SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino"**, destinato alle Pubbliche Amministrazioni del **Servizio Sanitario Nazionale**. L'attuazione avverrà tramite un **Appalto Specifico**, finalizzato alla stipula di un **Contratto Esecutivo** della durata massima di **48 mesi**.

Al paragrafo 2.3 sono riportati gli ES interessati alla Fornitura all'interno della procedura regionale.

L'impianto contrattuale con il fornitore individuato sarà organizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Consip e conseguente sottoscrizione di un contratto esecutivo con Azienda Zero.

Si evidenzia che per l'Intervento n°1 ("Implementazioni moduli per la gestione clinico-gestionale della Riabilitazione Territoriale, dell'Ospedale di Comunità, del Consultorio e dell'Assistenza Domiciliare, e per la generazione dei relativi flussi informativi"), in riferimento alla Scheda "Progetto regionale di sviluppo del Sistema Informativo Territoriale, a favore di tutte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto", trasmessa alla Commissione Regionale per gli Investimenti Tecnologici ed in Edilizia in data 14/05/2025, è previsto il ricorso a finanziamento PNRR relativo alla Missione M6 C2 I1.3.2.2.1 "Adozione da parte delle regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali (consultori di famiglia, ospedali di comunità, servizi di riabilitazione territoriale e servizi di cure primarie)".

3. OGGETTO DELLA FORNITURA

La Fornitura comprende quanto necessario per diffondere, gestire e mantenere una soluzione applicativa di Sistema Informativo Territoriale (SI.Ter) basata su un'unica piattaforma tecnologica estesa a livello aziendale nei diversi reparti e servizi attivi sul territorio. In particolare, il modello proposto prevede l'introduzione di un sistema tecnologico che garantisca il supporto funzionale alle attività svolte, in logica integrata, nei seguenti ambiti:

- **Centrale Operativa Territoriale (COT)**, servizio territoriale attivo in ogni Azienda ULSS con l'obiettivo di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. L'attività della COT non è di tipo front-office per il cittadino, ma è rivolta a tutti gli attori del sistema sanitario che possono richiederne l'intervento: medici ospedalieri, MMG/PLS, infermieri, professionisti presenti nei servizi aziendali e distrettuali nonché personale delle strutture di ricovero intermedie, residenziali e semiresidenziali. La COT svolge un ruolo di raccordo tra i vari servizi attraverso funzioni distinte e specifiche, seppur tra loro interdipendenti, mettendo in atto percorsi di presa in carico del paziente nella sua totalità. Per gestire le transizioni di un paziente da un setting all'altro, la COT prenderà in carico la segnalazione di dimissione protetta espressa dal setting (U.O) responsabile del caso, anche definito **setting inviante**, contattando ed attivando il servizio necessario alla definizione del setting definitivo o di destinazione, definito anche setting ricevente.
- **Strutture di Ricovero a Carattere Intermedio**, ovvero strutture intermedie destinate ad accogliere temporaneamente i pazienti che non possono essere assistiti a domicilio e per i quali risulti improprio il ricovero ospedaliero, il suo prolungamento o l'istituzionalizzazione. Esse garantiscono le cure necessarie a quei pazienti con un basso margine di imprevedibilità e/o instabilità clinica, che non richiedono assistenza ospedaliera, ma sono troppo instabili per poter essere trattati in un semplice regime ambulatoriale o residenziale classico e che trattano problemi che si risolvono in un periodo limitato di tempo. Nello specifico, rientra nell'ambito della presente iniziativa progettuale l'informatizzazione delle seguenti tipologie di strutture di ricovero a carattere intermedio:
 - **Ospedali di Comunità (ODC)**, strutture di ricovero breve che afferiscono al livello essenziale di assistenza territoriale, rivolte a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minori o per riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che vengono ricoverati in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare) e necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio. Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, in proposito, indica nell'Ospedale di Comunità (Country Hospital): *"la struttura dedicata all'attuazione delle cure domiciliari in ambiente protetto ovvero al consolidamento delle condizioni fisiche o alla prosecuzione del processo di recupero in ambiente non ospedaliero di dimessi da unità per acuti o post-acuti - lo strumento di sviluppo delle cure intermedie, intese come punto di raccordo fra cure primarie e cure ospedaliere"*.
 - **Unità Riabilitative Territoriali (URT)**, strutture di degenze il cui servizio è rivolto a persone con disabilità (prevalentemente ortopedica o neurologica) che abbiano superato la fase acuta della loro malattia. L'obiettivo è quello di ottenere per la persona e la sua famiglia la

qualità di vita migliore possibile, attraverso interventi riabilitativi, assistenziali ed educativi. Accedono all'Unità Riabilitativa Territoriale le persone che: hanno temporaneamente perso alcune funzioni (ad esempio: frattura di femore, politraumatismi o postumi di intervento ortopedico) che possono essere del tutto o in parte recuperate con interventi riabilitativi; hanno già effettuato una riabilitazione intensiva (ad esempio a seguito di un ictus) e che necessitano di proseguire il trattamento; sono affette da malattie evolutive (SLA, Parkinson, Sclerosi Multipla stabilizzata) con gravi disabilità che necessitano di un periodo di riabilitazione e/o adattamento a nuovi ausili.

- **Hospice**, strutture di degenza nate per rispondere ai bisogni assistenziali, clinici, psicologici e spirituali del malato in fase avanzata e terminale e per offrire sostegno ai suoi familiari. Obiettivo dell'Hospice è quindi quello di garantire un'assistenza globale al malato, personalizzando il suo percorso di presa in carico clinico-assistenziale in modo da assicurargli la migliore qualità di vita possibile nel rispetto della sua dignità.
- **Cure Domiciliari**: sono un servizio a valenza distrettuale rivolto all'erogazione a domicilio di interventi multiprofessionali caratterizzati da un livello di intensità di cure e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza; si articolano in cure domiciliare di base, ADI e cure palliative in età adulta e pediatrica.
 - **Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)**, ovvero un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali rese a domicilio del paziente, secondo piani individuali programmati di assistenza definiti con la partecipazione delle figure professionali interessate al singolo caso. Il medico di medicina generale/pediatra è il punto di riferimento primario per le esigenze sanitarie dell'anziano non autosufficiente e a lui competono le decisioni in ordine agli interventi terapeutici a domicilio. L'obiettivo generale dell'ADI è quello di favorire l'autonomia della persona non autosufficiente, mantenendola nel proprio ambiente di vita, facendosi carico del processo di recupero di tale autonomia e migliorando la disponibilità all'assistenza da parte dei familiari. Gli obiettivi dell'ADI sono molteplici:
 - evitare i rischi di isolamento sociale e di impoverimento della qualità di vita della persona;
 - ottenere un elevato livello di integrazione con i servizi già operanti, al fine di ottimizzare le risorse e aumentare la qualità;
 - ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali;
 - favorire la deospedalizzazione, al fine di evitare i gravi effetti negativi che si producono con una prolungata degenza ospedaliera.
 - **Cure Palliative Domiciliari (CP)**, di cui alla Legge n. 38 del 15 marzo 2010, sono garantite dal SSN, nell'ambito della Rete Locale di Cure Palliative (RLCP) a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle UCPDOM. I profili di cura attivati e la conseguente intensità assistenziale variano a seconda della complessità dei sintomi e dei bisogni delle persone assistite (cure palliative domiciliari di base e specialistiche).

- **Consultori Familiari (IAF)**, ovvero servizi socio-sanitari rivolti al singolo paziente, alla coppia e/o al nucleo familiare dove è possibile affrontare le tematiche che riguardano la vita affettiva, sessuale e relazionale, la procreazione responsabile, la maternità e la paternità, la genitorialità, la tutela della salute della donna, la consulenza preconcezionale, la prevenzione dei disturbi dell'apparato genitale femminile, il climaterio e l'interruzione volontaria di gravidanza. I servizi di consultorio dedicano particolare attenzione all'intervento rivolto a fasi cruciali o a situazioni di vita particolarmente conflittuali quali separazione e divorzio, violenza/maltrattamento. Per quanto riguarda la salute della donna, tenuto conto delle linee guida (All. A - Dgr. n. 215/2010), i Consultori Familiari offrono percorsi assistenziali legati al ciclo riproduttivo femminile dai 21 ai 64 anni, e dai 18 anni per la gravidanza e l'interruzione volontaria gravidanza (IVG).
- **Centro di Salute Mentale (CSM)**, ovvero il centro operativo e organizzativo del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) che coordina e svolge, per specifico ambito territoriale, le funzioni di tutela della Salute Mentale. I CSM garantiscono inoltre la funzione di coordinamento e di raccordo con gli altri servizi sanitari e sociosanitari che si occupano di Salute Mentale nel territorio e nell'Ospedale, attraverso la definizione di percorsi di cura integrati. Il Centro di Salute Mentale è la sede organizzativa dell'équipe degli operatori e la sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite anche l'integrazione funzionale con le attività dei distretti.
In particolare, il CSM svolge:
 - attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica;
 - definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell'approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di "rete", ed eventualmente anche residenziali, nella strategia della continuità terapeutica;
 - attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici ed attività formativa;
 - consulenza specialistica ai servizi "di confine", alle strutture residenziali per anziani e per disabili;
 - attività di prevenzione e promozione della salute mentale;
 - valutazione ai fini del miglioramento continuo di qualità delle pratiche e delle procedure adottate.
- **Prescrizione Elettronica**, sistema informatico per la prescrizione di ricette dematerializzate farmaceutiche e specialistiche in conformità alla normativa vigente (DM 2 novembre 2011 avente ad oggetto la dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)).

3.1. Descrizione del sistema

La soluzione applicativa richiesta dev'essere in grado di fornire e gestire il Sistema Informativo Territoriale (SI.Ter), nelle sue componenti applicative individuate al Capitolo 4, per tutti gli enti sanitari (ES) coinvolti operanti sul territorio regionale. Il sistema fornito dall'Aggiudicatario dovrà costituire una piattaforma tecnologica multi-servizio che permetta di svolgere tutte le attività che

rientrano negli ambiti clinico-sanitari menzionati all'inizio di questa sezione. Il sistema offerto dovrà essere caratterizzato da:

- gestione di istanze multi-Azienda e/o multi-Distretto (cd. *multitenancy*, ovvero capacità di gestire i domini dei singoli ES su un'infrastruttura comune, in una logica multi-organizzazione in cui è sempre garantita la segregazione logica dei dati di pertinenza di ciascun ES);
- aderenza alle normative regionali e nazionali, nonché alle evoluzioni delle stesse che si presenteranno nel periodo di validità del servizio (fino al termine contrattuale);
- applicazione della normativa privacy nazionale e del regolamento Europeo sulla protezione dei dati (2016/679) e delle relative evoluzioni che si presenteranno nel periodo di validità del servizio (fino al termine contrattuale);
- integrazione con i sistemi nazionali, regionali e aziendali come descritto nel Capitolo Integrazioni.

La Fornitura dovrà prevedere un'infrastruttura *cloud based* e *multitenant*, al fine di raggiungere il seguente stato di informatizzazione e digitalizzazione del territorio:

Tabella 2 - Stato di informatizzazione e digitalizzazione a tendere per i moduli del sistema

MODULO	ULSS 1	ULSS 2	ULSS 3	ULSS 4	ULSS 5	ULSS 6	ULSS 7	ULSS 8	ULSS 9	IOV	AOPD	AOVR
COT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X*	X*
ODC URT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HOSPICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CURE DOMICILIARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
CONSULTORI	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
CSM	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
PRESCRIZIONE ELETTRONICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Almeno per la componente di ammissione e dimissione protetta

Si specifica che l'infrastruttura *cloud* per la distribuzione delle applicazioni *software* oggetto della presente iniziativa, è individuata prioritariamente nel PSN, oppure in altra piattaforma cloud messa a disposizione dal Committente, secondo logiche orientate ai paradigmi della gestione a microsistemi e della *multitenancy*, in modo da consentire la segregazione logica dei dati di appartenenza dei diversi domini sanitari.

Il servizio deve garantire elevati livelli di sicurezza per la protezione dei dati e dei sistemi contro eventuali tentativi di violazione non autorizzati. Devono essere previsti sistemi di monitoraggio e alerting, affinché l'Aggiudicatario stesso notifichi al Committente, e quindi all'autorità competente, violazioni o Data Breach.

Devono essere adottati tutti quei sistemi e attività periodiche necessarie a garantire un'elevata sicurezza dei dati.

Devono essere previste frequenti azioni periodiche di *ethical hacking* e *penetration test* con le susseguenti attività correttive, comprovate dalla produzione dei documenti di risultato forniti al Committente.

Devono inoltre essere sempre fornite almeno le documentazioni previste dalla normativa e dalle circolari regionali o nazionali (ad esempio misure minime di sicurezza AgID da trasmettere a CERT-PA).

I livelli minimi di servizio sono descritti nel Capitolo 10 “Livelli di servizio”.

Devono essere previsti servizi di backup e restore dati che garantiscano la gestione delle procedure di salvataggio e di ripristino oggetto del servizio. L'erogazione può avvenire sia in modalità online, sia in modalità batch. L'utilizzo di tale servizio, considerata l'alta affidabilità insita nel paradigma di cloud, può ritenersi utile nel caso di errori da parte di operatori o amministratori.

I Concorrenti devono elaborare e proporre un progetto di fornitura e gestione del SI.Ter, predisposto in modo coerente alle installazioni locali e alla relativa connettività presente, in modo da garantire elevata affidabilità e riduzione al minimo di eventuali disservizi operativi rispetto a tutte le funzionalità necessarie all'esecuzione del servizio.

A partire dalla mappatura effettuata per ciascun ES in merito a:

- connettività garantita internamente e verso l'esterno;
- tipologia di attività clinico/assistenziale effettuata.

Le ditte Concorrenti devono presentare una proposta di progetto che massimizzi la continuità operativa, ottimizzandone le soluzioni infrastrutturali.

Più specificatamente, la Fornitura, dovrà svolgere le seguenti attività:

- realizzazione, personalizzazione, implementazione e collaudo dei moduli che compongono il Sistema Informativo Territoriale;
- diffusione del sistema;
- conduzione applicativa e infrastrutturale;
- manutenzione Evolutiva (MEV) del sistema;
- manutenzione ordinaria del sistema.

Sono parte integrante della Fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attività di project management, delivery, assistenza necessarie alla realizzazione ed erogazione delle componenti principali del sistema per la gestione del SI.Ter presso gli ES.

Le caratteristiche degli elementi di Fornitura sono dettagliatamente descritte nei Capitoli successivi.

Il sistema deve comprendere quanto necessario per diffondere, gestire e mantenere una soluzione applicativa regionale per la digitalizzazione degli ambiti oggetto della fornitura e per la condivisione degli stessi.

4. REQUISITI FUNZIONALI

Nel presente Capitolo si descrivono le caratteristiche della soluzione applicativa e le caratteristiche della struttura organizzativa di supporto al Sistema Informativo Territoriale.

Nello specifico, nel presente Capitolo sono riportati, per ognuno dei seguenti *moduli funzionali*, i requisiti che il Sistema Informativo Territoriale dovrà soddisfare.

Il sistema proposto dovrà rispettare tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, compresi gli accordi Stato Regioni e le linee di indirizzo regionali.

Tutte le interfacce software dovranno essere disponibili in lingua italiana.

Il sistema deve essere strutturato in una logica di *business workflow*, con la possibilità di implementare campi obbligatori e sistemi di controllo relativamente alla gestione dei processi (ad esempio la possibilità di creare un referto solo se compilate alcune sezioni). Queste parametrizzazioni devono essere attuabili direttamente da personale “amministratore” adeguatamente formato, ovvero senza ricorrere a sviluppi o contattare il Fornitore.

Il sistema dovrà prevedere la possibilità di utilizzare la firma elettronica digitale in modalità remota attraverso il sistema di firma in uso presso l'ES.

L'elenco delle funzionalità non è da ritenersi esaustivo.

A seguire sono evidenziati ulteriori requisiti funzionali minimi nel dettaglio.

Il sistema proposto dovrà essere *compliant* con le migliori best practices previste a livello nazionale e internazionale e alle linee guida FSE.

Il sistema dovrà, inoltre, supportare l'operatività dei singoli ambiti oggetto di fornitura, al fine perseguire quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (Ministero della Salute).

4.1. Generazione di documenti

La modulistica e le stampe prodotte in tutte le aree applicative della fornitura (a livello aziendale, sovraaziendale e regionale) devono avere intestazioni (quali ad esempio la denominazione e il logo dell'Ente Sanitario e della specifica struttura) personalizzabili.

Le stampe e i report prodotti dal sistema devono prevedere meccanismi atti a garantire la stampa per intero dei campi inseriti nei template di stampa. Non devono cioè essere possibili stampe mancanti di parti, rispetto alle informazioni dei campi compilate a video. Relativamente alla reportistica e alla gestione di dati ai fini di rendicontazione e analisi a livello di Servizio/U.O. e sovra-articolazioni, i report e gli elenchi disponibili nei diversi moduli devono poter essere esportati verso i più comuni strumenti di elaborazione individuale (ad esempio excel, formati .csv, .odf, etc.), e deve essere garantita la possibilità di definire calcoli automatici di indicatori di dettaglio e generici (ad esempio per scale di valutazione).

In particolare, il sistema dovrà consentire all'Amministratore regionale e agli operatori aziendali, di:

- tramite idonei strumenti, di cui la fornitura dovrà essere dotata, costruire interrogazioni al sistema ed estrazioni tramite i principali formati di rappresentazione delle informazioni (es. fogli di calcolo);
- esportare porzioni di data base per analisi con strumenti esterni al sistema;
- a tal fine dovrà essere fornita informazione completa e dettagliata sulla struttura dei dati e sul loro significato al fine di rendere possibile un autonomo livello di elaborazione ma non di modifica.

Dovranno essere garantite le seguenti funzioni minime:

- esistenza di criteri di selezione, basati su tutti i tipi di informazioni registrate, per la ricerca delle informazioni del sistema (a titolo di esempio: selezione per specifico periodo di riferimento);
- possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate, con creazione di reportistica specifica assicurata attraverso l'esportazione di dati;
- generazione dei report che verranno definiti e condivisi, laddove necessario, con il livello regionale.

4.2. Fruibilità dati storici

Per quanto riguarda la gestione dello storico, i sistemi devono permettere la storicizzazione (versioning e gestione di addenda) dei dati e dei relativi output prodotti (report, stampe, documenti firmati e non) e garantire l'accesso e la visibilità dei dati storicizzati a tutte le tipologie di operatori abilitati. Lo storico potrebbe essere importato in step a seconda le necessità dei singoli ES. Nell'avviamento dovrà essere compresa la migrazione dello storico e del patrimonio informativo. Dovrà essere premesso l'importazione dello storico importando non solo pdf ma fornendo dati strutturati. Il sistema deve comunque essere dotato di funzionalità di interrogazione dati e produzione reportistica (in formati .txt, .csv, .pdf, etc.) per le esigenze dei diversi utilizzatori.

Il fornitore dovrà predisporre delle apposite interfacce per l'importazione del dato storico dagli applicativi uscenti, tramite tool applicativi o mettendo a disposizione un tracciato record che definisca la semantica necessaria all'importazione, entro 3 mesi dalla data del collaudo. Lo strumento di import dei dati sarà un servizio incluso nella presente fornitura, mentre tutte le attività di export e bonifica dei dati saranno a carico degli Enti Sanitari.

4.4. Flussi informativi e produzione del debito informativo

In questo paragrafo si descrivono i requisiti tecnico-funzionali mandatori che l'Aggiudicatario dovrà garantire per quanto concerne la produzione, da parte dei moduli oggetto di fornitura, dei flussi informativi di interesse per le diverse aree funzionali oggetto della presente iniziativa.

Tali strumenti di raccolta e misurazione dati rispondono ad una molteplicità di esigenze:

- misurare più efficacemente i servizi offerti secondo gli standard assistenziali e la loro qualità;
- agevolare la programmazione futura sulla base dei dati epidemiologici della popolazione, del fabbisogno e dell'offerta;
- monitorare periodicamente l'efficienza della rete di offerta;

- consentire periodiche elaborazioni e trasmissioni di dati a livello ministeriale, agli organi regionali ed agli stakeholder.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'implementazione dei flussi informativi di pertinenza degli applicativi oggetto del presente capitolato in ottemperanza alle linee guida regionali e ministeriali vigenti in materia. Dovrà inoltre assicurare l'aggiornamento dei flussi in base ad eventuali modifiche e/o variazioni normative. L'aggiudicatario dovrà infine provvedere all'integrazione di eventuali nuovi flussi introdotti dalla normativa vigente o futura (ad esempio il flusso "NPI" - Neuropsichiatria Infantile).

Per ciascun modulo, il sistema proposto dovrà consentire all'operatore in possesso di determinati privilegi amministrativi di accedere ad un'area riservata da cui produrre ed estrarre i dati del flusso di pertinenza per il periodo temporale di interesse.

Per ciascun modulo, il sistema proposto dovrà inoltre prevedere un sistema di controlli di qualità del flusso in fase di generazione dello stesso, che comprendano verifiche di tipo logico e formale secondo le specifiche tecniche del flusso stesso, ad esempio una valutazione per ciascuna variabile dell'appartenenza dei dati al dominio previsto.

Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi dei principali flussi informativi, distinti per area funzionale di interesse, che il sistema fornito dall'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di Azienda Zero e degli ES.

4.4.1. SIAD

Il flusso informativo SIAD (Sistema Informativo Assistenza Domiciliare), istituito con il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2008, è uno strumento per la raccolta, monitoraggio ed analisi dei dati relativi all'assistenza domiciliare, ovvero il complesso integrato di procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone presso il proprio domicilio, con presa in carico di diversi livelli di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale.

I principali riferimenti normativi relativi all'istituzione ed evoluzione del flusso informativo SIAD sono i seguenti:

- Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2008;
- Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023, Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante: «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare»;
- Regione Veneto: Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2372 del 29 dicembre 2011 "Flusso Informativo Assistenza e Cure Domiciliari: approvazione dei relativi progetti e collaborazione con l'Azienda ULSS 4 nelle fasi di gestione";
- Regione Veneto: Aggiornamento disciplinare tecnico v. 3 - Aprile 2025 e aggiornamento Tracciato Flusso informativo cure e assistenza domiciliare – Maggio 2025.

4.4.2. ODC-URT

Il flusso informativo ODC (Ospedali di Comunità) Unità Riabilitative Territoriali (URT) è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2683 del 29 dicembre 2014. Per quanto riguarda il

flusso ODC, è in previsione l'adozione del flusso SIOC, per il quale la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguamento.

I riferimenti normativi relativi all'istituzione del flusso informativo ODC-URT sono i seguenti:

- Regione Veneto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2683 del 29 dicembre 2014;
- Regione Veneto: Decreto n.1 del 10 ottobre 2016 del responsabile dell'Unità Organizzativa Strutture Intermedie e Sociosanitarie Territoriali – Sistema Informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso l'ODC e l'URT. DGR 2683/2014. Approvazione del documento tecnico.

4.4.3. SIAR

Il flusso informativo SIAR (Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa), istituito con Decreto del Ministero della salute del 7 agosto 2023, è finalizzato alla raccolta, monitoraggio ed analisi delle informazioni relative ai trattamenti riabilitativi, presa in carico e piano individuale di assistenza e riabilitazione.

I principali riferimenti normativi e tecnici relativi all'istituzione del flusso SIAR sono i seguenti:

- Decreto del Ministero della salute del 7 agosto 2023;
- Specifiche funzionali Sistema Informativo Assistenza Riabilitativa (SIAR) - (PNRR – obiettivo M6C2 – sub-investimento 1.3.2.2.1) - Versione 2.5 - Aprile 2024.
- Regione Veneto – Decreto del Direttore Generale dell'area sanità e sociale n.123 del 28 settembre 2023 - PNRR Missione 6, Componente 2, l'Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria". Adozione del flusso informativo sanitario SIAR.

4.4.4. Hospice

Il flusso informativo Hospice, istituito con Decreto Ministeriale del 6 giugno 2012, è finalizzato alla raccolta, monitoraggio ed analisi delle informazioni relative all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice.

I principali riferimenti normativi e tecnici relativi all'istituzione del flusso informativo Hospice sono i seguenti:

- Ministero della Salute - Decreto 6 giugno 2012 – Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice;
- Ministero della Salute - Specifiche funzionali dei tracciati Hospice – Maggio 2018 – Versione 2.1
- Regione Veneto – Deliberazione della Giunta Regionale n. 2851 del 28/12/2012 - Istituzione del Flusso Informativo per il Monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice e modifica della Scheda per la valutazione di accessibilità all'Hospice (DGR 3318/2008).

4.4.5. SISM

Il flusso informativo SISM (Sistema Informativo per la salute mentale), istituito con Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2010, è finalizzato alla raccolta, monitoraggio ed analisi delle informazioni relative agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati nell'ambito dell'assistenza rivolta a persone adulte con problemi psichiatrici e alle loro famiglie, ad esclusione della neuropsichiatria infantile.

I principali riferimenti normativi e tecnici relativi all'istituzione del flusso informativo SISM sono i seguenti:

- Ministero della Salute - Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2010;
- Ministero della Salute – SISM Specifiche funzionali - Versione 2.9 Gennaio 2021;
- Ministero della Salute – MANUALE OPERATIVO Sistema Informativo Salute Mentale - Giugno 2018;
- Regione Veneto – Decreto n. 129 del 22 dicembre 2022 – Disciplinare tecnico Flusso Sistema Informativo Salute Mentale (SISM).

4.4.6. SICOF

Il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) è stato istituito con Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023 ed è finalizzato alla raccolta, monitoraggio ed analisi delle informazioni prestazioni consultoriali previste dall'articolo 24 «Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie» DPCM 12 gennaio 2017.

I principali riferimenti normativi e tecnici relativi all'istituzione del flusso informativo SICOF sono i seguenti:

- Ministero della Salute - Decreto del 7 agosto 2023;
- Ministero della Salute – Specifiche funzionali – Versione 2.0 Ottobre 2023;
- Regione Veneto – Decreto n. 127 del 29 settembre 2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale - PNRR Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria". Adozione del flusso informativo sanitario SICOF.

4.4.7. ICR

Il flusso ICR (Istituti e Centri di Riabilitazione) consiste nella raccolta, monitoraggio ed analisi delle informazioni relative all'attività svolta dagli Istituti e Centri di Riabilitazione ex art. 26 legge 833/78.

Il principale riferimento normativo e tecnico relativo all'istituzione del flusso informativo ICR è la notadi Regione Veneto prot. n. 27767/50.07.51 del 10 giugno 2003.

4.4.8. COT

Il flusso informativo COT (Centrale Operativa Territoriale) consiste nella raccolta, monitoraggio ed analisi delle informazioni relative all'attività erogata dalle Centrali Operative Territoriali.

I riferimenti normativi e tecnici relativi all'istituzione del flusso informativo COT sono i seguenti:

- Regione Veneto – Decreto n. 3 del 14 aprile 2025 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale - Adozione in via sperimentale nelle Aziende ULSS del "Flusso informativo Centrale Operativa Territoriale".
- Regione Veneto - Nota prot. n. 27494 del 9 giugno 2025. DDR 3/2025. Adozione in via sperimentale nelle Aziende ULSS del "Flusso informativo Centrale Operativa Territoriale", rif. nota reg. prot. n. 191174 del 14/04/2025. Invio documenti aggiornati e comunicazione scadenza trasmissione.

4.5. Auditing

I sistemi oggetto di gara devono essere in grado di gestire il logging delle operazioni, secondo quanto previsto dall'infrastruttura di sicurezza e di auditing regionale. I servizi previsti dall'architettura regionale sono compliant con il profilo ATNA Secure Node per lo storing dei dati di audit. Il sistema deve prevedere la raccolta centralizzata, attraverso strumenti adeguati, della completa tracciabilità delle operazioni effettuate (visualizzazione, inserimento, modifica, annullamento, etc.), al fine di poter rendere fruibili tutte le operazioni eseguite in ogni momento attraverso un'interfaccia adeguata disponibile all'operatore autorizzato. Si evidenzia, in particolare, che deve essere prevista la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di visualizzazione dei dati (per soddisfare alle richieste di chi e da quale terminale ha visualizzato determinati dati). La registrazione dei log deve avvenire tramite soluzioni di hashing, firma e marca temporale, al fine di garantire a terzi l'immodificabilità nel tempo, e possa, a tutti gli effetti, dare evidenza legale.

La tracciabilità delle operazioni deve essere sempre ricostruibile mantenendo inalterata la sua consultazione nel tempo.

Le informazioni minime (non esaustive) devono essere:

- operatore (ID-operatore);
- generalità operatore;
- timestamp;
- tipo operazione (lettura, inserimento, modifica, cancellazione logica, etc.);
- tipologia di operazione;
- dato trattato;
- causale dell'accesso (se l'assistito non è in carico dell'operatore).

I sistemi offerti devono pertanto essere progettati affinché la registrazione di tutte le operazioni non impatti sulle performance, attraverso soluzioni innovative e avanzate. Quanto sopra espresso deve essere garantito anche per gli operatori amministratori di sistema, di database, di sistema

operativo, al fine di garantire al Committente che le modifiche ai sistemi siano sempre documentate.

4.6. Dizionari, Cataloghi, Codifiche

Si definiscono Cataloghi o Dizionari tutti gli elenchi che compongono le informazioni codificate utilizzabili da tutte le funzionalità in fornitura, cioè gli elenchi a cui gli operatori fanno riferimento.

Il sistema dovrà includere la possibilità di gestire i cataloghi regionali, prevedendo l'integrazione con eventuali sistemi regionali dedicati alla gestione delle codifiche.

Di seguito di riporta un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestazioni con associazione codifica CVP;
- nomenclatore e tariffario nazionale (per le prestazioni extra CVP);
- altre prestazioni aziendali;
- centri di costo;
- centri di responsabilità;
- codici struttura (HSP11 bis, STS etc.);
- strutture eroganti (unità di offerta, unità operative);
- strutture di contatto;
- esenzioni regionali delle altre Regioni;
- esenzioni nazionali e relative correlazioni con codici ministeriali;
- Comuni e stati esteri;
- Enti Sanitari e relazione Enti Sanitari/Comuni;
- regimi e convenzioni di erogazione;
- listini comuni (ad esempio medicina legale, veterinaria, etc.);
- listini specifici (ad esempio convenzioni, libera professione, etc.);
- correlazione tra esenzioni e regimi di erogazione;
- catalogo dell’Affinity Domain XDS;
- correlazione tra profili/pacchetti di prestazioni richiedibili e interventi/procedure
- quesiti diagnostici codificati;
- definizione dell’organizzazione delle strutture dal punto di vista gerarchico (ad esempio dipartimento strutturale, funzionale, interaziendale, U.O., etc.) e funzionale

Il sistema deve prevedere un’interfaccia grafica con soluzioni di wizard avanzate per le codifiche non previste a livello regionale:

- per le operazioni di consultazione, inserimento, modifica e cancellazione logica;
- per le operazioni di import/export massivo di codifiche mediante tracciati definiti (per codifiche periodicamente aggiornate da enti esterni, medici di base, comuni, Enti Sanitari, etc.).

Di tutte le voci afferenti ai dizionari deve essere gestito il “versioning” (data inizio e data fine validità, con periodo di validità impostato anche per il futuro). In tal modo, si può ad esempio gestire il riutilizzo di codifiche diverse nel tempo, oppure prevedere l’applicazione futura di nuovi regimi tariffari già pre-configurati.

4.7. Autenticazione

L'accesso al sistema, alle funzionalità e ai dati deve avvenire secondo modalità che ne tutelino la sicurezza, in termini di riservatezza, di tutela della privacy, di protezione nei confronti di accesso fraudolento o anche solo accidentale da parte di persone non autorizzate, in linea con la normativa nazionale vigente D.Lgs. 196/2003 e con il regolamento Europeo sulla protezione dei dati (2016/679), e relative modifiche e integrazioni (D.Lgs. 101/2018 e successivi).

Il sistema deve permettere l'utilizzo dei servizi web di autenticazione esposti dagli attori Identity and Assertion Provider (IAP) dei singoli ES in accordo alle specifiche "GDL-O Sicurezza Infrastruttura di Sicurezza" e al documento di specifiche di integrazione relative ad APMS (facendo riferimento all'ultima versione disponibile).

Deve essere possibile effettuare velocemente il cambio di sessione operatore e del contesto di operatività all'autenticazione. Maggiori dettagli in merito verranno forniti nel Capitolo dedicato alle integrazioni.

4.8. Profilazione, autorizzazione e visibilità del dato

Il sistema dovrà rendere disponibili dati analitici e di sintesi e pseudo-anonimizzati nonché anonimizzati, secondo quanto definito dalla normativa ripresa al Capitolo 8.1.

La gestione della profilazione degli operatori deve essere delegabile ai vari livelli di responsabilità e deve prevedere la gestione dell'entità del profilo operatore nelle sue diverse articolazioni: l'Ente Sanitario (ES), i ruoli, le singole funzioni, con la possibilità di organizzare le articolazioni descritte in entità "profili" e "sotto-profili", consentendo la massima flessibilità di attribuzione di privilegi, dalla proposta di ruoli predefiniti fino alla gestione di eccezioni per ruoli personalizzati, con la possibilità di configurare ciascun ruolo nel modo più granulare possibile, il tutto in perfetta coerenza con le norme legate alla privacy a livello europeo, nazionale e regionale.

La configurazione dei profili deve permettere l'identificazione della tipologia di utenti amministratori di sistema. Possibili tipologie di amministratori di sistema sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestori delle funzionalità che si occupano di mantenere attivo il servizio, di conservarne l'efficienza, di effettuare le configurazioni previste;
- utenti key users dei singoli ES quali, ad esempio il referente della COT, il responsabile della centrale cure intermedie etc.

Le funzioni di gestione degli operatori e dei profili/ruoli devono poter essere gestite dal personale preposto del Committente e/o degli ES, che deve poter:

- configurare le funzioni e le altre opzioni in modo flessibile e personalizzabile senza che siano necessari interventi o implementazioni da parte del soggetto aggiudicatario. Deve essere possibile configurare la visualizzazione delle funzioni (ad esempio menù) e dei contenuti in modalità gerarchica, con attribuzione ai profili o a classi omogenee di operatori, e possibilità di variazione per il singolo operatore;
- associare un operatore a un profilo/ruolo con determinate autorizzazioni;

- definire le modalità di accesso ai dati (ad esempio sola lettura, inserimento etc.).

Il sistema deve prevedere la parametrizzazione delle modalità di stampa, con possibilità di associare a un profilo operatore o postazione una modalità di stampa di default (ad esempio su stampante predefinita, a video, etc.), eventualmente modificabile dall'operatore stesso. Deve inoltre essere prevista, in ottemperanza al D.Lgs. 101/2018 e al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (2016/679), e ss. mm. ii. (D.Lgs. 101/2018 e successivi), la possibilità in ciascun sistema di estrarre l'elenco o la matrice di tutti gli operatori con indicato:

- profilo;
- funzioni autorizzate extra profilo;
- per ogni funzione autorizzata le modalità di accesso ai dati (lettura, inserimento, modifica etc.).

Tale elenco o matrice deve essere accessibile in tempo reale dai Responsabili di procedura e/o del trattamento dei dati, per avere sempre sotto controllo le relative abilitazioni. La funzione deve disporre di un layout facilmente consultabile dagli operatori, con possibilità di drill down o di esplosione dell'elenco (ad esempio per vedere le singole funzioni previste dal profilo).

Si faccia inoltre riferimento alle specifiche “Scenari di integrazione DEA-IMS-APMS v1.0” per la gestione dell'autenticazione dell'operatore.

Per quanto riguarda la gestione e la conseguente visibilità del dato, il sistema offerto deve prevedere funzioni diverse a seconda della tipologia del dato clinico e amministrativo presente in ogni area/sezione (fino al singolo campo).

I dati devono poter essere configurabili almeno nelle seguenti modalità, riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- legati all'assistito e comuni a tutti gli eventi: in questo caso, tali dati devono essere recuperati automaticamente e resi disponibili per la consultazione, modifica e completamento da parte dell'operatore durante un qualsiasi evento di cura, con tracciabilità e consultabilità degli inserimenti/modifiche/cancellazioni/letture (ad esempio allergie, anamnesi patologica remota, etc.);
- comuni all'interno del percorso di cura/PDTA: in questo caso tali dati devono essere recuperati automaticamente e resi disponibili per la consultazione e modifica solo negli episodi di cura relativi al percorso, con tracciabilità e consultabilità degli inserimenti/modifiche/cancellazioni/letture (ad esempio esame obiettivo, parametri vitali etc.);
- legati al singolo episodio clinico: in questo caso i dati sono contenuti solo nel singolo episodio.

Il sistema deve prevedere vari livelli di accesso: da sola lettura a gestione parziale o completa. Il sistema dei profili deve essere configurabile in modo diversificato tra la parte di gestione del SI.Ter (nei suoi diversi settori) e la gestione per dipartimento.

Ciascun ruolo deve poter essere configurato in modo parametrico e flessibile e deve rispondere ad opportune policy di visibilità e di accesso a dati e operazioni alcune delle quali sono consentite solamente per determinati profili.

L'accesso all'applicativo dovrà avvenire attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

L'accesso deve poter essere consentito anche attraverso l'integrazione con i sistemi LDAP e deve poter gestire anche altri sistemi di autenticazione più avanzati quali smart card, dispositivi di autenticazione (es. token) e deve permettere di ereditare l'autenticazione da un sistema chiamante.

4.9. Notifiche e alert

Il sistema deve prevedere un'interfaccia di notifica e avviso globale, tramite l'utilizzo di simbologia opportuna, trasversale a tutte le funzionalità. La configurazione delle notifiche da attivare deve essere funzionale e flessibile al fine di suggerire il completamento e la chiusura corretta dei processi.

In opportune sezioni (che verranno definite dal Committente), deve essere possibile mostrare/evidenziare notifiche su eventi importanti generati da azioni esterne.

Selezionando una notifica/avviso deve essere possibile eliminarlo o procedere direttamente all'apertura del contesto opportuno, previsto nel processo identificato dalla notifica, con i dati già precaricati eventualmente per completare le operazioni (sola visualizzazione, modifica o inserimento).

4.10. Acquisizione documenti e oggetti multimediali esterni

Deve essere prevista la possibilità di acquisire la documentazione in formato digitale, nei formati maggiormente utilizzati e diffusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: .xlsx, .csv, .pdf, .docx, etc)

In tutte le funzionalità deve essere possibile consultare oltre ai documenti prodotti, anche i documenti esterni caricati.

4.11. Visualizzazione dei documenti clinici e amministrativi

In tutte le fasi del percorso dell'assistito dev'essere possibile accedere a uno strumento che consenta la visualizzazione dei documenti clinici e amministrativi (strutturati e non), nei diversi formati previsti (compreso immagini, video, audio) e ne consenta la consultazione secondo i profili definiti nelle sezioni Profilazione, autorizzazione e visibilità del dato e Gestione Privacy.

4.12. Gestione privacy e consensi

In tema di privacy e trattamento dei dati personali e sensibili, il sistema deve garantire la perfetta aderenza alla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia; si fa riferimento, inoltre, a quanto previsto dalle specifiche regionali e linee guida in materia di privacy.

La registrazione dei consensi deve essere possibile attraverso la funzionalità di gestione del consenso. I consensi di ogni paziente devono corrispondere a definiti privilegi di accesso ai dati.

Si deve prevedere la gestione del consenso informato relativo ai processi di diagnosi e cura (ad esempio procedure, terapie, stato di gravidanza, etc.) che vengono eseguiti sull'assistito.

La configurazione dei consensi deve poter essere gestita da operatori del Committente e/o degli ES, permettendo l'aggiunta, la modifica, la cancellazione di richieste di consenso in modo flessibile e garantendo la possibilità di gestire il consenso legato al recupero dei dati e dei documenti pregressi. Deve essere prevista la storicizzazione dei consensi dati e l'identificazione dei punti di registrazione dei consensi.

In base a quanto definito dalle policy, deve essere possibile richiamare la gestione dei consensi in punti definiti, la cui parziale o intera compilazione è obbligatoria per il prosieguo del processo, e prevedere la stampa dell'informativa.

4.13. Requisiti specifici – Sistema Centrale Operativa Territoriale (COT)

Il sistema proposto a supporto delle attività della Centrale Operativa Territoriale (COT) dovrà prevedere necessariamente una gestione informatizzata e paperless delle procedure applicative e dei workflow clinico-amministrativi descritti di seguito.

4.13.1. Percorso di dimissione protetta

Il sistema deve consentire al personale delle unità operative di degenza delle strutture che erogano attività in regime di ricovero di generare una segnalazione per un paziente da destinare alla COT. La segnalazione deve veicolare una proposta, o setting proposto, per la quale il personale del reparto dimettente richiede una presa in carico e valutazione al personale della COT (ad esempio dimissione protetta verso struttura di ricovero a carattere intermedio, dimissione protetta con contestuale attivazione di un programma di assistenza domiciliare integrata etc.). In fase di dimissione protetta dev'essere possibile, per l'operatore del reparto, acquisire automaticamente i dati di interesse relativi al ricovero del paziente e compilare un set di scale e/o informazioni obbligatorie ai fini dell'invio della segnalazione alla COT (ad esempio la scala BRASS). Il sistema deve consentire l'implementazione di schede specifiche in base alle esigenze dell'Amministrazione e/o dei singoli ES (a titolo puramente esemplificativo si riportano: BARTHEL, IADL, ADL, VAOR, KARNOFSKY, S.Va.M.A Sanitaria, S.Va.M.A cognitivo-funzionale). Devono essere altresì presenti appositi campi dove riportare tutte le informazioni pertinenti per la presa in carico della scheda di segnalazione, come patologie concomitanti, rischio infettivo e terapie in corso. L'operatore del reparto dev'essere messo nella condizione di poter monitorare in qualsiasi momento ed in tempo reale lo stato di avanzamento della segnalazione precedentemente inviata: di poter modificare alcuni campi/valori al variare della condizione clinico assistenziale dell'assistito all'interno della segnalazione inoltrata alla COT, di ricevere notifiche puntuali ed automatiche in corrispondenza delle operazioni svolte dal personale della COT, (ad esempio richiesta di integrazione della segnalazione con ulteriori informazioni, assenza di una scala, rifiuto della richiesta in quanto non idonea etc.).

4.13.2. Percorso di ammissione protetta

Il sistema deve consentire di generare una scheda di segnalazione da parte (o per conto) di Medico di Medicina Generale (MMG), Pediatra di Libera Scelta (PLS), RSA, Strutture Intermedie: ODC, URT Hospice. Dev'essere possibile, altresì, gestire qualsiasi workflow di ammissione protetta del

paziente verso servizi territoriali, che possa arrivare da parte di strutture di ricovero a carattere intermedio e Assistenza Domiciliare Integrata. Dev'essere possibile, anche in questi casi, generare una scheda di segnalazione di ammissione protetta, destinata alla COT indicando un opportuno setting proposto. Il sistema deve consentire di personalizzare la scheda di segnalazione in base alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e/o degli ES.

4.13.3. Gestione di una scheda di segnalazione da parte della COT

La COT deve poter visualizzare tutte le segnalazioni pervenute all'interno di una dashboard principale. Il sistema deve mettere a disposizione una serie di filtri personalizzabili per semplificare e favorire la ricerca da parte dell'operatore (ad esempio l'operatore dev'essere messo nella condizione di identificare rapidamente i casi relativi a pazienti con elevato rischio infettivo o infezione MDR in corso). Il sistema deve permettere all'utente della COT di prendere in carico una segnalazione, anche a livello regionale, (scheda unica di segnalazione tra COT della Regione Veneto) di valutarla e di assegnare un setting definitivo, ovvero un servizio di destinazione finale deputato all'erogazione del servizio, opportuno.

Qualora il setting proposto preveda l'attivazione di VMD, l'utente COT deve poter visualizzare:

- l'avvenuta consegna dell'allegato B (DGR n.96 del 04/02/2025), controfirmata dal proponente;
- l'avvenuta consegna dell'allegato A, contenente la domanda per l'accesso ai servizi di rete residenziali e domiciliari e domiciliari integrati (DGR n.96 del 04/02/2025) con i relativi setting possibili e proposti al caregiver/paziente/ADS, controfirmata per accettazione del setting definitivo discusso in VMD.

A seguito di valutazione della segnalazione in sede di UVMD, il sistema deve offrire al personale COT e/o del servizio erogante in possesso degli opportuni privilegi la possibilità di compilare la S.Va.M.A

nelle sue cinque sezioni costituenti: S.Va.M.A GENERALE, S.Va.M.A UVMD, S.Va.M.A Sanitaria, S.Va.M.A cognitivo-funzionale, S.Va.M.A sociale. Il sistema deve prevedere la possibilità di compilare un diario clinico-infermieristico ove riportare informazioni ritenute di interesse sia da parte del servizio richiedente che da parte del personale COT. In ultima istanza, il sistema deve permettere alla COT di smistare una scheda di segnalazione verso uno dei seguenti setting definitivi:

- domicilio del paziente, con eventuale e contestuale attivazione di uno o più servizi;
- strutture di lungodegenza;
- strutture di ricovero a carattere intermedio (ODC/URT/Hospice);
- strutture sociosanitarie;
- trasferimento ad altra centrale per competenza.

Nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento ad una richiesta di inserimento in struttura di ricovero pubblica o convenzionata, il sistema deve consentire all'utente la visualizzazione dei posti letto disponibili presso la struttura stessa.

4.13.4. Erogazione di una segnalazione

Il sistema deve offrire la possibilità di tracciare, o tramite inserimento delle informazioni all'interno del diario o mediante l'utilizzo di appositi campi, l'avvenuta erogazione della richiesta. Dev'essere disponibile uno stato ad hoc che l'operatore potrà utilizzare per la chiusura della segnalazione. Pertanto, il sistema deve consentire il tracciamento – da parte del servizio che accoglie la domanda – dell'avvenuta presa in carico (o idoneità) da parte del setting definitivo. L'avvenuta presa in carico/idoneità deve essere visibile da parte della COT, nello stesso software.

4.14. Requisiti specifici – Sistema Strutture di Ricovero a Carattere Intermedio: OdC e URT

Il sistema proposto a supporto delle attività delle Strutture di Ricovero a Carattere Intermedio, e specificatamente Ospedali di Comunità (ODC) e Unità Riabilitative Territoriali (URT), dovrà prevedere necessariamente una gestione informatizzata di tutti i processi a partire dalla presa in carico del paziente fino alla sua dimissione.

4.14.1. Diario e comunicazioni

La funzionalità di diario e gestione consegne rappresenta il cuore del sistema, che deve offrire la possibilità all'utente in possesso degli appositi privilegi amministrativi di scrivere sul diario oppure sul diario integrato, a seconda della configurazione. Il sistema deve permettere di decidere se condividere l'informazione inserita o se mantenerla confidenziale e strettamente personale e, quindi, non visibile a nessun altro utente diverso rispetto a quello che l'ha introdotta in cartella. Il sistema deve prevedere tre tipologie di diari: medico (per medici), sanitario (per infermieri e fisioterapisti) e socioassistenziale (per OSS, educatori, assistenti sociali etc.). In alternativa, può prevedere un unico diario integrato che unisca i tre sopra menzionati. Dev'essere in ogni caso possibile poter visualizzare i diari per singola struttura/reparto o per singolo ospite. Per ogni paziente dev'essere possibile inserire all'interno del diario un numero illimitato di valutazioni/PI/PAI/PRI (obbligatoriamente all'inizio del ricovero, alla presa in carico ed alla dimissione). Ogni scheda PI/PAI/PRI deve essere composta da una serie di schede multidisciplinari, tra cui: scheda medica, scheda infermieristica, scheda riabilitativa, scheda sociale, scheda assistenziale.

Il sistema fornito deve presentare infine la possibilità di gestire un servizio di invio comunicazioni via e-mail per nucleo/reparto e/o per singola mansione, con aggiunta di eventuali allegati nei formati di estensione file maggiormente diffusi sul mercato (.pdf, .word, .xls, .xlsx etc.). All'atto della lettura dell'e-mail da parte del ricevente dev'essere generato un apposito messaggio di conferma.

4.14.2. Terapia informatizzata

La funzionalità di gestione della terapia informatizzata dev'essere disponibile in cartella e conforme alle linee di indirizzo e raccomandazioni del Ministero della Salute riguardo il processo di riconciliazione farmacologica. Il sistema deve essere integrato con una banca dati farmaceutica a propria scelta (ad esempio Farmadati) purché allineata e sincronizzata con le banche dati

ministeriali AIFA. Dev'essere possibile, per ogni attività di prescrizione e somministrazione, tracciare a sistema un set minimo di dati obbligatori tra cui l'utente che ha compiuto l'operazione e la data/ora di effettuazione della stessa. Il sistema deve consentire di prevedere degli alert automatici che informino l'operatore di eventuali allergie del paziente all'atto della somministrazione.

Dev'essere possibile ricercare un farmaco in archivio per nome commerciale o per principio attivo. Per semplificare l'azione di ricerca da parte del medico, dev'essere inoltre possibile creare dei prontuari farmaceutici personalizzati contenenti i farmaci più comunemente utilizzati. Il sistema deve indicare in maniera chiara ed inequivocabile, per ciascun farmaco selezionato, la via di somministrazione (ad esempio endovena, intramuscolo etc.) e la categoria (anticoagulante, antidiabetico etc.) e permettere la consultazione del bugiardinio in formato digitale. Una volta terminata la prescrizione delle terapie, dev'essere possibile produrre e stampare il Foglio Unico Terapia (FUT) da usare per la somministrazione. Quest'ultima deve poter avvenire in fasce orarie configurabili da parte dell'Amministrazione e/o dei singoli ES oppure in modalità "condizionata". Il FUT deve mostrare chiaramente ed inequivocabilmente i farmaci che devono essere somministrati per singolo paziente in modo da minimizzare il rischio di errore.

Sarà valutata come elemento migliorativo la possibilità di integrare il sistema via API con i software di gestione del magazzino in uso presso gli ES.

4.14.3. Monitoraggio dei parametri vitali

Il modulo di cartella clinica elettronica deve prevedere una funzionalità di gestione dei parametri vitali ritenuti di interesse dai singoli ES. Dev'essere in particolar modo possibile configurare sia singoli parametri (ad esempio peso, altezza, pressione arteriosa, saturazione etc.) che parametri compositi (ad esempio pressione + glicemia + saturazione) che valori calcolati (ad esempio BMI). L'operatore dev'essere supportato nella lettura e nell'interpretazione dei dati mediante grafici chiari ed immediati.

Sarà considerato elemento migliorativo la disposizione di scale di valutazione multidimensionali (VMD) che permettano di valutare la gravità della condizione clinica del paziente da molteplici punti di vista.

4.14.4. Fatturazione

Decorsi la soglia di giorni di ricovero in struttura a carico del SSN, il paziente è tenuto al pagamento di una quota giornaliera di compartecipazione alla spesa sanitaria. La DGR n. 1563/2024 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: aggiornamento della tariffa giornaliera di remunerazione, delle quote a carico dell'assistito per giornata di degenza e dell'esenzione alla compartecipazione alla spesa (ticket) per le prestazioni.", la quale modifica parzialmente la DGR n. 1887/2019, ridefinisce la tariffa giornaliera di remunerazione, le quote a carico dell'assistito per giornate di degenza e l'esenzione alla compartecipazione alla spesa (ticket) per le prestazioni, sia per l'Ospedale di Comunità che per l'Unità Riabilitativa Territoriale, così come riportato nella seguente tabella:

Tabella 3 – Tariffe e soglie di fatturazione per OdC e URT

	OdC	URT
Tariffa giornaliera omnicomprensiva	€ 162,00	€ 165,00
Quota a carico dell'assistito per giornata di degenza	€25,00 dal 31° al 60° giorno	€25,00 dal 16° al 60° giorno
Quota a carico dell'assistito per giornata di degenza	€45,00 dal 61° giorno	€45,00 dal 61° giorno
Prestazioni specialistiche ambulatoriali	Esenzione ticket fino al 60° giorno di degenza	Esenzione ticket fino al 60° giorno di degenza

In relazione alle prestazioni specialistiche ambulatoriali la DGR n. 1563/2024 ha esteso il periodo di esenzione dal ticket, mediante l'istituzione di un codice di esenzione specifico "OCRT" per pazienti ricoverati in Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale per il periodo di ricovero nelle strutture al fine di poter beneficiare dell'esonero dal ticket per le prestazioni specialistiche (Laboratorio, Medicina Fisica e Riabilitazione, Diagnostica per immagini e altro) necessarie durante la durata dello stesso fino a un massimo di 60 giorni.

La DGR prevede che le prestazioni ambulatoriali siano erogate in regime di esenzione solo fino al 60° giorno di degenza sia per l'ODC che per l'URT, fatte salve le altre esenzioni di legge. La quota a carico dell'assistito è di 25,00 Euro dal 31° al 60° giorno per l'ODC e di 25,00 Euro dal 16° al 60° giorno per l'URT; per entrambe le strutture la quota a carico dell'assistito a partire dal 61° giorno è di Euro 45,00.

Per quanto riguarda le prestazioni da riabilitazione, per le quali la DGR n. 1887/2019 prevedeva l'esenzione dal ticket, si specifica che sono ricomprese nelle prestazioni specialistiche.

Il sistema offerto deve prevedere un modulo amministrativo che permetta di discriminare i ricoveri a carico del SSN da quelli per i quali dev'essere generata una quota alberghiera a carico dell'assistito, secondo le indicazioni di cui sopra, nonché di inserire eventuali giustificativi/motivazioni di proroga della degenza oltre la soglia massima prevista dalla normativa senza che ciò comporti alcun onere a carico dell'utente.

4.15. Requisiti specifici – Sistema Strutture di Ricovero a Carattere Intermedio: Hospice

Il sistema proposto a supporto delle attività degli Hospice dovrà prevedere necessariamente una gestione informatizzata di tutti i processi a partire dalla presa in carico del paziente fino alla sua dimissione, secondo quanto previsto da normativa regionale.

4.15.1. Diario e comunicazioni

Analogamente a quanto richiesto per il modulo delle strutture di ricovero a carattere intermedio di cui al §4.11, la funzionalità core del sistema di cartella clinica elettronica per l'Hospice è rappresentato dal diario clinico informatizzato. Il sistema deve prevedere tre tipologie di diari: medico (per medici/psicologi), sanitario (per infermieri e fisioterapisti) e socioassistenziale (per OSS, educatori, assistenti sociali etc.). Ciascuna tipologia di utente deve poter alimentare il contenuto del diario conformemente alla propria mansione ed ai propri privilegi amministrativi. Dev'essere sempre possibile poter visualizzare i diari per singola struttura/reparto o per singolo ospite. Per ogni paziente dev'essere possibile inserire all'interno del diario un numero illimitato di valutazioni/PI/PAI/PRI (obbligatoriamente all'inizio del ricovero, alla presa in carico ed alla dimissione). Ogni scheda PI/PAI/PRI deve essere composta da una serie di schede multidisciplinari, tra cui: scheda medica, scheda infermieristica, scheda riabilitativa, scheda sociale, scheda assistenziale.

Il sistema fornito deve presentare infine la possibilità di gestire un servizio di invio comunicazioni via e-mail per nucleo/reparto e/o per singola mansione, con aggiunta di eventuali allegati nei formati di estensione file maggiormente diffusi sul mercato (.pdf, .word, .xls, .xlsx etc.). All'atto della lettura dell'e-mail da parte del ricevente dev'essere generato un apposito messaggio di conferma.

4.15.2. Terapia informatizzata

La funzionalità di gestione della terapia informatizzata dev'essere disponibile in cartella e conforme alle linee di indirizzo e raccomandazioni del Ministero della Salute riguardo il processo di riconciliazione farmacologica. Il sistema deve essere integrato con una banca dati farmaceutica a propria scelta (ad esempio Farmadati) purché allineata e sincronizzata con le banche dati ministeriali AIFA. Dev'essere possibile, per ogni attività di prescrizione e somministrazione, tracciare a sistema un set minimo di dati obbligatori tra cui l'utente che ha compiuto l'operazione e la data/ora di effettuazione della stessa. Il sistema deve mettere a disposizione un sistema di alert automatico che informi l'operatore di eventuali allergie del paziente all'atto della somministrazione.

Dev'essere possibile ricercare un farmaco in archivio per nome commerciale o per principio attivo. Per semplificare l'azione di ricerca da parte del medico, dev'essere inoltre possibile creare dei prontuari farmaceutici personalizzati contenenti i farmaci più comunemente utilizzati. Il sistema deve indicare in maniera chiara ed inequivocabile, per ciascun farmaco selezionato, la via di somministrazione (ad esempio endovena, intramuscolo etc.) e la categoria (anticoagulante, antidiabetico etc.) e permettere la consultazione del bugiardinio in formato digitale. Una volta terminata la prescrizione delle terapie, dev'essere possibile produrre e stampare il Foglio Unico Terapia (FUT) da usare per la somministrazione. Quest'ultima deve poter avvenire in fasce orarie configurabili da parte dell'Amministrazione e/o dei singoli ES oppure in modalità "condizionata". Il FUT deve mostrare chiaramente ed inequivocabilmente i farmaci che devono essere somministrati per singolo paziente in modo da minimizzare il rischio di errore.

Sarà valutata come elemento migliorativo la possibilità di integrare il sistema via API con i software di gestione del magazzino in uso presso gli ES.

4.15.3. Monitoraggio dei parametri vitali

Il modulo di cartella clinica elettronica deve prevedere una funzionalità di gestione dei parametri vitali ritenuti di interesse dai singoli ES. Dev'essere in particolar modo possibile configurare sia singoli parametri (ad esempio peso, altezza, pressione arteriosa, saturazione etc.) che parametri compositi (ad esempio pressione + glicemia + saturazione) che valori calcolati (ad esempio BMI). L'operatore dev'essere supportato nella lettura e nell'interpretazione dei dati mediante grafici chiari ed immediati.

Il sistema deve mettere infine a disposizione scale di valutazione multidimensionali (VMD) che permettano di valutare la gravità della condizione clinica del paziente da molteplici punti di vista, con una modalità di visualizzazione grafica che dia all'operatore immediata evidenza dell'andamento dello stato di salute del paziente, con particolare attenzione ai percorsi di fine vita.

4.15.4. Ulteriori strumenti a supporto

Il sistema deve prevedere strumenti per la valutazione dei bisogni e la valutazione della complessità clinica e assistenziale utilizzati dalla RLCP, secondo la normativa e le linee di indirizzo regionali.

4.16. Requisiti specifici – Sistema Cure Domiciliari

La cartella per le Cure Domiciliari (Assistenza Domiciliare Integrata - ADI e Cure Palliative Domiciliari), deve consentire la gestione completa del complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali, rese a domicilio dell'ammalato, secondo piani individuali programmati di assistenza, definiti con la partecipazione delle figure professionali interessate al singolo caso.

4.16.1. Attività

Il sistema deve permettere di configurare tutte le specifiche attività e sub-attività da erogare e monitorare. Dev'essere possibile, mediante un'agenda o un apposito calendario, pianificare gli appuntamenti assegnando un'attività ad uno specifico utente o ad uno o più operatori. Dev'essere possibile in qualsiasi momento cambiare l'assegnazione dell'attività. Il sistema deve offrire all'utente in possesso degli appositi privilegi amministrativi la possibilità di monitorare in tempo reale delle attività effettuate dalle diverse tipologie di operatori con il dettaglio della fase di esecuzione o mancata esecuzione. Sarà considerato elemento migliorativo la possibilità di monitorare le timbrature virtuali degli operatori con evidenza degli scostamenti rispetto al monte ore.

4.16.2. PAI

Il sistema deve mettere a disposizione una sezione dedicata alle valutazioni multidisciplinari periodiche e ai PAI. La gestione del PAI deve consentire alle varie figure professionali di definire gli obiettivi e le azioni da svolgere per soddisfare le necessità del paziente. Dal PAI individualizzato

dev'essere possibile pianificare tutte le attività definite, suddivise per qualifica professionale, e definire indicatori volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi. Ciascuna tipologia di operatore deve poter modificare il documento relativamente alla/e parte/i di propria competenza in base al ruolo, quindi più operatori possono lavorare contemporaneamente sullo stesso utente.

La valutazione del PAI deve prevedere obbligatoriamente quattro aree: medica (patologie ed anamnesi), infermieristica (trattamenti, lesioni da pressione etc.), professionisti (sociale, riabilitazione etc.) e assistenziale. Il sistema deve acquisire le informazioni utili alla creazione del PAI direttamente dalle sezioni del software in cui esse sono state inserite e registrate, evitando perdite di tempo e minimizzando il rischio di errori.

4.16.3. Order Entry

Sarà considerato come elemento migliorativo ai fini della valutazione dell'offerta tecnica del Fornitore la disponibilità di un modulo integrato per la richiesta di esami di laboratorio, esami diagnostici e consulenze specialistiche, fornendo tutte le informazioni necessarie quali, a titolo esemplificativo, la necessità di trasporto, l'indicazione del fornitore esterno etc. Potranno essere acquisiti i referti prodotti dalla struttura erogante nella forma di allegati mediante standard e protocolli informatici condivisi.

4.16.4. Terapia informatizzata

La funzionalità di gestione della terapia informatizzata dev'essere disponibile in cartella e conforme alle linee di indirizzo e raccomandazioni del Ministero della Salute riguardo il processo di riconciliazione farmacologica. Il sistema deve essere integrato con una banca dati farmaceutica a propria scelta (ad esempio Farmadati) purché allineata e sincronizzata con le banche dati ministeriali AIFA. Dev'essere possibile, per ogni attività di prescrizione e somministrazione, tracciare a sistema un set minimo di dati obbligatori tra cui l'utente che ha compiuto l'operazione e la data/ora di effettuazione della stessa. Il sistema deve mettere a disposizione un sistema di alert automatico che informi l'operatore di eventuali allergie del paziente all'atto della somministrazione.

Dev'essere possibile ricercare un farmaco in archivio per nome commerciale o per principio attivo. Per semplificare l'azione di ricerca da parte del medico, dev'essere inoltre possibile creare dei prontuari farmaceutici personalizzati contenenti i farmaci più comunemente utilizzati. Il sistema deve indicare in maniera chiara ed inequivocabile, per ciascun farmaco selezionato, la via di somministrazione (ad esempio endovena, intramuscolo etc.) e la categoria (anticoagulante, antidiabetico etc.) e permettere la consultazione del bugiardino in formato digitale. Una volta terminata la prescrizione delle terapie, dev'essere possibile produrre e stampare il Foglio Unico Terapia (FUT) da usare per la somministrazione. Quest'ultima deve poter avvenire in fasce orarie configurabili da parte dell'Amministrazione e/o dei singoli ES oppure in modalità "condizionata". Il FUT deve mostrare chiaramente ed inequivocabilmente i farmaci che devono essere somministrati per singolo paziente in modo da minimizzare il rischio di errore.

Sarà valutata come elemento migliorativo la possibilità di integrare il sistema via API con i software di gestione del magazzino in uso presso gli ES.

4.16.5. Diario e comunicazioni

La funzionalità di diario e gestione consegne rappresenta il cuore del sistema, che deve offrire la possibilità all'utente in possesso degli appositi privilegi amministrativi di scrivere sul diario oppure sul diario integrato, a seconda della configurazione. Il sistema deve permettere di decidere se condividere l'informazione inserita o se mantenerla confidenziale e strettamente personale e, quindi, non visibile a nessun altro utente diverso rispetto a quello che l'ha introdotta in cartella. Il sistema deve prevedere tre tipologie di diari: medico (per medici), sanitario (per infermieri e fisioterapisti) e socioassistenziale (per OSS, educatori, assistenti sociali etc.).

In alternativa, può prevedere un unico diario integrato che unisca i tre sopra menzionati, con possibilità di filtrare le note per operatore. Dev'essere in ogni caso possibile poter visualizzare i diari per singola struttura/reparto o per singolo ospite. Per ogni paziente dev'essere possibile inserire all'interno del diario un numero illimitato di valutazioni/PI/PAI/PRI (obbligatoriamente all'inizio del ricovero, alla presa in carico ed alla dimissione). Ogni scheda PI/PAI/PRI deve essere composta da una serie di schede multidisciplinari, tra cui: scheda medica, scheda infermieristica, scheda riabilitativa, scheda sociale, scheda assistenziale.

Il sistema fornito deve presentare infine la possibilità di gestire un servizio di invio comunicazioni via e-mail per nucleo/reparto e/o per singola mansione, con aggiunta di eventuali allegati nei formati di estensione file maggiormente diffusi sul mercato (.pdf, .docx, .xls, .xlsx etc.). All'atto della lettura dell'e-mail da parte del ricevente deve essere generato un apposito messaggio di conferma.

4.16.6. Calendario e scadenze

Il sistema deve mettere a disposizione tre calendari per segnare scadenze e appuntamenti: il calendario di struttura, degli utenti e degli operatori. I calendari devono avere una visualizzazione semplice e permettere di inserire le scadenze cliccando sul giorno e sull'ora in cui si desidera registrare l'appuntamento. Dev'essere possibile filtrare il calendario delle scadenze per attività.

4.16.7. Report attività domiciliari

Il sistema deve offrire una modalità di visualizzazione integrata dello storico degli orari delle diverse tipologie di operatori, consentendo di personalizzare il report utilizzando molteplici filtri. Dev'essere possibile produrre il report in formato esportabile.

4.16.8. Ulteriori strumenti a supporto

Il sistema deve prevedere strumenti per la valutazione dei bisogni assistenziali in ADI, nonché strumenti per la valutazione dei bisogni e la valutazione della complessità clinica e assistenziale utilizzati dalla RLCP e RRTDCPP, secondo la normativa e le linee di indirizzo/percorsi integrati di cura regionali, nonché relativi requisiti di accreditamento.

4.17. Requisiti specifici – Sistema Consultori, Età Evolutiva e Neuropsichiatria Infantile

Il sistema deve consentire una piena informatizzazione dei processi clinico-amministrativi nell'ambito dei servizi rivolti al singolo, alla coppia e alla famiglia, in cui è possibile affrontare le tematiche che riguardano la vita affettiva, sessuale e relazionale, la procreazione responsabile, la maternità e la paternità, la genitorialità, la tutela della salute della donna, la consulenza preconcezionale, la prevenzione dei disturbi dell'apparato genitale femminile, il climaterio e l'interruzione volontaria di gravidanza.

4.17.1. Apertura cartella

La cartella rappresenta il contenitore unico delle prese in carico dei Consultori per le diverse aree di intervento, per l'Età evolutiva ed eventualmente per la Neuropsichiatria Infantile (NPI). Deve offrire una visione globale delle prese in carico del paziente e del relativo storico. I percorsi di presa in carico possono essere attivati in momenti diversi e devono gestire informazioni specifiche per l'area di riferimento. Nella cartella quindi si possono avere più percorsi attivi contemporaneamente purché di diverso tipo, ad esempio un cittadino può avere un percorso "Supporto psicologico" ed un "Percorso nascita" attivi nello stesso periodo ma con date di presa in carico diversa e con schede specifiche.

Ogni percorso di presa in carico dovrà gestire un dataset minimo di informazioni obbligatorie che l'operatore dovrà gestire all'apertura, ad esempio: data di apertura, data di primo contatto, area di intervento, distretto/sede territoriale titolare della presa in carico, data di presa in carico, motivo di apertura, inviante. L'apertura di una presa in carico deve gestire anche i criteri di visibilità ovvero se l'accesso è consentito al consultorio del DSS oppure ad una équipe di professionisti più ristretta.

4.17.2. Apertura percorso

La configurazione dei tipi di percorso all'interno del sistema per i consultori deve considerare almeno le 6 Aree proposte dal Ministero: A - Salute sessuale, B - Salute riproduttiva, C - Prevenzione e promozione della salute, D - Supporto psicologico, E - Adozione - Affidi, F - Rapporti con le istituzioni. Deve essere possibile gestire e configurare percorsi anche su ulteriori Aree, in base alle esigenze di Azienda Zero e/o degli ES, sarà valutata come elemento migliorativo da parte del Committente.

La gestione dell'età evolutiva e della NPI può essere inclusa in specifiche aree del consultorio oppure gestita in percorsi specifici in base alle indicazioni degli Enti Sanitari.

Il sistema deve offrire la possibilità di creare percorsi di presa in carico delle seguenti tipologie:

- individuali, ovvero riferiti al singolo paziente;
- piccoli gruppi, ovvero riferiti alla coppia o al nucleo familiare;
- grandi gruppi (ad esempio gruppi di allattamento, IAN, gruppo pre-parto etc.);
- gruppi anonimi, che rappresentano una persona non fisica a cui si intesta un omonimo percorso dedicato (ad esempio, la classe di una scuola).

È da prevedere anche la presa in carico generica, che serve per gestire le situazioni dove l'attività inizialmente viene rivolta ad un cittadino poi estesa ad altre persone (partner o famiglia). Dev'essere disponibile una sezione "Accoglienza" destinata ad accogliere tutte le informazioni dell'assistito che si raccolgono all'atto del primo accesso.

4.17.3. Accessi/Visite

Il sistema deve essere dotato di un modulo per la registrazione delle prestazioni relative alle diverse Aree con i dovuti controlli di coerenza impostati sul tipo percorso e sul ruolo dell'operatore. Dovranno essere gestite le prestazioni previste dai flussi con la possibilità di integrare il catalogo afferendo comunque a quelle previste.

Il sistema dev'essere dotato di un proprio modulo di agende per consentire la pianificazione degli accessi/visite. L'operatore che accede al sistema può gestire le proprie attività e quelle della propria struttura mediante una lista di lavoro appositamente configurata. Tale worklist deve essere predisposta per essere alimentata mediante integrazione con i sistemi di gestione accesso a prenotazione (CUP) in uso negli ES.

4.17.4. Gestione percorso

Dev'essere disponibile una sezione "Accoglienza" che raccolga tutte le informazioni che si acquisiscono per il paziente all'atto dell'apertura di un percorso. In tale sezione devono essere disponibili le seguenti card obbligatorie:

- assistiti associati al percorso;
- équipe associata al percorso;
- dati socio-demografici;
- prima visita;
- persone di riferimento;
- anamnesi remota;
- allegati;
- schede specifiche per area di lavoro;
- esito valutazione.

Il sistema deve permettere di configurare delle schede ad hoc per ogni tipologia di percorso, a titolo esemplificativo si riportano: scheda per percorso post-coitale, scheda per percorso ginecologico, scheda per percorso maschile, scheda per percorso IVG, scheda per percorso Post-Partum e Puerperio, scheda per percorso gravidanza, scheda per percorso psico-sociale. L'Aggiudicatario dovrà consentire la predisposizione di ulteriori schede in base alle esigenze specifiche dell'Amministrazione e/o degli ES.

Il sistema deve permettere di tracciare l'avvenuta presa in carico del paziente che ha eseguito una visita/accesso al consultorio e che sia stato ritenuto idoneo ad essere preso in carico nell'ambito di un percorso ambulatoriale.

Nel corso della gestione del percorso assistenziale il medico deve poter emettere una prescrizione farmaceutica o specialistica sfruttando il sistema di prescrizione elettronica i cui requisiti

AZIENDA ZERO – Appalto Specifico ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della Regione Veneto – ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2365 - LOTTO 3 Capitolato Tecnico

fondamentali sono descritti al Capitolo 4.20. Si specifica che tale modulo dovrà essere accessibile mediante integrazione basata su web service/API o in modalità di chiamata di contesto.

In base al processo di presa in carico adottato dall'Ente Sanitario il sistema dovrà prevedere a livello di configurazione che alcune informazioni potranno essere raccolte in modalità obbligatoria per assolvere ai debiti informativi interni ed esterni.

4.17.5. Chiusura percorso

Il sistema deve mettere a disposizione una sezione "Chiusura percorso" che deve presentare obbligatoriamente una card "Conclusione" composta dai seguenti campi:

- data chiusura, campo obbligatorio che deve poter essere impostato dall'utente da apposito menu calendarizzato e, di default, posto uguale alla data/ora corrente;
- motivo chiusura, campo obbligatorio che permette di specificare una motivazione per la conclusione del percorso selezionando un'alternativa tra quelle disponibili in apposito menu a tendina;
- note, campo obbligatorio a compilazione in modalità di testo libero.

4.18. Requisiti specifici – Sistema Centro Salute Mentale (CSM)

Il sistema proposto deve consentire la piena digitalizzazione dei processi che avvengono nell'ambito del Centro di Salute Mentale (CSM), il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. Esso coordina nell'ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini maggiorenni che presentano patologie psichiatriche. Nel CSM vengono elaborati progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati per le persone prese in carico.

4.18.1. Accoglienza

La fase di accoglienza del paziente è un processo che può richiedere tempo, la somministrazione di visite e test e che spesso coinvolge più tipi di figura (Psichiatra, Infermiere, Assistente Sociale). È opportuno che il sistema sia configurabile per gestire gli opportuni spazi per ogni figura e per le diverse fasi del processo. Indicativamente può essere suddiviso nelle seguenti sottofasi:

- contatto: tipicamente amministrativo utilizzato per gestire la richiesta o le segnalazioni e le schede di accoglienza customizzate;
- sociale: riservato all'assistente sociale con schede personalizzate;
- sanitario: riservato agli infermieri per la rilevazione dei dati sanitari;
- valutazione clinica: riservato ai medici per le valutazioni specifiche del servizio e per la definizione della diagnosi;
- esito: riservato al medico per la definizione del tipo di presa in carico/non presa in carico.

L'accesso al servizio può essere diretto o tramite richiesta prenotata su sistema CUP. Nel caso di accesso diretto l'apertura di un percorso sarà frutto di data-entry, nel caso di prenotazione CUP, se il sistema è integrato l'apertura del percorso viene gestita con una funzionalità che guida l'operatore nella registrazione.

Il sistema deve consentire l'assegnazione del caso ad una équipe che procede pianificando gli interventi in base all'urgenza. Gli interventi possono essere svolti in regime ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale oppure domiciliare.

Per consentire la corretta alimentazione dei flussi devono essere inseriti dei controlli specifici nelle diverse fasi del processo di presa in carico, ad esempio deve essere registrata la diagnosi ICD9-CM. Altri controlli di obbligatorietà potranno essere richiesti dagli Enti Sanitari.

Il sistema deve consentire di esitare la valutazione del paziente con uno dei seguenti quattro outcome:

- chiusura del percorso con consulenza;
- presa in carico (multidisciplinare);
- assunzione in cura (psichiatra);
- invio ad altri servizi.

Il sistema deve permettere di gestire l'area per cui viene fatta la presa in carico o l'assunzione in cura. Le principali aree sono: DSM e Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; la committenza può richiedere la gestione di ulteriori aree (Es. Post Partum).

4.18.2. Trattamento

Nella fase di trattamento vengono dovranno essere gestite almeno le seguenti informazioni:

- terapie farmacologiche (prescrizione e somministrazione);
- accessi e prestazioni;
- inserimento in strutture residenziali/semiresidenziali.

L'accesso del cittadino, inteso come prestazione ambulatoriale, dev'essere gestito e documentato in un'apposita sezione della cartella. L'operatore dovrà gestire:

- la data dell'evento (proposta dal sistema ma modificabile);
- il luogo di erogazione (proposto in base ai dati di accesso dell'operatore al sistema, modificabile);
- le prestazioni erogate scelte dal catalogo e discriminate in base alla qualifica dell'operatore, al servizio ed al trattamento in corso;
- le note di diario;
- le schede e scale di valutazione.

Nel corso della gestione del percorso assistenziale il medico deve poter emettere una prescrizione farmaceutica o specialistica sfruttando il sistema di prescrizione elettronica i cui requisiti fondamentali sono descritti al Capitolo 4.20. Si specifica che tale modulo dovrà essere accessibile mediante integrazione basata su web service/API o in modalità di chiamata di contesto.

In particolare, nell'ottica dell'efficientamento dei percorsi clinico-assistenziali Ospedale-Territorio e Territorio-Ospedale deve essere assicurata l'integrazione con il sistema ADT in uso presso i singoli ES allo scopo di rilevare, in maniera automatica ed in tempo reale, le notifiche di ricovero per gli assistiti in carico al servizio.

Infine, il sistema deve consentire di:

- visualizzare una worklist giornaliera per il personale infermieristico, (schema giornaliero delle attività di somministrazione da effettuare);
- registrare parametri ed indicatori ritenuti di interesse quali peso, altezza, BMI etc. La richiesta di configurazione di ulteriori parametri potrà pervenire da parte del Committente e/o dei singoli ES in base alle specificità dei singoli contesti;
- predisporre e compilare scale cliniche di valutazione predisposte con gli item previsti;
- predisporre e configurare schede distinte per singola patologia nella fase di gestione del trattamento clinico-sanitario;
- effettuare l'upload di documenti ad integrazione della cartella ambulatoriale clinica.

In ottica di ottimizzazione del flusso di attività, dovrà essere inoltre valutata e verificata la possibilità di:

- accedere ai dati di invalidità dei pazienti;
- sviluppare la procedura contabile in correlazione al dato di presenza in strutture residenziali e semiresidenziali;
- integrazione con la Farmacia, in particolare relativamente alla gestione diretta di carico e scarico dei farmaci, visualizzazione del prontuario farmaceutico aziendale, acquisizione automatica dei farmaci consegnati dalle Farmacie Aziendali ai CSM.

4.18.3. Conclusione

Il sistema deve consentire all'operatore di chiudere il percorso del paziente indicando obbligatoriamente una data di chiusura ed una motivazione in modalità di testo libero.

4.19. Requisiti specifici – Sistema di Prescrizione Elettronica

Il modulo di prescrizione elettronico fornito dall'Aggiudicatario deve permettere la prescrizione della ricetta dematerializzata conformemente alle linee guida fornite dal Ministero della Salute, alle specifiche tecniche presenti su Sistema TS ed in ottemperanza al documento di specifiche tecniche regionali "Dematerializzazione della ricetta rossa" all'ultima versione disponibile.

4.19.1. Prescrizione farmaceutica

Il modulo prescrittivo dev'essere integrato con una banca dati farmaceutica riconosciuta a livello nazionale e sincronizzata con le banche dati AIFA (ad esempio Farmadati). Dev'essere possibile ricercare un farmaco in archivio per nome commerciale o per principio attivo. Per semplificare l'azione di ricerca da parte del medico, dev'essere inoltre possibile creare dei profili personalizzati contenenti i farmaci più comunemente utilizzati dall'utente. Il sistema deve offrire la possibilità di gestire la molteplicità delle informazioni che si addicono ad un modulo di prescrizione informatizzata, tra cui:

- impostazione della clausola di non sostituibilità del farmaco in ricetta;
- selezione della nota AIFA associata;

- consultazione dei generici disponibili per un determinato farmaco originale;
- selezione della quantità di confezioni;
- inserimento del quesito diagnostico/note a corredo della prescrizione;
- indicazione del numero di protocollo del Piano Terapeutico disponibile su Sistema TS.

L'utente deve poter risalire agevolmente allo storico delle prescrizioni farmaceutiche precedentemente emesse e poterle duplicare rapidamente e senza perdita di tempo.

4.19.2. Prescrizione specialistica

Il modulo prescrittivo deve implementare il Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) v2.4, e garantire l'allineamento con le future versioni. Dev'essere possibile ricercare una prestazione in archivio per codice CVP o descrizione associata. Per semplificare l'azione di ricerca da parte del medico, dev'essere inoltre possibile creare dei profili personalizzati contenenti le prestazioni più frequentemente utilizzate dall'utente. Il sistema deve offrire la possibilità di gestire la molteplicità delle informazioni che si addicono ad un modulo di prescrizione informatizzata, tra cui:

- impostazione della classe di priorità in ricetta;
- specificazione del quesito diagnostico in testo libero o in modalità codificata;
- selezione della quantità di prestazioni prescritte;
- inserimento di eventuali note a corredo delle singole prestazioni prescritte.

L'utente deve poter risalire agevolmente allo storico delle prescrizioni specialistiche precedentemente emesse e poterle duplicare rapidamente e senza perdita di tempo.

Il sistema deve implementare logiche automatiche di spaccettamento delle prestazioni in più ricette in funzione dell'applicazione delle regole regionali circa il numero massimo di prestazioni inseribili in ricetta e circa la compatibilità tra singoli codici CVP in virtù delle branche di appartenenza e del tipo accesso (0, 1).

5. REQUISITI NON FUNZIONALI

Nel presente Capitolo si descrivono le caratteristiche non funzionali che il sistema in oggetto dovrà soddisfare.

5.1. Interoperabilità e integrazioni

Il sistema oggetto della fornitura dovrà interfacciarsi ed integrarsi in maniera completa le varie componenti del sistema informativo aziendale o sovraziendale, sia regionale che nazionale in materia, secondo specifiche che verranno condivise in sede esecutiva di progetto.

Laddove negli ES non sia ancora disponibile il nuovo Sistema Informativo Ospedaliero fornito da Regione Veneto, il fornitore dovrà garantire fin avvio le attuali integrazioni con i sistemi degli ES (ad esempio anagrafe paziente, CUP, ADT, repository aziendali ecc..) con le specifiche in essere, per far fronte alle funzionalità oggetto di gara. Sarà in seguito necessario completare l'integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero fornito da Regione Veneto una volta completata l'adozione dello stesso da parte di ogni ES.

Il Fornitore dovrà implementare modalità standard di scambio dati e documenti. Il sistema dovrà essere aderente agli standard regionali adottati nell'interoperabilità tra i vari sistemi, sia essi regionali che del singolo ES. Il sistema dovrà altresì essere conforme ai principali standard utilizzati in ambito sanitario (HL7 CDA2, HL7 FHIR, HL7 v2.X) nonché ai principali profili IHE adottati, per assicurare la piena interoperabilità con gli altri sistemi. Deve inoltre garantire una piena interoperabilità tra i diversi moduli del SI.Ter oggetto della fornitura, garantendo la completa trasmissione tra essi delle informazioni necessarie ai processi.

Di seguito vengono elencate le integrazioni che il SI.Ter dovrà garantire per assolvere le funzionalità necessarie ai vari moduli, con i relativi riferimenti:

- **Autenticazione e login:** L'applicativo in oggetto dovrà essere integrato con il sistema di autenticazione regionale APMS (Application Profile Management System) relativamente a tutti i moduli costituenti e, per il tramite di APMS, con i sistemi di Identity and Assertion Provider (IAP) già esistenti nei singoli ES, secondo quanto definito nei documenti "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza v2.17" e "Scenari di integrazione DEA-IMS-APMS v1.0".
- **Organigramma e profilazione:** L'applicativo in oggetto dovrà essere integrato con il sistema regionale A.Re.A e con l'eventuale sistema IMS aziendale, laddove presente nel singolo ES, secondo quanto definito nel documento "Specifiche tecniche Attribute Provider v1.8" e nel documento "Scenari di integrazione DEA-IMS-APMS v1.0", ed in base al livello di digitalizzazione dell'ES.
- **Anagrafiche pazienti:** L'applicativo in oggetto dovrà integrarsi all'Anagrafe Regionale. Il sistema dovrà conservare l'identificativo univoco per tutte le transazioni e poterne recepire ogni variazione. Il sistema dovrà quindi essere in grado di gestire le operazioni principali di allineamento anagrafico (ricerca e sottoscrizione), in tutti i processi, garantendone la totale tracciabilità nel rispetto della sicurezza del processo clinico. Le specifiche tecniche di riferimento sono "Specifiche tecniche - Anagrafe Zero v2.9", "Linee guida SIO per l'adeguamento degli applicativi integrati ad Anagrafe Zero al modello organizzativo v1.4" e

“Modello organizzativo e linee guida per i servizi anagrafici di integrazione con Anagrafe Zero v1.4”. Nelle realtà dove non è stato avviato il Sistema Informativo Ospedaliero Regionale dovrà inoltre garantire l'integrazione con le anagrafi degli Enti Sanitari.

- **Integrazione con banca dati farmaci:** per la gestione delle anagrafiche dei farmaci l'applicativo in oggetto dovrà integrarsi con una banca dati dei farmaci che garantisca l'allineamento con la banca dati di AIFA (es. farmadati).
- **Condivisione documentale e alimentazione FSEr:** L'applicativo in oggetto dovrà garantire la condivisione documentale e l'alimentazione del FSEr attraverso l'infrastruttura XDS regionale, rispettando l'Affinity Domain regionale “Progetto FSEr - Specifiche tecniche Affinity Domain v2.30”, in particolare:
 - dovrà conferire i documenti nel XDS Document Repository (Aziendale o Regionale, in base al tipo di documento) in conformità a quanto previsto dal profilo IHE XDS.b, permettendo la pubblicazione e la condivisione dei documenti, e loro indicizzazione nel XDS Document Registry regionale, e garantendo gli opportuni livelli di riservatezza, gestione delle versioni e delle catene documentali;
 - laddove i documenti prodotti andranno ad alimentare il FSE, dovrà garantire il rispetto della normativa e linee guida di riferimento per quanto concerne formato, modalità di condivisione e validazione per FSE 2.0, sostenendo qualora necessario il relativo accreditamento previsto;
 - dovrà garantire la possibilità di aggiornamento dei metadati di documenti precedentemente condivisi in conformità a quanto previsto dal profilo IHE Metadata Update con la sua estensione “Remove Metadata and Document”.

Per quanto riguarda gli ES in cui non è stato avviato il Sistema Informativo Ospedaliero Regionale risulta necessario garantire le integrazioni in essere presso gli ES per l'archiviazione dei documenti e loro indicizzazione.

- **Recupero e import informazioni e dati:** L'applicativo in oggetto dovrà garantire, dove necessario, il recupero e l'import delle informazioni condivise nell'infrastruttura regionale; in particolare:
 - dovrà essere in grado di recuperare i documenti di interesse nel XDS Document Repository, in conformità a quanto previsto dal profilo IHE XDS.b, anche previa loro ricerca nel XDS Document Registry regionale;
 - laddove i documenti abbiano una parte strutturata (CDA2), dovrà essere in grado di recuperare l'informazione di interesse ed importarla nel sistema;
 - dovrà essere in grado di recuperare i dati presenti nel FHIR server regionale, anche previa loro ricerca, in conformità a quanto previsto dallo standard HL7 FHIR, relativamente alle risorse FHIR contenenti le informazioni cliniche di interesse e condivise dai vari applicativi in Regione Veneto;
 - laddove necessario, dovrà essere in grado di gestire meccanismi di sottoscrizione e notifica, sia essa documentale in ottemperanza a quanto previsto dal profilo IHE DSUB e la sua estensione definita nel supplement “Extensions to Metadata Subscription”: “IHE_ITI_Suppl_DSUB_Extensions”, sia essa relativa alle risorse FHIR, in conformità a quanto previsto dallo standard HL7 FHIR, in modo tale da poter essere notificato repentinamente di documentazione, dati ed informazioni di interesse.

- **Accesso ad applicativi terzi e visualizzatori:** L'applicativo in oggetto deve prevedere la possibilità di chiamare in contesto l'applicativo del SIO utilizzando le transazioni riportate nelle specifiche "Specifiche tecniche transazioni ausiliarie integrazione SIO v2.10" per le diverse funzionalità previste, ad esempio il modulo CUP per la prenotazione. Inoltre, deve poter richiamare in contesto anche altri applicativi, come ad esempio il visualizzatore regionale del FSE o la piattaforma di telemedicina, utilizzando le transazioni definite dalle specifiche "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.2" e loro eventuale declinazione specifica per determinato applicativo. Per quanto riguarda gli ES in cui non è stato avviato il Sistema Informativo Ospedaliero Regionale risulta necessario garantire l'eventuale accesso in contesto tramite integrazione in essere presso gli ES.
- **Accesso ai moduli del SI.Ter da applicativi terzi:** L'applicativo in oggetto deve prevedere la possibilità di essere chiamato in contesto da applicativi terzi in aderenza alle "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.2" e loro eventuale declinazione specifica per determinato modulo del SI.Ter (COT, ODC/URT, Hospice, Cure Domiciliari, etc.).
- **Order Entry/richiedente:** L'applicativo in oggetto dovrà garantire, dove necessario, la funzionalità di order entry o richiedente (Order Placer) per poter trasmettere verso gli applicativi eroganti (es. RIS, LIS, Telemedicina, etc) le richieste di erogazione di esami/prestazioni, tramite specifici Web Service, in conformità a quanto riportato nei documenti "Specifiche tecniche integrazione RIS v2.14", "Specifiche tecniche integrazione LIS v2.14" e "Specifiche tecniche - dipartimentali clinici v2.12".
- **Ricezione ordini/erogatore:** L'applicativo in oggetto dovrà garantire la funzionalità di ricezione ordini o erogatore (Order Filler) per poter ricevere le prenotazioni o richieste di esecuzioni di esami/prestazioni dagli applicativi richiedenti (es. CUP SIO, Telemedicina, etc.), tramite specifici Web Service, in conformità a quanto riportato nei documenti "Specifiche tecniche integrazione RIS v2.14" e "Specifiche tecniche - Integrazione Dipartimentali v2.12".
- **DWH:** L'applicativo in oggetto deve poter garantire alimentazione dei sistemi di DWH e di B.I. sia aziendali che regionali, tramite specifiche condivise in fase esecutiva da parte del committente.
- **Sistemi di pagamento e amministrativo contabile:** L'applicativo in oggetto deve garantire l'integrazione con moduli di pagamento (ad esempio casse automatiche, mypay, etc.) e garantire la raccolta dei dati atti a confluire verso flussi amministrativo contabili degli ES. Le specifiche verranno condivise in fase esecutiva da parte del committente.
- **Prescrizione:** L'applicativo in oggetto deve poter garantire la gestione della prescrizione della ricetta dematerializzata sia farmaceutica che specialistica in conformità a quanto previsto dalle specifiche "Dematerializzazione della ricetta rossa farmaceutica progetto FSEr v1.1" e "Dematerializzazione della ricetta rossa progetto FSEr v2.28" e dalle specifiche scaricabili dal sito del Sistema TS. Inoltre, dovrà garantire la possibilità di gestire anche la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN secondo quanto riportato "Specifiche tecniche dematerializzazione della ricetta bianca farmaceutica v0.2" e le specifiche scaricabili dal sito del Sistema TS.
- **Magazzino, micrologistica e distribuzione diretta farmaci:** L'applicativo in oggetto deve poter garantire l'integrazione con l'applicativo di logistica e magazzino per la gestione della movimentazione dei prodotti e delle richieste e/o distribuzione dei farmaci, in aderenza a quanto

previsto dalle “Specifiche Tecniche - Integrazione Magazzino e Logistica v3.0”. Per quanto riguarda gli ES in cui non è stato avviato il Sistema Informativo Ospedaliero Regionale e/o il dipartimentale DEA Logical risulta necessario garantire le attuali integrazioni in essere presso gli ES.

- **SIO - ADT/Pronto Soccorso:** L'applicativo in oggetto deve poter integrarsi con il modulo SIO - ADT/Pronto Soccorso sia per la gestione del percorso di dimissione protetta che per verificare episodi di ricovero o pronto soccorso per paziente in carico ai singoli applicativi. I servizi sono definiti all'interno del documento “Specifiche tecniche - COT v1.0” per gli ES che hanno avviato il Sistema Informativo Ospedaliero anche per la parte di ricoveri e pronto soccorso. Per quanto riguarda gli ES in cui non è stato avviato il Sistema Informativo Ospedaliero Regionale risulterà necessario garantire l'integrazione con gli attuali sistemi esistenti. Successivamente, quando il nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) verrà reso disponibile la soluzione dovrà integrarsi con quest'ultimo.

5.2. Accessibilità e usabilità

In termini di Accessibilità e Usabilità, il sistema dovrà rispondere ai seguenti requisiti di carattere generale:

- conformità ai requisiti normativi quali:
 - Linee guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici;
 - Norme di accessibilità così come stabilito dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 e ss.mm. (c.d. “legge Stanca”) e del successivo Decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
 - Norma UNI EN 301549:2021 (e ss.mm.ii.) che identifica gli standard a livello europeo;
 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
 - ove applicabile, il Decreto Legislativo 10 novembre 2022, n. 82, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), concernente i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ICT.
- adesione ad un modello user-friendly, con caratteristiche d'uso di semplicità, intuitività e omogeneità;
- essere dotata di un'interfaccia utente intuitiva e responsive, aderente ad un modello Human Centered Design (riferimento ISO 9241 - Ergonomics of Human System Interaction), allo scopo di consentire un'utile ed efficiente gestione dei contenuti, dei documenti e dei processi, nonché fornire una rappresentazione chiara, esaustiva ma al contempo ponderata dei dati.

Inoltre, le funzionalità del sistema devono essere accessibili in ambienti Android (tutte le versioni) e iOS (tutte le versioni) o Windows anche mediante appositi moduli predisposti per l'utilizzo su tali dispositivi (ad esempio laptop fino a 10”, tablet 8 o 10”, etc.).

L'interfaccia, pertanto, deve essere predisposta all'utilizzo tramite soluzioni touch e di immediata fruibilità, prevedendo adeguate caratteristiche dello schema grafico per l'utilizzo tramite touch (ad esempio adeguate dimensioni dei pulsanti e delle selezioni, etc.).

Il sistema dovrà garantire:

- possibilità di accesso al di fuori della rete aziendale tramite l'utilizzo di dispositivi mobili personali;
- accesso almeno dai principali browser senza installazione di software aggiuntivi;
- accesso all'applicativo attraverso le modalità sotto elencate (si veda inoltre Capitolo 4.8):
 - direttamente al sistema proposto attraverso integrazione, come indicato nei documenti allegati;
 - l'autenticazione deve avvenire in accordo alle specifiche "GDL-O Sicurezza Infrastruttura di Sicurezza", e – laddove richiesto - attraverso integrazione con LDAP;
- rapidità di accesso alle funzioni chiave del sistema (ad esempio presenza di menù generale con le aree applicative principali);
- presenza in ogni schermata delle informazioni critiche sul paziente configurabili (ad esempio anagrafica);
- supporto agile al work-flow clinico-assistenziale (ad esempio passaggio rapido tra le fasi di inquadramento, diagnosi, rilevazioni);
- visualizzazione dell'intero percorso clinico del paziente in forma cronologica e sintetica, dando, inoltre, la possibilità di accedere al dettaglio di ciascun evento clinico occorso;
- agli operatori di mettere in risalto le informazioni ritenute più rilevanti, quali: eventi critici occorsi, prossimi esami/accertamenti (tali informazioni dovranno essere organizzate in modo omogeneo e con una nomenclatura chiara e pertinente);
- accesso tramite standard W3C.

Si riportano di seguito ulteriori requisiti da soddisfare:

- il sistema, in tutte le sue funzionalità, deve essere altamente ergonomico. Affinché la navigazione risulti fluida, l'operatività deve tradursi in sequenze di comandi intuitive, con evidenza immediata delle informazioni necessarie per l'attività dell'operatore, questo in tutte le funzionalità richieste;
- il layout grafico delle videate deve essere standardizzato per tutte le funzionalità descritte nel capitolato tecnico (ad esempio caratteristiche grafiche utilizzate per evidenziare i campi obbligatori, le funzioni disabilitate, i campi con scelte multiple, etc.) e delle modalità di selezione delle voci (ad esempio utilizzo del doppio click del mouse o unico "tap"), così come deve essere standardizzato l'utilizzo dei tasti funzione e della tastiera. L'interfaccia operatore deve consentire una facile e immediata individuazione delle informazioni richiedendo pochi passaggi per completare le funzionalità richieste;
- nelle principali funzioni deve essere dato un messaggio di conferma all'operatore al termine dell'operazione richiesta, qualora risulti necessario (ad esempio inserimento, modifica, cancellazione, etc.), in modo che non ci siano incertezze su quanto effettuato; tale caratteristica va prevista in modo selettivo per le funzioni più delicate che saranno individuate dal Committente, attraverso configurazione del sistema;
- il sistema deve consentire di proporre l'autocompilazione dinamica durante la digitazione (ad esempio ricerche google-like). Si intende con ciò: riempimento automatico del campo su cui si sta operando la digitazione; riempimento basato sul riconoscimento della stringa di testo in

immissione, il match della stessa con una lista di voci immissibili e la visualizzazione all'operatore, per un rapido inserimento, di detta lista;

- il sistema deve garantire l'elaborazione automatica di quanto al momento digitato in correlazione ai dati già inseriti in altri form relativi all'evento stesso (anche da altri operatori), generando dei warning nel caso di anomalie;
- i pulsanti che richiamano altre applicazioni devono poter formulare gli URL, tramite web services, e con la gestione dei token di autenticazione in modalità sicura;
- gli operatori non devono avere la necessità di cambiare interfaccia operatore per svolgere le diverse attività; per poter garantire questa caratteristica, anche nel futuro, il sistema deve rispondere a requisiti di espandibilità che permettano di inglobare nuove componenti funzionali anche se forniti da terze parti, come già riportato nel punto precedente;
- devono essere previste modalità di login e logout rapide per semplificare l'utilizzo del sistema da più operatori e deve essere indicato in maniera chiara il nominativo dell'operatore loggato al momento;
- dev'essere prevista la possibilità di configurare il sistema in modo che effettui il logout automatico dopo un intervallo di tempo di inattività prestabilito;
- non deve essere necessario installare strumenti di *office automation* a bordo delle postazioni utilizzate (anche per funzionalità di generazioni documenti);
- il sistema deve esporre un'interfaccia operatore in lingua italiana;
- la progettazione e l'architettura del sistema deve garantire elevati livelli di sicurezza: nello specifico si vuole implementare l'utilizzo del sistema informatico via web (con protocollo https), per poterne consentire l'agevole utilizzo da parte degli operatori in contesti al di fuori dell'Azienda (ad esempio su dispositivi mobili in reperibilità, o in ambiti di mobilità/portabilità, senza dover utilizzare sistemi di VPN);
- le funzionalità del sistema utilizzate in "mobilità" da parte degli operatori (tipicamente invio, eseguito, visualizzazione e manipolazione degli oggetti multimediali, anamnesi, esame obiettivo, richieste esami/prestazioni e consultazione, rilevazione parametri, prescrizione e somministrazione terapie, etc.) devono essere fruibili da dispositivi mobili (tablet medicali, smartphone, monitor touch) in ambienti Android (tutte le versioni) e iOS (tutte le versioni) o Windows anche mediante appositi moduli predisposti per l'utilizzo su tali dispositivi (ad esempio laptop fino a 10", tablet 8 o 10", etc.). L'interfaccia, pertanto, deve essere predisposta all'utilizzo tramite soluzioni touch e di immediata fruibilità, prevedendo adeguate caratteristiche dello schema grafico per l'utilizzo tramite touch (ad esempio adeguate dimensioni dei pulsanti e delle selezioni, etc.). Si evidenzia che il sistema offerto dovrà, comunque, essere "responsive", non prevedendo l'utilizzo di moduli appositi per le funzionalità su dispositivi mobili e/o touch. Saranno valutati positivamente i sistemi che presenteranno soluzioni "responsive" in fase di presentazione dell'offerta. Per la sicurezza del dato, qualora nel dispositivo mobile siano memorizzati dati in locale, questi devono essere automaticamente cifrati;
- deve essere consentita la presenza simultanea di mouse, tastiera e touch (con gestione del "terzo tocco" per l'utilizzo di funzioni quali il CTRL-ALT-CANC direttamente sul monitor touch) per l'utilizzo da parte dell'operatore;
- deve essere garantita la compatibilità con almeno tre dei più diffusi browser presenti sul mercato, purché il browser rispetti le normative e circolari vigenti in tema di sicurezza;

- deve essere messo a disposizione, in tutte le aree applicative della soluzione applicativa offerta, un sistema di condivisione di informazioni, quali ad esempio informative, file documenti, note per gli operatori, etc. Le informazioni possono essere pubblicate da parte di ruoli/profili autorizzati, con possibilità di avere bacheche differenziate per singola funzionalità;
- ogni modulo descritto nel presente capitolato deve disporre di una funzionalità di ricerca e filtri tramite soluzioni avanzate tipo motori di ricerca, anche con l'inserimento parziale delle informazioni. I campi utilizzati nei filtri di ricerca devono essere altamente configurabili anche da operatori “non esperti”.

5.3. Efficienza ed Efficacia

La ridondanza del dato dovrà essere minimizzata al fine di ottenere maggior correttezza e puntuale aggiornamento.

Dovrà essere evitata, tramite specifici controlli sui campi, l'eventualità che gli operatori omettano dati fondamentali per il percorso di cura o li scrivano in modo incompleto o sintatticamente scorretto.

È necessario che il sistema sia in grado di fornire una reportistica su temi quali: indicatori chiave di processo, gestione del rischio clinico, inconsistenze nei dati inseriti, statistiche a vari livelli sui casi clinici trattati (patologie manifestate, procedure/azioni terapeutiche attuate a livello medico ed infermieristico, prescrizioni e somministrazioni adottate, utilizzo di dispositivi, ecc.), statistiche di utilizzo dell'applicativo, e così via.

Il sistema dovrà prevedere sistemi di alert clinici significativi, automatici, oltre che di proposta di compilazione automatica di campi sulla base di altri elementi.

È opportuno distinguere gli alert clinici significativi, scelti da parte dell'ES dopo condivisione interna con i professionisti, e gli “avvisi” che possono essere anche molto più numerosi, contestualizzati in specifici percorsi, pur sempre di univoca interpretazione e definizione a livello aziendale.

A tal proposito, il sistema dovrà prevedere dei meccanismi che consentano, nel caso in cui vengano apportate modifiche ad informazioni contenute nel sistema stesso, di notificare all'utente che esiste una versione nuova e aggiornata di tale informazione.

Il sistema dovrà, inoltre, prevedere un sistema di notifica che informi il personale del centro su attività/promemoria in scadenza sul paziente (es. scadenza validità referti).

Il sistema dovrà, inoltre, garantire un livello minimo per quel che riguarda le prestazioni ed in particolar modo i tempi di risposta delle diverse schede che la compongono, anche a fronte di richieste multiple provenienti dai diversi utenti.

Un'adeguata registrazione delle informazioni può rendere più efficiente l'erogazione delle prestazioni aumentando il tempo che il professionista può dedicare al paziente e aumentare la soddisfazione del paziente facilitando attività integrate con l'erogazione della prestazione (prescrizioni di farmaci e accertamenti, certificazioni).

Per quanto concerne le transazioni di front-end (ad esempio apertura di singole schermate popolate con i dati del sistema), si ritiene che il tempo di risposta massimo debba essere di norma

inferiore ai 2 secondi (in caso di interazioni non dipendenti da sistemi terzi), con tempo di risposta frustrazione (F) massimo di 8 secondi, come descritto nel Capitolo “Livelli di Servizio”.

La misurazione si baserà sul tempo intercorrente tra il ricevimento della richiesta da parte del dispositivo di collegamento (router o similare) e il ricevimento della risposta al medesimo punto. Tale tempo di risposta deve essere confermato in sede di aggiudicazione, verificato in fase di collaudo e monitorato in esercizio. A tal fine il Committente metterà in opera sistemi di monitoraggio finalizzati a tale analisi, oltre al sistema di monitoraggio che comunque deve mettere a disposizione il Concorrente stesso.

5.4. Disponibilità

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- tutti gli aggiornamenti di tipo minor del sistema devono essere possibili “a caldo”, senza fermi del sistema (se non in termini di “secondi” per l’eventuale riavvio dei servizi), in modo da garantire la piena continuità delle cure, mentre gli aggiornamenti di tipo major possono prevedere dei fermi macchina, fino a un massimo di 4 ore l’anno, salvo deroghe concordate con il Committente;
- al fine di garantire la massima granularità nella metodologia di sviluppo, in base alle organizzazioni nelle quali deve essere attivato l’impianto, è preferibile che i sistemi proposti prevedano un’architettura sviluppata con applicazioni composite e micro servizi tramite la tecnologia di “software container”, al fine di permettere la massima integrabilità tra le funzionalità oggetto del capitolato e i sistemi terzi, nonché la massima elasticità e velocità nelle fasi di modifica e sostituzione di “parti” di processo rappresentato dal sistema;
- al fine di gestire un miglioramento continuo della qualità dei dati e pronta risposta alle esigenze di processo aziendali, il sistema deve essere strutturato in una logica di business workflow, con la possibilità di implementare campi obbligatori e sistemi di controllo relativamente alla gestione dei processi (ad esempio possibilità di creare un referto solo se compilate alcune sezioni etc.). Queste parametrizzazioni devono essere attuabili direttamente da personale “amministratore” adeguatamente formato, ovvero senza ricorrere a sviluppi o contattare il Fornitore;
- nel supporto alle attività del medico, i sistemi devono includere tecnologie operative facilitanti;
- il sistema proposto (sia strutturale sia concettuale) deve essere di tipo PRIVACY BY DESIGN, ovvero deve considerare nelle fasi di progettazione, realizzazione, implementazione e gestione dei sistemi, la riservatezza e la protezione dei dati personali, garantendo le seguenti caratteristiche:
 - proattività e non reattività (prevenire non correggere);
 - privacy come impostazione di default;
 - privacy incorporata nella progettazione;
 - massima funzionalità – Valore positivo, non valore zero;
 - sicurezza fino alla fine – Piena protezione del ciclo vitale;
 - visibilità e trasparenza – Mantenere la trasparenza;
 - rispetto per la privacy dell’assistito – Centralità dell’assistito.

Per quanto concerne le transazioni di front-end (ad esempio apertura di singole schermate popolate con i dati del sistema), si ritiene che il tempo di risposta massimo debba essere di norma inferiore ai 2 secondi (in caso di interazioni non dipendenti da sistemi terzi), con tempo di risposta frustrazione (F) massimo di 8 secondi.

La misurazione si baserà sul tempo intercorrente tra il ricevimento della richiesta da parte del dispositivo di collegamento (router o similare) e il ricevimento della risposta al medesimo punto. Tale tempo di risposta deve essere confermato in sede di aggiudicazione, verificato in fase di collaudo e monitorato in esercizio. A tal fine il Committente metterà in opera sistemi di monitoraggio finalizzati a tale analisi, oltre al sistema di monitoraggio che comunque deve mettere a disposizione il Concorrente stesso.

Per i sistemi richiesti in modalità cloud, risulta vincolante la non interdipendenza elaborativa tra i processi attivi (front-end, batch) al fine di evitare un degrado sulle prestazioni.

La ridondanza del dato dovrà essere minimizzata al fine di ottenere maggior correttezza e puntuale aggiornamento.

La completa disponibilità dei dati clinici dovrà essere garantita sempre e dovunque, anche a fronte di un malfunzionamento del sistema, dell'infrastruttura di comunicazione o di altri sistemi applicativi integrati dell'ES.

Il sistema dovrà essere coerente con il contesto organizzativo dell'ES e le relative procedure di emergenza e *business continuity*.

5.5. Estendibilità e scalabilità

Il sistema dovrà essere fornito come una soluzione scalabile ed estendibile in termini tecnologici e le parti della stessa dovranno essere in grado di adeguarsi ai mutamenti tecnologici e all'interazione con componenti esterne.

Deve essere garantita pertanto la massima scalabilità, al fine di gestire il pronto e completo supporto sia agli aggiornamenti normativi, sia all'evoluzione dei requisiti funzionali e dimensionali dovuti alle mutate esigenze in termini di funzioni applicative e numero di utenti.

Il sistema deve inoltre garantire nel tempo la possibilità di estendere ed evolvere i servizi in funzione della disponibilità e diffusione di tecnologie abilitanti.

Dovrà essere possibile estendere di volta in volta il sistema con le funzionalità dei vari moduli o organismi dell'ES interessati a tali dati. I requisiti di scalabilità dovranno essere rispettati attraverso un giusto dimensionamento delle infrastrutture di calcolo, di rete, di archiviazione dati.

Il sistema dovrà possedere:

- scalabilità di carico, ovvero capacità di aumentare le prestazioni del sistema in funzione della potenza di calcolo complessiva dedicata alla sua esecuzione. Tale scalabilità è necessaria per far fronte al carico computazionale generato dall'ingente e sempre crescente numero di utenti utilizzatori del sistema;

- scalabilità geografica, intesa come capacità del sistema di mantenere inalterata la sua usabilità e utilità indipendentemente dalla distanza fisica dei suoi utenti o delle sue risorse. Nel sistema, dunque, dovranno essere integrate sedi periferiche dell'ES;
- scalabilità clinica, ovvero necessità di coprire specifiche esigenze del processo di cura in vari ambiti operativi. Essa dovrà essere garantita sia dalla flessibilità del sistema in oggetto, sia dalla presenza di moduli applicativi verticali integrati con il sistema aziendale stesso. Queste valutazioni dovranno essere condotte di concerto con la funzione aziendale preposta al governo dell'architettura del Sistema Informativo Aziendale, nell'ottica di salvaguardare la coerenza del Sistema Informativo Aziendale;
- scalabilità amministrativa, ovvero mantenere inalterata la sua gestibilità indipendentemente da quante organizzazioni lo utilizzano.

5.6. Tracciabilità ed esibizione

Il sistema dovrà garantire la tracciabilità totale delle operazioni, ossia dovrà tener traccia, per ciascuna operazione di accesso, visualizzazione, inserimento, modifica o importazione, delle informazioni relative a data, ora e autore della operazione, dandone evidenza a livello di interfaccia ove richiesto.

Il sistema dovrà garantire che, fatte salve le eventuali bozze (contenuti per cui è ammissibile l'inserimento in via provvisoria e non validati), le informazioni registrate siano modificabili solo tramite versionamento del dato e del documento. Il tracciamento delle operazioni deve essere sempre ricostruibile e deve mantenere inalterata la sua consultabilità nel tempo. In particolare, il sistema dovrà assicurare la tracciabilità di tutte le attività (documenti, annotazioni) inserite mediante la loro associazione con l'autore, la data e l'ora della registrazione. L'identificazione della data ed ora di una registrazione viene effettuata mediante tempo di sistema del server. Tutte le componenti della fornitura dovranno essere sincronizzate con il sistema di timing aziendale. Dovrà altresì essere reso disponibile giornalmente in formato elettronico (secondo modalità da condividere durante la fase esecutiva del progetto) l'informazione del dettaglio dei documenti prodotti per consentire la verifica di completezza ai fini della conservazione legale. Attività quest'ultima che resterà in carico all'azienda appaltante.

Inoltre, il sistema dovrà garantire la storicizzazione delle varie versioni di tutti i documenti gestiti (versionamento), ai fini della riproducibilità nel tempo. I documenti dovranno poter essere storicizzati con i relativi consensi e livelli di privacy anche nel dossier aziendale.

Il sistema dovrà altresì consentire la possibilità di attivazione una validazione/approvazione esplicita, da parte dei soggetti autorizzati, dei documenti/dati ricevuti automaticamente da fonti esterne (ad esempio referti, dati di laboratorio, di monitoraggio, ecc.). Qualora attivata, eventuali documenti/dati non ancora validati e quindi non facenti ancora parte del sistema, dovranno comunque essere fruibili dando evidenza del loro stato di validazione.

I documenti importati nel sistema secondo le modalità precedentemente definite dovranno essere archiviati in formato nativo sullo storage aziendale e da questi recuperati dall'applicativo in modalità trasparente all'utente. Tali documenti non dovranno essere archiviati in campi blob all'interno del database. Più in generale tale modalità se presente dovrà essere rivista nell'ottica di cui sopra.

L'estrazione di copie analogiche di originali informatici, seppur possibile, dovrà avvenire con indicazione chiara della fonte e nel rispetto di eventuale regolamentazione aziendale.

È richiesta la possibilità di firmare digitalmente la documentazione prodotta dal sistema oggetto del presente capitolato tramite il sistema aziendale di firma massiva. Dovrà altresì essere reso disponibile giornalmente in formato elettronico (modalità da condividere) l'informazione del dettaglio dei documenti prodotti per consentire la verifica di completezza ai fini della conservazione legale. Attività quest'ultima che resterà in carico all'azienda appaltante.

Infine, è gradita la possibilità di raccogliere durante il processo la firma grafometrica dei pazienti (ed eventualmente degli operatori) tramite appositi tablet.

5.7. Gestione utenze

Deve essere prevista, in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (2016/679), e ss. mm. ii. (D.Lgs. 101/2018 e successivi), la possibilità in ciascun modulo del sistema di estrarre l'elenco o la matrice di tutti gli operatori con indicato:

- profilo;
- funzioni autorizzate extra profilo;
- per ogni funzione autorizzata le modalità di accesso ai dati (lettura, inserimento, modifica, etc.).

Tale elenco o matrice deve essere accessibile in tempo reale dai Responsabili di procedura e/o del trattamento dei dati, per avere sempre sotto controllo le relative abilitazioni. La funzione deve disporre di un layout facilmente consultabile dagli operatori, con possibilità di drill down o di esplosione dell'elenco (ad esempio per vedere le singole funzioni previste dal profilo).

5.8. Affidabilità e Sicurezza

Qualora l'erogazione dei servizi/soluzioni IT da parte del Fornitore comporti il trattamento dei dati personali tale trattamento è soggetto all'applicazione delle normative (GDPR) e alle disposizioni, interne all'azienda, che interessano tale ambito. A tale proposito, il Fornitore riconosce e garantisce di aver fatto tutto quanto necessario al fine di conformarsi alla normativa e alle disposizioni applicabili in materia di tutela dei dati personali e/o sensibili che comporti il trattamento dei medesimi dati da parte del Fornitore, saranno eseguite in piena conformità al "GDPR" vigente.

Il sistema deve garantire le misure minime di sicurezza proposte da AGID. Pertanto, dovrà essere garantito:

- monitoraggio e gestione dei sistemi di salvataggio dati su Cloud, analisi dei report, verifica giornaliera della corretta esecuzione dei backup;
- aggiornamento periodico della documentazione di sistema;
- aggiornamento periodico del software, per garantire i più elevati standard di sicurezza e gestire le vulnerabilità;
- attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- il sistema deve essere sviluppato tenendo conto dei principi del "ciclo di vita del software" e della "analisi del rischio", secondo le norme tecniche (o principi e metodologie almeno equivalenti) e le best practice internazionali; in ogni caso non dovranno utilizzare librerie

deprecate e/o obsolete, né dovranno essere scritti e sviluppati con versioni del linguaggio di programmazione fuori supporto tecnico del fabbricante o a fine ciclo di vita (end-of-life) e comunque non dovranno trovarsi in tale stato per tutta la durata contrattuale;

- il sistema deve essere mantenuto e gestito in modo da conservare e mantenere stabili nel tempo tutte le caratteristiche possedute al momento del collaudo definitivo.

Dovrà essere garantita la manutenzione per l'intera durata dell'appalto, al fine di salvaguardare la possibilità da parte dell'Azienda di mantenere l'aderenza agli standard nel tempo.

Uno degli obiettivi primari del servizio di manutenzione è la continuità di servizio, inteso come perfetto e continuo funzionamento delle singole componenti, nonché come perfetto e continuo funzionamento delle integrazioni funzionali tra i diversi componenti.

5.9. Reporting, monitoraggio e stampe

Il sistema proposto deve essere dotato di un sistema di reporting configurabile secondo i fabbisogni delle Aziende. Tale sistema di monitoraggio dovrà essere aggiornato con dati in tempo reale. In particolare, il sistema dovrà consentire il monitoraggio degli indicatori previsti dalle linee di indirizzo regionali. Dovranno essere garantiti dei tempi di risposta adeguati a tutte le elaborazioni, senza comportare rallentamenti sulle funzionalità del sistema.

La modulistica e le stampe prodotte in tutte le aree applicative della fornitura devono avere intestazioni (quali ad esempio, la denominazione e il logo dell'Ente Sanitario e della specifica struttura, etc.) personalizzabili.

La creazione di nuova documentazione o la revisione della documentazione presente deve essere possibile a cura del personale aziendale preposto (o di personale di presidio del Fornitore), senza necessità di intervento del gruppo di sviluppo del Fornitore, tramite sistemi di generazione e modifica delle stampe semplici e intuitive con utilizzo limitato di codice di programmazione.

Le stampe e i report prodotti dal sistema devono prevedere meccanismi atti a garantire la stampa per intero dei campi inseriti nei template di stampa. Non devono cioè essere possibili stampe mancanti di parti, rispetto alle informazioni dei campi compilate a video.

Relativamente alla reportistica e alla gestione di dati ai fini di rendicontazione e analisi a livello di Servizio/U.O. e sovra-articolazioni, i report e gli elenchi disponibili nei diversi moduli devono poter essere esportati verso i più comuni strumenti di elaborazione individuale (ad esempio excel, formati .csv, .odf, etc.), e deve essere garantita la possibilità di definire calcoli automatici di indicatori di dettaglio e generici (ad esempio per scale di valutazione).

5.10. Garanzie di performance

L'infrastruttura deve dare garanzia di elevate performance anche in presenza di notevoli livelli di carico e un elevato numero di contatti giornalieri.

Il software deve gestire nativamente problematiche di concorrenza legate alla scrittura/accesso ai dati.

6. ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO

Nel presente Capitolo viene descritto il modello architetturale di Azienda Zero, nel quale dovrà essere collocato il Sistema Informativo Territoriale e i relativi requisiti architettureali.

6.1. Contesto Azienda Zero

Il contesto architetturale di Azienda Zero è descritto approfonditamente nel documento di Reference Architecture di Azienda Zero. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto inserito in tale documento e allinearsi ai successivi eventuali aggiornamenti, che verranno predisposti indicativamente ogni 6 mesi.

6.2. Architettura del sistema

6.2.1. Modello architetturale

Il modello architetturale si deve basare su una logica a microservizi. I dettagli di tale modello sono definiti nel documento di Reference Architecture di Azienda Zero. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto inserito in tale documento e allinearsi ai successivi eventuali aggiornamenti, che verranno predisposti indicativamente ogni 6 mesi. Specificatamente, l'implementazione a microservizi del sistema deve prevedere un insieme di servizi autonomi e rendere il sistema ancora più scalabile. La gestione di un micro-servizio non deve influire sugli altri e consente di scegliere lo stack tecnologico più adatto in maniera completamente indipendente dal resto dell'architettura. L'accessibilità del singolo microservizio dev'essere garantita da API specifiche che fungono da interfaccia e lo rendono interoperabile anche con gli applicativi terzi che interagiscono con il sistema.

6.2.2. Elementi software

Il sistema proposto deve includere tutti i moduli applicativi necessari a supportare i processi descritti permettendo l'attivazione indipendente di ognuno di essi a seconda dello scenario implementativo richiesto in ciascuno degli Enti Sanitari. In particolare, oltre alle componenti funzionali devono essere previsti moduli dedicati all'integrazione dati da e verso i sistemi informativi di ospedali e Azienda Zero.

Per quanto riguarda le componenti che si occupano di reportistica e business intelligence, è richiesta la possibilità di integrare i dati generati dal sistema con dati provenienti da fonti esterne al fine di fornire vista e correlate adeguate ai requisiti funzionali.

6.2.3. Connettori e interfacce

Le funzionalità del sistema in esame richiedono lo scambio di informazioni e di contesti applicativi con le altre componenti del Sistema Informativo attraverso connettori ed interfacce applicative che consentano l'utilizzo integrato delle funzioni svolte dai diversi componenti. Questi connettori ed interfacce dovranno essere implementate attraverso servizi di cooperazione progettati in funzione delle specifiche modalità di interazione con gli altri componenti.

AZIENDA_ZERO – Appalto Specifico ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della Regione Veneto – ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2365 - LOTTO 3 Capitolato Tecnico

6.2.4. Infrastruttura tecnologica e caratteristiche dimensionali

Il sistema oggetto di fornitura dovrà avvalersi della infrastruttura tecnologica indicata dal Committente, che nel caso specifico sarà il Polo Strategico Nazionale (PSN), oppure altra infrastruttura cloud messa a disposizione dal Committente. La fornitura dovrà includere anche i servizi di gestione sistemistica, manutenzione, monitoraggio e gestione della sicurezza.

6.3. Il contesto organizzativo - geografico

6.3.1. Elementi software (es. moduli, componenti, servizi, DB, etc.)

Il sistema proposto deve includere tutti i moduli applicativi necessari a supportare i processi in ambito permettendo l'attivazione indipendente di ognuno di essi a seconda dello scenario implementativo richiesto in ciascuno degli Enti Sanitari. In particolare, oltre alle componenti funzionali devono essere previsti moduli dedicati all'integrazione, come definito nel Capitolo dedicato.

Se verrà fornito un DWH dove si potranno fare elaborazioni, i dati dovranno essere aggiornati in tempo reale. Dovranno essere garantiti dei tempi di risposta adeguati per tutte le elaborazioni senza avere rallentamenti sul sistema sia che avvenga su dati presenti su DB o su un possibile DWH.

In mancanza di rete o guasti regionali o locali o di altro tipo di guasti il dipartimento dovrà poter svolgere le funzionalità indicate dal gruppo tecnico e al momento di ripristino del collegamento dovranno essere previste delle funzionalità di allineamento evitando problematiche di conflitto o di perdita di dati.

6.3.2. Integrazioni con altri software già presenti nel contesto di riferimento

Le integrazioni da prevedere sono descritte approfonditamente al Capitolo 5.2 – Interoperabilità e Integrazioni. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto inserito in tale documento e agli specifici allegati, e allinearsi ai successivi eventuali aggiornamenti di questi.

Gli obiettivi delle integrazioni indicate sono:

- snellimento dei processi;
- eliminazione di data entry e duplicazione dei dati;
- ricostruzione del percorso dell'assistito;
- dematerializzazione dei processi;
- fruibilità dei servizi digitali agli operatori e agli assistiti.

Gli oneri di integrazione lato terze parti (ad esempio fornitori, elettromedicali, etc.) sono a carico del Committente.

Nello specifico è richiesta l'integrazione almeno con i seguenti Software:

- la soluzione applicativa dovrà integrarsi con gli attuali sistemi esistenti. Successivamente, quando il nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) verrà reso disponibile il nuovo sistema dovrà integrarsi con quest'ultimo;
- Anagrafe 0 del SIO che include i dati dell'anagrafica unica regionale;
- Repository Aziendali;
- APMS;
- FSE;
- Piattaforma Regionale Telemedicina;
- CUP.

È altresì richiesto che vengano predisposti strumenti che consentano di effettuare interfacciamenti con SW di adozione futura.

Dovrà essere infine consentita, a seconda della tipologia di integrazione, la definizione di tempi e modi del processo di integrazione (sincrono real time a fronte della variazione del dato/asincrono ASAP con cadenza prefissata e configurabile).

6.3.2.1. Sistemi di firma digitale

Le funzionalità oggetto del presente capitolato tecnico, che necessitano di produrre documenti digitali, devono essere in grado di interfacciarsi con il sistema di firma presente nelle aziende messo a disposizione dal Committente.

Per la documentazione prodotta che deve essere firmata dall'assistito e/o operatori, il sistema offerto deve predisporre i servizi per l'interfacciamento con i sistemi esterni di firma qualificata (ad esempio firma grafometrica su tablet).

Per quanto riguarda la firma dei documenti, la procedura deve consentire:

- la gestione di firme multiple dello stesso documento da parte di operatori differenti per la gestione delle seguenti casistiche:
 - firma dello stesso documento da parte di operatori diversi;
 - firma di parti diverse del documento da parte di differenti operatori;
- la gestione di addenda, ovvero l'aggiunta di postille (dotate anch'esse di firma) a integrazione/modifica di un documento;
- il versioning, ovvero la gestione di versioni multiple del medesimo documento, da utilizzarsi nel caso sia necessario modificare un documento già firmato.

6.3.2.2. Ambienti tecnologici

L'infrastruttura a supporto del deve essere organizzata e dimensionata in modo tale di mettere a disposizione i seguenti ambienti:

- **PRODUZIONE (PR):** Ambiente operativo di erogazione del servizio.
- **TEST E COLLAUDO (TEST):** Ambiente non produttivo (ovvero con dati non riconducibili ad assistiti reali) per testare gli effetti degli aggiornamenti di prodotto, il rilascio di nuovi moduli e il collaudo dei moduli/funzionalità prima dell'installazione in produzione. Non deve interferire, in

nessun caso, sull'ambiente di produzione e deve essere integrabile con tutti gli altri sistemi/strumenti interessati al processo.

La gestione dell'ambiente di test include, inoltre:

- la verifica di aggiornamenti software (applicativi, sistemi operativi e software di base);
- verifica dell'installazione di nuovo software.

Tale ambiente, non produttivo (ovvero con dati non riconducibili ad assistiti reali), sarà utilizzato anche per tutte le **attività di formazione** e presentazione del sistema. Gli strumenti in questo ambiente sono almeno a pari livello di quanto già rilasciato e attivo in produzione, con possibile presenza di nuovi moduli già testati da rilasciare, per i quali sono necessarie attività aggiuntive di formazione.

Questo ambiente non operativo è da impostare sin dall'inizio del progetto.

Per le attività di **Labeling**, il fornitore potrà utilizzare un proprio ambiente interno, purché ottemperante alle misure minime di sicurezza, per espletare tutte le attività che si renderanno necessarie ai fini del soddisfacimento delle tempistiche progettuali, nelle more della messa a disposizione dell'infrastruttura cloud regionale,

– **BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY**

L'Aggiudicatario deve presentare una soluzione tecnica che garantisca la *business continuity* (BC) del servizio - ai sensi dell'art. 50-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale – intesa come piano d'insieme delle procedure e soluzioni tecnico-organizzative, accorgimenti e delle misure di reazione e risposta a eventi imprevisti che possono compromettere, anche parzialmente, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, il normale funzionamento dei servizi ICT utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e deve garantire i seguenti punti:

- produzione del Piano di Emergenza e di Continuità Operativa che deve essere presentato in sede di proposta;
- assicurare il servizio di copia e allineamento dei dati dei sistemi primari con i dati contenuti nei sistemi secondari;
- garantire che sia il sito che il piano e gli impianti di Disaster Recovery (DR) siano stati organizzati e progettati tenendo conto delle esigenze di continuità e manutenibilità dei data center, mettendo a disposizione dei siti alternativi di DR e garantendo:
 - l'assoluta sicurezza dei siti, ossia l'adozione di sistemi in linea con lo stato dell'arte, dell'evoluzione tecnologica e della normativa vigente al riguardo, assicurando la protezione da accessi non autorizzati, la presenza di gruppi di continuità e accorgimenti che garantiscano l'erogazione dell'elettricità senza interruzioni, la presenza di dispositivi antincendio e anti-allagamento nonché il rispetto dei requisiti richiesti da Regione del Veneto; la *fault tolerance* (tolleranza ai guasti) con possibilità di isolare l'apparato in *fault*, senza pregiudicare la continuità delle funzionalità e del servizio erogato;
 - la disponibilità a soddisfare le eventuali esigenze di crescita che fosse necessario fronteggiare nel corso dell'erogazione dei servizi di DR;
- predisporre le opportune misure di protezione per proteggere i dati, contenuti negli apparati storage dedicati alla soluzione di DR, da accessi non autorizzati;

- garantire gli interventi e le attività di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva nonché il costante aggiornamento tecnologico delle componenti software, senza oneri aggiuntivi per il Committente;
- garantire la manutenzione della soluzione di BC/DR e delle componenti software che compongono la cosiddetta configurazione di emergenza, assicurando i servizi per la riattivazione e il ripristino dei sistemi primari/di produzione a seguito di una condizione di emergenza di qualsivoglia tipo e la disponibilità delle componenti software della configurazione di emergenza.

L'Aggiudicatario si impegna a sottoporsi all'esecuzione di test periodici (almeno due volte l'anno), per simulare il funzionamento dei siti di DR in caso di disastro dei siti primari, al fine di verificare la corretta erogazione dei servizi e la costante adeguatezza della soluzione di DR e che sia altresì assicurato il corretto ripristino del funzionamento del sistema offerto.

L'Aggiudicatario deve porre in essere ogni attività di sua competenza per i test periodici previsti per la verifica della corretta funzionalità dei sistemi adottati per garantire la soluzione di DR, evitando di compromettere i dati di produzione durante le simulazioni e predisponendo copie dei dati a uso esclusivo della simulazione stessa da cancellare al termine delle prove.

L'Aggiudicatario deve porre in essere ogni attività di sua competenza nel verificare e testare le procedure formalizzate per garantire, in condizioni di funzionamento normale dei sistemi primari, le operazioni di allineamento. L'effettuazione del test deve essere concordata con Azienda Zero e le relative Strutture Sanitarie. Nel caso in cui il test non dovesse dare esito positivo, l'Aggiudicatario si impegna a ripetere il test in accordo con Azienda Zero e le relative Strutture Sanitarie, si impegna altresì a risolvere le criticità evidenziate, restando a suo carico ogni onere derivante dalle predette attività comprese le responsabilità da ciò derivanti.

I livelli di servizio sono indicati nel Capitolo "Livelli di Servizio" (Capitolo 10).

– **REPORTISTICA E ANALISI DATI**

Il sistema deve consentire di produrre report/estrazioni/indicatori su dati analitici, pseudoanonimizzati e di sintesi, agevolmente impostabili su ogni campo. In particolar modo deve permettere, a operatori opportunamente profilati, di impostare moduli di report standard/estrazioni/indicatori, integrabili e modificabili nel tempo, senza la necessità dell'intervento da parte del Fornitore aggiudicatario. Per ogni operatore, deve essere possibile impostare una classe di report/estrazioni/indicatori per ottenere immediatamente un cruscotto aggiornato in merito a determinate casistiche e parametri di interesse. Il sistema deve essere quindi in grado di soddisfare le esigenze derivanti dal fabbisogno informativo dettato a livello nazionale, regionale e aziendale sia a livello di servizio che di U.O. che delle sovra-articolazioni.

I dati devono essere messi a disposizione dei più comuni strumenti di produttività/ elaborazione individuale (es. Excel, formati .csv, .odf, .xml etc.) e per mezzo di API per l'integrazione con sistemi di BI aziendali. Nel caso di generazione di reportistica documentale presentare un layout personalizzabile (es. in termini di logo aziendale, data estrazione, etc.).

Tale funzionalità deve prevedere logiche di generazione di report/estrazioni/indicatori in modo da garantire tempi di risposta adeguati senza causare rallentamenti alle altre funzionalità del sistema, anche attraverso la generazione di quanto necessario in modalità asincrona.

6.4. Requisiti e Vincoli

Il sistema dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- garantire nel tempo l'allineamento del sistema all'evoluzione dell'Architettura Azienda Zero per quanto riguarda le versioni dei prodotti utilizzati;
- mantenere l'applicazione allineata alle nuove versioni dei prodotti/framework utilizzati, ovvero l'applicazione non dovrà utilizzare versioni di prodotti prossimi a "end-of-life" e/o "end-of-support";
- tutte le componenti all'interno dell'immagine container sono considerate componenti applicative, e quindi di competenza del fornitore;
- gestire adeguatamente la tracciatura degli eventi (log audit);
- ciascun componente architetturale del sistema dovrà essere progettato in modo da poter lavorare in alta affidabilità e in modo che un singolo failure non comporti un'interruzione del servizio;
- il sistema deve dare garanzia di elevate performance anche in presenza di notevoli livelli di carico e un elevato numero di contatti giornalieri. Per quanto concerne le transazioni di front-end (ad esempio apertura di singole schermate popolate con i dati del sistema), si ritiene che il tempo di risposta massimo debba essere di norma inferiore ai 2 secondi.

In fase di esecuzione saranno regolamentate le modalità di interazione con Azienda Zero e saranno profilate le utenze del Fornitore per poter accedere alla gestione delle componenti non comprese nella RA.

7. SERVIZI PROFESSIONALI

L'iniziativa dovrà essere accompagnata da una gamma di servizi professionali di natura tecnica e gestionale atti a supportare la transizione al nuovo servizio, nonché orientati alla efficace operatività del sistema stesso.

7.1. Servizi gestionali e applicativi

Project management dell'iniziativa: rientrano in queste attività il coordinamento gestionale e amministrativo dell'iniziativa complessiva ed il supporto agli ES nella gestione dei singoli cantieri di lavoro per tutta la durata dell'iniziativa.

Analisi, Progettazione, Predisposizione del sistema: rientrano in queste attività la progettazione, realizzazione e declinazione sul contesto veneto della suite di servizi e soluzioni applicative facenti parte del sistema in oggetto. Queste attività riguarderanno il periodo dall'inizio della Fornitura al termine del transitorio di attivazione del nuovo sistema sugli ES. In particolare, tali attività riguarderanno:

- la definizione delle specifiche funzionali e di interfaccia;
- la definizione delle specifiche di interfaccia e integrazione verso i sistemi informativi esterni;
- la definizione delle specifiche tecniche del software;
- l'implementazione del software;
- il test delle componenti e dei moduli del software.

Delivery, supporto alla messa in esercizio e altri servizi gestionali connessi al governo delle installazioni: rientrano in queste attività tutti quei servizi di supporto alla fase di implementazione del sistema, della sua diffusione, del supporto operativo all'attivazione del sistema presso le diverse sedi degli ES e del governo complessivo del sistema, tra cui il supporto alla gestione della domanda, alla pianificazione delle implementazioni e delle evoluzioni, alla diffusione del sistema, ai servizi per la gestione del cambiamento e la formazione e supporto tecnico-specialistico agli ES. Particolare attenzione dovrà essere riservata a supportare i singoli ES nella fase di transizione al nuovo sistema. In particolare, si richiede al Fornitore di:

- individuare, in base alle esigenze degli utenti, le migliori soluzioni alle problematiche emerse;
- definire le check-list di verifica per le funzionalità rilasciate;
- fornire il supporto alle validazioni;
- organizzare e svolgere il **servizio di formazione** per tutti i professionisti e operatori sanitari coinvolti nell'utilizzo del nuovo sistema;
- fornire l'attività di configurazione locale del sistema, sotto le indicazioni dei responsabili degli ES;
- organizzare e svolgere il servizio di **supporto operativo** all'avvio del sistema presso il singolo ES e per il tempo necessario;
- **servizio di presidio on-site** per tutto il periodo contrattuale per tutti gli ES;
- **definire** con gli ES i piani dettagliati degli interventi previsti con la descrizione delle attività unitamente alla durata e alle date previste di fine lavoro.

Servizi di integrazione tra il sistema e quanto previsto al Capitolo 5.2.

Manutenzione, assistenza e supporto applicativo: rientrano in queste attività i servizi di manutenzione (correttiva, adeguativa, normativa ed evolutiva) del software in esercizio e l'assistenza a tutti gli utenti del sistema in oggetto, a partire dal completamento della prima attivazione della Fornitura fino al termine del contratto. Si ritengono incluse in questa classe di servizi gli aggiornamenti tecnologici (comprese le major release) del sistema fornito rilasciati nel corso della durata della Fornitura. Tenendo conto della criticità dei processi coinvolti il servizio di assistenza e supporto applicativo, dovrà essere in grado di garantire una elevata capacità di intervento e fornire prestazioni documentabili.

Gestione operativa delle installazioni, tuning e monitoraggio del sistema: rientrano in queste attività tutti i servizi di manutenzione, assistenza ed esercizio del sistema sia nella sua versione originaria sia con le eventuali personalizzazioni, aggiornamenti e implementazioni introdotti nel tempo a partire dal completamento della prima attivazione della Fornitura fino al termine del contratto.

Pianificazione e realizzazione delle evoluzioni dei servizi: rientrano in queste attività tutti i servizi di vera e propria evoluzione del sistema complessivo e dei servizi correlati, intesi come sviluppo di nuovi sistemi e/o funzionalità specifiche (ad esempio sviluppo di software ad hoc), che potranno essere richieste dagli ES.

Exit Strategy: alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà garantire l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi oggetto di fornitura all'ES o ad una terza parte da esso individuata. Si rimanda al Capitolo 9.5.

7.2. Profili professionali

I profili professionali per l'erogazione dei servizi di cui sopra, saranno oggetto di valutazione da parte dell'ES, il quale potrà valutare il curriculum della risorsa e potrà effettuare un colloquio per valutarne l'aderenza delle competenze con quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico e con le finalità dell'attività da svolgere.

Si prega di far riferimento alle figure e alle relative caratteristiche previste all'Appendice 1A ("Profili professionali") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

8. GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

8.1. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali derivante dalla prestazione dei servizi di cui al presente affidamento dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente, «**Normativa Privacy**»), ossia del Reg. UE 2016/679, recante il «*Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali*» o «*GDPR*», del D.Lgs. 196/2003, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» o «*Codice Privacy*», dei Provvedimenti emanati dalle Autorità competenti italiane ed europee, delle norme in materia di digitalizzazione rilevanti ai fini della data protection.

A titolo meramente esemplificativo, si richiamano:

➤ **Norme fondamentali comunitarie e nazionali in materia di data protection:**

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche on riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, recante «*Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali*»;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e, da ultimo, dal Decreto-legge dell'8 ottobre 2021, n. 1339, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 3 dicembre 2021, n. 205, recante il «*Codice in materia di Protezione dei dati personali*»;

➤ **Provvedimenti e prassi Ue in materia di data protection (a titolo esemplificativo):**

- «*Guidelines 9/2022 on personal data breach notification under GDPR*» adottate dall'European Data Protection Board il 28 marzo 2023;
- «*Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access*», adottate dall'European Data Protection Board il 18 gennaio 2022, aggiornate da ultimo il 30 maggio 2024;
- «*Linee-guida 01/2021 su esempi riguardanti la notifica di una violazione dei dati personali*», adottate dall'European Data Protection Board il 14 dicembre 2021;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni «*relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana*» (COM/2018/233/final del 25 aprile 2018);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, recante «*Una strategia europea per i dati*» (COM/2020/66/final del 19 febbraio 2020);
- Raccomandazione della Commissione Europea dell'8 aprile 2020, recante «*on a common Union toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonymised mobility data*»;

- «Linee Guida 4/2019 in materia di Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita» adottate dall'European Data Protection Board il 20 ottobre 2020;
 - «Linee-guida 03/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell'emergenza legata al Covid-19», adottate dall'European Data Protection Board il 21 aprile 2020;
 - «Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato ai fini del regolamento (UE) 2016/679», adottate dal WP29 il 4 aprile 2017 e modificate il 4 ottobre 2017;
 - «Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679», adottate dall'European Data Protection Board il 4 maggio 2020;
 - «Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679», adottate dall'European Data Protection Board il 10 ottobre 2022 e modificate il 28 marzo 2023, che vanno ad aggiornare le precedenti linee guida WP250 (rev. 01) adottate dal WP29 e approvate dall'European Data Protection Board il 25 maggio 2018;
- **Provvedimenti e prassi UE in materia di tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione (a titolo esemplificativo):**
- Parere 5/2014 «sulle tecniche di anonimizzazione», adottato dal Gruppo di Lavoro W29 il 10 aprile 2014;
 - «Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19», adottate dall'European Data Protection Board (EDPB) il 21 aprile 2020;
 - «Pseudonymisation techniques and best practices», adottato dall'European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) il 3 dicembre 2019;
 - Regolamento UE 2018/1807 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 14 novembre 2018, «relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea»;
 - Sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia UE, «Tutela dei dati personali – Procedura di indennizzo degli azionisti e creditori in seguito alla risoluzione di un ente creditizio – Decisione del GEPD che dichiara che il CRU ha violato i suoi obblighi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 – Nozione di “dati personali” – Articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725 – Diritto di accesso al fascicolo» del 26 aprile 2013, Causa T-557/20;
 - Linee guida 01/2025 sulla pseudonimizzazione, adottate il 16 gennaio 2025 dall'European Data Protection Board;
- **Provvedimenti e prassi nazionali in materia di data protection (a titolo esemplificativo):**
- Provvedimento del 30 luglio 2019, adottato all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, «sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach)»;

- Provvedimento del 7 marzo 2019, adottato dall'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, recante *«Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario - 7 marzo 2019»*;
 - Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019, adottato dall'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, recante le *«prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101»*; Provvedimento dell'11 ottobre 2018, adottato dall'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, recante *«Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679»*;
 - Provvedimento del 29 aprile 2021, adottato dall'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, recante il *«Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico»*;
 - Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, adottato dall'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, recante *«Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche»*;
 - Provvedimento del 27 novembre 2008, adottato dall'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, recante prescrizioni *«ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema»*;
 - *«Linee Guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica»* - Allegato A al Provvedimento n. 513 del 12 novembre 2014 del Garante per la protezione dei dati personali;
- **Fonti regolatorie in materia di digitalizzazione (a titolo esemplificativo):**
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *«Codice dell'amministrazione digitale»*;
 - *«Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026»*, approvato con D.P.C.M. 12 gennaio 2024, e da ultimo aggiornato nel 2025;
 - *«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»*, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;
 - Determinazione AGID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021, recante *«Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione»*;
 - Circolare AGID 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante: *«Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni»*;
 - Legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante *«Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»*;
 - Circolare AGID del 9 aprile 2018, n. 2, recante *«Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA»*;
 - Circolare AGID del 1° ottobre 2018, n. 3, recante *«Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"»*;

- «Linee guida AGID sull'accessibilità degli strumenti informatici», adottate il 23 luglio 2020 e modificate il 21 dicembre 2022;
- «Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, emanate dall'AGID il 10 settembre 2020, così come modificate ai sensi della determinazione AGID n. 371/2021;
- Determinazione AGID n. 455/2021 del 25 giugno 2021, recante «Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici»;
- Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici ai sensi della lettera b) comma 3-bis articolo 73 e dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottate con determinazione AGID n. 547/2021;
- Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della lettera b) comma 3-bis articolo 73 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. adottate con determinazione AGID n. 547/2021;
- Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 adottato con Decreto del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in data 27 giugno 2024, prot. n. 21007.

Si precisa che il Fornitore, nel corso dell'intera durata del contratto, dovrà garantire pieno rispetto anche delle norme, dei provvedimenti e delle prassi in materia di data protection che dovessero intervenire nel tempo.

Fermo quanto sopra, nei sottoparagrafi successivi si descriveranno alcuni degli obblighi generali (connessi alla Normativa Privacy) e specifici (individuati sulla base delle peculiarità degli appalti oggetto di affidamento con la presente procedura) che il Fornitore dovrà rispettare ai fini della protezione dei dati personali.

Tutto quanto definito e richiesto dal presente Capitolato Tecnico dovrà essere garantito dal Fornitore e dai suoi eventuali subappaltatori/subcontraenti.

8.1.1. Obblighi generali del Fornitore in materia di protezione dei dati personali

Il Fornitore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche solo «**Responsabile**») dal titolare del trattamento (di seguito, anche «**Titolare**»), e dovrà, pertanto, operare in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 28 del GDPR, alle previsioni afferenti alla data protection che saranno contenute nel Contratto Esecutivo e alle istruzioni che saranno impartite dal Titolare medesimo nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

In ragione di quanto sopra e a titolo esemplificativo, il Fornitore dovrà:

- **sul piano organizzativo:** strutturare e mettere in atto un'organizzazione specifica per la protezione dei dati personali attraverso la definizione di un modello privacy, con individuazione di ruoli, funzioni e responsabilità, procedendo alla predisposizione delle necessarie policy e al conferimento delle nomine.

In tal senso, procederà ad individuare: (i) i soggetti “delegati” e i soggetti “autorizzati” al trattamento”, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy; (ii) gli “Amministratori di sistema” per le attività legate al presente appalto (v. Provvedimento del 27 novembre 2008).

Il Fornitore avrà facoltà di avvalersi di sub-fornitori, nelle modalità previste dall'art. 28 Reg. UE 2016/679 e dal Contratto Esecutivo;

- **sul piano delle misure di sicurezza:** il Fornitore dovrà adottare un approccio basato sul principio di Privacy by Design e by Default di cui agli artt. 25 e 32 del GDPR e alle «*Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default*», adottate dall'European Data Protection Board (EDPB) il 20 ottobre 2020. Di conseguenza, il Fornitore dovrà:
 - da un lato, predisporre fin dalla progettazione misure tecniche e organizzative adeguate (*data protection by design*), volte (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e (ii) ad integrare nel trattamento le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti del GDPR e a tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati;
 - dall'altro, dare effettiva attuazione alle suddette misure nell'ambito del trattamento, affinché siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari alla specifica finalità perseguita (*data protection by default*).

In tal senso, il Fornitore, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, dovrà tenere conto, tra l'altro, della tipologia di dati trattati, e dei rischi presentati dal trattamento, in particolare di quelli che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Fornitore dovrà inoltre rispettare gli adempimenti specifici posti dal GDPR in capo al titolare, nel caso in cui si verifichino violazioni dei dati personali (da intendersi, ai sensi dell'art. 4, n. 12 del Regolamento UE n. 679/2016, come «*la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati*»).

Sul punto, il Gruppo W29 ha predisposto apposite linee guida in materia di *data breach*. Ossia le «*Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679*», adottate il 3 ottobre 2017 con versione definitiva il 6 febbraio 2018, le quali specificano che le principali tipologie di violazione dei dati personali possono essere classificati come segue:

- **violazione della riservatezza**, in caso di divulgazione dei dati personali o accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
- **violazione dell'integrità**, in caso di modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali;
- **violazione della disponibilità**, in caso di perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di dati personali.

In caso di violazione dei dati personali, nel rispetto del GDPR e del Contratto Esecutivo, il Fornitore dovrà

- a) darne comunicazione al Titolare, immediatamente e, in ogni caso, non oltre le 24 ore, da quando il Fornitore medesimo, o un suo Sub-Responsabile, ha avuto conoscenza della violazione o ha avuto elementi per sospettare che sia avvenuta una violazione.

- b) collaborare con il Titolare, anche al fine di consentire il completamento del processo di notifica all'Autorità Garante, nelle (i) attività di indagine, al fine rilevare tutte le evidenze necessarie a valutare le cause, la natura e gli effetti della violazione dei dati personali, nonché (ii) nell'adozione delle azioni necessarie a mitigare qualsivoglia danno o conseguenza lesiva per i diritti e delle libertà degli Interessati e (iii) nella predisposizione e implementazione, previa approvazione del Titolare, di un piano di misure per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione dei dati personali simile a quella occorsa possa ripetersi in futuro.

Posto quanto sopra, il Fornitore dovrà rispettare i livelli minimi di sicurezza previsti dalle fonti indicate in premessa.

Il Fornitore dovrà inoltre supportare i Titolari nell'adozione di un **Protocollo di risposta**, consistente in una procedura interna volta a gestire e risolvere eventuali ipotesi di violazione dei dati personali. In particolare, nell'ambito di tale procedura, dovrebbero essere individuate:

- le modalità di investigazione e di indagine volte ad individuare la presenza di eventuali violazioni, nonché la natura e la portata della stessa, qualora si verifichi;
- i flussi di comunicazione delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti;
- le modalità di valutazione della violazione riscontrata;
- lo svolgimento delle eventuali notifiche, ove necessarie;
- le modalità di svolgimento di test periodici volti a verificare la validità del protocollo, nonché l'individuazione di eventuali correttivi allo stesso.

8.1.2. Previsioni specifiche materia di protezione dei dati personali

A specificazione e in aggiunta rispetto agli obblighi generali di cui al paragrafo precedente, il Fornitore dovrà:

- (a) garantire il pieno coordinamento con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel trattamento dei dati personali – quali, ad esempio, Regione, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Strutture sanitarie e socio-sanitarie, Comuni, Operatori economici – proponendo misure tecnico-giuridiche finalizzate all'integrazione e alla sinergia con gli stessi (ad es., procedure, protocolli operativi).

Tali strumenti dovranno assicurare la conformità dei trattamenti alla Normativa Privacy nel corso dell'intero ciclo di vita dei dati personali ed efficaci policy in materia di privacy, ad esempio con riferimento alla gestione degli eventi di data breach, in modo di consentire al Titolare di porre in essere le attività previste dalla Normativa Privacy medesima;

- (b) garantire il rispetto della data protection nell'ambito dell'intero ciclo di vita dei dati personali, anche mediante misure tecnico-organizzative differenziate a seconda del soggetto di volta in volta coinvolto (ad es., personale amministrativo, personale sanitario e socio-sanitario, ecc.).

A tal fine, il Fornitore dovrà tra l'altro garantire adeguata formazione nei confronti di ciascuna tipologia di soggetti coinvolti nei processi di digitalizzazione e predisporre apposite linee guide, manuali, moduli, flussi relativi ai processi e al ciclo di vita del dato;

- (c) individuare una figura che ricopra il ruolo di Privacy & Security Manager, che gestirà nel corso

dell'esecuzione contrattuale tutte le tematiche di Sicurezza e di Privacy afferenti alla commessa e che costituirà il referente unico per l'Azienda in merito alle suddette materie;

- (d) garantire il rispetto della normativa in materia di digitalizzazione (ad es., CAD e Linee Guida AGID), quali, ad esempio, le *«Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici»* di settembre 2020/maggio 2021; la Determinazione AGID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 in materia di *«Cloud della PA»* e il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, in materia di *«Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche»*;
- (e) supportare sul piano tecnico il Titolare nelle interlocuzioni con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (i.e. tematiche di data protection), l'Agenzia per l'Italia Digitale (i.e., tematiche di digitalizzazione), il Ministero della Salute (i.e., tematiche di governance sanitaria), l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (i.e., tematiche di sicurezza dei dati), ed ogni altra Autorità coinvolta nell'ambito dell'attuazione dell'appalto in questione;
- (f) effettuare specifiche analisi del rischio privacy (sulla base del principio di *privacy by design*), al fine di segnalare, in qualsiasi momento, al Titolare rischi, originari e/o sopravvenuti, connessi al trattamento e di individuare misure tecniche ed organizzative da adottare, anche ai fini di un'effettiva e costante tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Le metodologie di analisi del rischio dovranno essere preventivamente condivise con l'Azienda;
- (g) supportare il Titolare nello svolgimento *ex ante* delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati personali (o *«DPIA»*) in merito ai trattamenti che saranno posti in essere ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, conformemente all'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e alle migliori prassi UE e nazionali.

Il Fornitore, al fine di individuare eventuali criticità per ciò che concerne la Normativa Privacy e di apportare i necessari correttivi, dovranno effettuare e trasmettere al Titolare specifiche analisi del rischio anche sui prodotti software, in fase di progettazione e prima del loro sviluppo;
- (h) adottare, nell'ambito della progettazione dei sistemi, (i) misure idonee a garantire la "qualità ed esattezza del dato" (ossia la completezza, accuratezza, tempestività, coerenza, univocità, integrità, conformità dello stesso), (ii) nonché processi idonei a monitorare costantemente i flussi relativi ai processi e al ciclo di vita dei dati, segnalando immediatamente con appositi alert qualsiasi anomalia effettiva o potenziale;
- (i) adottare misure per l'acquisizione e la conservazione dei consensi (ove necessari in ragione degli specifici trattamenti, alla luce dei *«Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario»* resi dal Garante in data 7 marzo 2019) nel rispetto del GDPR (i.e., art. 7) e delle prassi UE e nazionali;
- (j) garantire che i dati personali siano trattati esclusivamente su infrastrutture localizzate all'interno dell'Unione europea, salvo documentate e motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che dovranno essere preventivamente approvate dal Titolare e fermo, in ogni caso, il rispetto degli artt. 45 e ss. del GDPR;
- (k) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con

il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

8.2. Gestione della sicurezza delle informazioni

Di seguito vengono riportate le misure di sicurezza atte a preservare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei servizi e delle informazioni che dovranno essere attuate dal Fornitore nell'ambito delle attività ad esso assegnate.

Il Fornitore dovrà garantire e monitorare l'applicazione delle prescrizioni di seguito descritte anche da parte degli eventuali suoi sub-fornitori, anche attraverso attività di audit pianificati e documentati.

Fermo restando che, la fornitura oggetto del contratto, per quanto di competenza, dovrà:

- rispettare le "Linee Guida per lo sviluppo del software sicuro" emesse dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- in caso sia a carico del fornitore l'individuazione dell'ambiente di destinazione dell'oggetto di fornitura, prevedere che il software sia installato su una infrastruttura qualificata in compliance con le disposizioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27 giugno 2024 per il trattamento di dati e servizi;
- rispettare gli obblighi minimi di competenza del Fornitore, così come previsti dalla Legge 90/2024 (Legge 28 giugno 2024, n. 90. Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici) e dalla Direttiva NIS 2 (UE 2022/2555).

8.2.1. Requisiti generali

Il Fornitore dovrà:

- garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni gestite nell'ambito di tutte le attività ad esso affidate;
- nell'ambito del trattamento dei dati e delle informazioni, ed in particolare nella comunicazione e trasmissione di informazioni, all'interno e all'esterno dell'organizzazione rispettare il principio di:
 - least privilege;
 - need-to-know;
 - segregation of duties.
- collaborare attivamente con il Titolare nell'applicazione delle misure di sicurezza previste;
- garantire, e/o collaborare a, la redazione di tutta la documentazione di Sicurezza e Privacy, in conformità agli standard definiti;
- utilizzare le procedure operative del Titolare al fine di assicurare la sicura e corretta operatività delle strutture di elaborazione delle informazioni del Titolare e, laddove il Fornitore operasse presso la propria sede e con proprie risorse deve documentare, aggiornare e curare la messa in pratica di adeguate procedure operative e documentare e monitorare tutti i cambiamenti apportati alle strutture di elaborazione delle informazioni e ai sistemi;

- prevedere la designazione di una figura che ricopra il ruolo di Security Manager, indicativamente corrispondente al profilo professionale Cloud Security Specialist definito dall'AQ, in termini di "focal point" per le tematiche di Sicurezza e Privacy, per la gestione degli eventuali eventi anomali, incidenti e sulle tematiche tecnologiche ed organizzative ovvero ad un eventuale piano di continuità operativa del Titolare, ivi comprese le attività di Disaster Recovery.

8.2.2. Requisiti di riservatezza

Il Fornitore dovrà:

- utilizzare i dati personali e le informazioni in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle attività svolte;
- utilizzare i dati personali e le informazioni solo ed esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione di quanto richiesto contrattualmente;
- non trattare i dati personali, ovvero le informazioni, diversi da quelli per i quali è stato espressamente autorizzato;
- garantire il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati personali e delle informazioni adottando tutte le misure, fisiche nonché tecnologiche, di sicurezza idonee;
- mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni trattati nello svolgimento di quanto richiesto contrattualmente, non diffonderli e non comunicarli a terzi salvo preventiva autorizzazione scritta del Titolare. L'obbligo di riservatezza in merito ai dati vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e sub-fornitori, per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, i dati e le informazioni, salvo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione dell'attività richiesta e sempre previa autorizzazione scritta da parte del Titolare; al termine delle attività richieste o comunque del contratto, restituire al referente del Titolare i dati e le informazioni oppure, se richiesto e applicabile, procedere alla loro distruzione, con modalità sicure e documentate, fornendone evidenza;
- comunicare immediatamente al referente del Titolare qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali e delle informazioni;
- cancellare in maniera sicura, secondo le tecnologie più adeguate, i dati e le informazioni presenti sui dispositivi (PC, Tablet, ecc.) in caso di dismissione e comunque al termine del contratto. Tutte le attività di dismissione sicura dovranno essere registrate e conservate fornendo al Titolare tutte le evidenze di quanto svolto durante tutto l'arco del contratto;
- mantenere e comunicare al Titolare un registro aggiornato delle manutenzioni svolte;
- nel caso in cui l'attività di manutenzione debba essere svolta all'esterno del Titolare, garantire che i dati personali e le informazioni contenute nei prodotti non siano accessibili;
- definire ed attuare delle procedure per il loro trattamento e memorizzazione dei dati e delle informazioni, anche ricorrendo all'utilizzo di cifratura. Nello specifico il Fornitore dovrà adottare

idonee procedure per la gestione, mantenimento e dismissione dei supporti di memorizzazione contenenti dati, ad esempio implementando metodi di sovrascrittura a più livelli o cancellazione sicura dei supporti. Tutte le attività di dismissione sicura dovranno essere registrate e conservate fornendo al Titolare tutte le evidenze di quanto svolto durante tutto l'arco del contratto.

È sempre vietata l'estrazione e il trasferimento di dati e/o di ogni altra informazione dalle basi dati e dai sistemi del Titolare, salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta.

8.2.3. Gestione del personale del Fornitore

Il Fornitore dovrà garantire che il proprio personale (dipendenti e collaboratori), abbia piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni. In particolare:

- il Fornitore, durante il processo di acquisizione del proprio personale, dovrà valutare i livelli di conoscenza degli obiettivi e delle problematiche di sicurezza in funzione delle attività che dovranno essere svolte. Inoltre, il personale del Fornitore dovrà ricevere da questi un'adeguata e continuativa formazione inerente alle tematiche di Sicurezza e Privacy, in particolare, dovrà essere predisposta una formazione dedicata per il personale con ruoli specializzati;
- il Fornitore, alla conclusione del rapporto di lavoro del dipendente e/o collaboratore, dovrà:
 - nel caso in cui le credenziali siano definite sulle reti, sistemi e applicazioni del Titolare, comunicare tempestivamente al referente del Titolare i nominativi degli utenti che dovranno essere rimossi;
 - nel caso in cui le credenziali siano definite sulle reti, sistemi e applicazioni gestite dal Fornitore, rimuovere tutte le credenziali di autenticazione (ID e password) utilizzate dal dipendente e/o collaboratore dimissionario.

8.2.4. Accesso agli ambienti ed ai sistemi

Accesso agli ambienti del Titolare

Il Fornitore potrà accedere alle reti, ai sistemi e agli ambienti che il Titolare metterà a disposizione, relativamente al proprio modulo di competenza, attraverso le modalità di connessione definite.

L'infrastruttura utilizzata dovrà rispettare i requisiti minimi definiti e descritti nel seguito.

In nessun caso, in ambienti diversi dalla produzione, dovranno essere presenti dati reali di produzione dei servizi gestiti, a meno di preventiva autorizzazione scritta fornita dal Titolare. Si sottolinea che, ancorché salvaguardate le problematiche di protezione dei dati personali, il Fornitore rimane responsabile del rischio di furto, perdita accidentale e/o distruzione di patrimonio informativo, inteso come le basi dati, il codice sorgente e/o le soluzioni prodotte, le infrastrutture e le personalizzazioni sviluppate nonché le informazioni e i dati trattati, per quanto di sua competenza.

Accessi logici

Il Fornitore dovrà garantire sia sugli ambienti del Titolare da esso gestiti, sia sui propri ambienti, che l'accesso alle informazioni, servizi e sistemi avvenga in modo sicuro per prevenire l'accesso da parte di utenti che non hanno i necessari diritti e pertanto impedire trattamenti non autorizzati.

Il ciclo di vita delle utenze, sui sistemi gestiti dal Fornitore, prevede che:

- ogni operazione del ciclo di vita (creazione, modifica, sospensione, ecc.) che riguarda le utenze relative ad ambienti, sistemi o applicazioni del Titolare, dovrà essere preventivamente formalizzata dal Fornitore ai referenti specifici del Titolare e da questi ultimi autorizzata;
- il Fornitore dovrà effettuare la tracciatura di tutte le richieste effettuate inerenti alla gestione del ciclo di vita delle utenze per renderla disponibile su richiesta.

Accesso a reti, sistemi e ambienti del Titolare

Nel caso di accesso a reti, sistemi e ambienti del Titolare, il Fornitore dovrà:

- richiedere in forma scritta la creazione di una nuova utenza che dovrà contenere l'identificativo della persona a cui verrà assegnata, l'ambito di utilizzo, il ruolo, l'ambiente e la durata. Le utenze richieste dovranno essere univoche, personali e utilizzate in modo che l'accesso alle informazioni da parte di ogni singolo utente sia limitato alle sole (principio del "minimo privilegio") informazioni di cui necessita (principio del "need-to-know") per lo svolgimento dei propri compiti;
- inviare una tempestiva comunicazione in caso di variazione delle mansioni o delle attività in modo che il profilo venga adeguato alle effettive nuove esigenze; effettuare una revisione periodica delle utenze al fine di individuare le utenze inattive e quelle che necessitano di una modifica;
- richiedere immediatamente la disabilitazione di un'utenza assegnata ad un suo dipendente o collaboratore nei seguenti casi:
 - interruzione del rapporto di lavoro con il Fornitore;
 - cambio di mansione che non necessita dell'accesso ai sistemi informatici /applicazioni del Titolare;
 - utenze inattive emerse nella revisione periodica.

Tutto il personale autorizzato del Fornitore dovrà:

- eseguire l'accesso ai sistemi e agli ambienti tramite le proprie credenziali di accesso personali (ad esempio user ID, password) fornite dal Titolare;
- custodire ed utilizzare le proprie credenziali di accesso con la massima cautela al fine di evitare l'intercettazione, volontaria o fortuita, delle stesse da parte di terzi evitando in ogni caso di comunicarle ad altri e non consentendo a nessun'altra persona di utilizzarle.

Accesso ad ambienti del Fornitore

Nel caso in cui il Fornitore tratti dati e/o informazioni del Titolare attraverso propri ambienti e sistemi dovrà:

- rispettare principi espressi nei Paragrafi precedenti relativamente alla gestione del ciclo di vita delle utenze e all'accesso alle informazioni;
- definire un processo di gestione delle credenziali di autorizzazione e dei relativi profili di accesso;
- definire utenze univoche, personali e profilate in ottemperanza alle normative di riferimento;
- definire le autorizzazioni di accesso alle informazioni in modo che siano differenziate in base al ruolo ed agli incarichi ricoperti dai singoli individui;
- definire le procedure per consentire l'accesso ai dati nei casi in cui, a causa della prolungata assenza o dell'impedimento della persona autorizzata, si renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del Titolare;
- effettuare periodicamente valutazioni tecniche sulla robustezza delle parole chiave e credenziali usate dagli utenti;
- provvedere alla sospensione delle utenze nei seguenti casi:
 - assenza prolungata del dipendente (assenza per malattia o infortunio superiore a 90 giorni);
 - scadenza della parola chiave e inserimento consecutivo di 5 parole chiave errate;
 - decorrenza del tempo massimo di inattività;
 - scadenza di un'utenza temporanea, utilizzata da personale non dipendente.
- formalizzare e tracciare la richiesta di riattivazione di un'utenza sospesa. Inoltre, qualora il ripristino avvenga a seguito di sospensione per scadenza temporale della parola chiave, consentire all'utente di accedere al sistema solo per modificare la password;
- gestire la storicizzazione degli account e delle loro attività al fine di tenerne traccia, fornendo, su richiesta del Titolare le informazioni in merito.

Tutte le persone autorizzate del Fornitore dovranno:

- eseguire l'accesso ai sistemi e ambienti del Fornitore tramite le proprie credenziali di accesso personali (ad esempio user ID, password);
- custodire ed utilizzare le proprie credenziali di accesso con la massima cautela al fine di evitare l'intercettazione, volontaria o fortuita, delle stesse da parte di terzi evitando in ogni caso di comunicarle ad altri e non consentendo a nessun'altra persona di utilizzarle.

8.2.5. Modalità e specifiche di connessione

La connessione remota (dove per remota è da intendersi eseguita da sedi non del Titolare) ai sistemi del Titolare sarà possibile, previa le opportune e necessarie autorizzazioni, solo attraverso:

- connessioni dedicate;
- connettività VPN di tipo site-to-site.

La connettività VPN-Client, che dovrà essere nominale, è autorizzata solo in casi eccezionali e corredata da opportuna motivazione scritta.

La connettività Internet e l'apparato remoto lato Fornitore saranno a suo carico così come pure la configurazione della connessione VPN (nel caso di connettività site-to-site).

Il Titolare fornirà le specifiche di configurazione, a cui la connettività VPN deve rispondere, che dovranno essere applicate dal Fornitore. La VPN sarà unica per ciascun Fornitore (nel caso di RTI sarà resa disponibile una VPN per ogni società appartenente all'RTI). Non sono possibili in nessun caso VPN multiple per lo stesso Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore abbia l'esigenza di:

- accedere da sedi territoriali diverse;
- far accedere i suoi sub-fornitori;
- permettere l'accesso al proprio personale da postazioni remote rispetto ai propri sistemi, dovrà rispettare almeno gli stessi requisiti di sicurezza del Titolare, ove definiti.

Nel caso di accesso da parte del Fornitore ad ambienti di produzione del Titolare che trattano dati personali, come ulteriore misura di sicurezza, verrà richiesto al Fornitore una particolare configurazione della VPN che assegna in maniera statica un indirizzo IP univoco, assegnato sempre alla stessa persona che sarà autorizzata a quel particolare accesso.

L'attivazione della connessione andrà preventivamente concordata con il personale tecnico, tramite i referenti operativi specifici. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione una figura con il ruolo di Interfaccia Tecnica entro 5 giorni dall'avvio dell'attività di "approntamento infrastrutture e strumenti" della fase "attivazione servizio".

Qualora il Titolare ritenesse opportuno utilizzare altre modalità di connessione, anche in funzione delle evoluzioni tecnologiche, il Fornitore dovrà adoperarsi per i necessari adeguamenti.

La trasmissione di flussi di dati da e verso l'infrastruttura del Titolare dovrà avvenire su protocolli sicuri e cifrati: la tipologia e la natura dei flussi informativi e le relative modalità di protezione saranno concordate con i relativi referenti del Titolare.

Il Fornitore mantiene un inventario aggiornato dei flussi di dati da e verso l'infrastruttura del Titolare, che devono essere formalmente approvati dal Titolare.

8.2.6. Infrastruttura del Fornitore

Il Fornitore, in funzione delle attività assegnate, dovrà implementare sulla propria infrastruttura e sui propri sistemi le opportune regole di sicurezza in funzione della criticità del servizio e/o dell'informazione trattata.

Nel dettaglio il Fornitore dovrà, ove ricorra il caso:

- garantire la separazione degli ambienti (es: sviluppo, integrazione, produzione, management);
- prevedere meccanismi di autenticazione per l'accesso agli ambienti commisurati al rischio connesso ai privilegi delle utenze, alla criticità dei sistemi informativi e di rete a cui accedono e alla tipologia di operazioni che possono effettuare sugli stessi;
- implementare opportuni meccanismi di tracciatura e auditing;
- controllare e monitorare, tramite appositi strumenti (quali ad esempio firewall, IDS, Correlatori di Eventi, ecc.), gli eventuali "punti di contatto" tra le reti interne del Fornitore e la rete del Titolare;

- garantire lo svolgimento di attività di backup e restore secondo procedure formalizzate che definiscano le metodologie di salvataggio e ripristino, i tempi di conservazione delle copie, il numero di versioni da salvare, la cifratura utilizzata e la tipologia dei dati. In particolare, per i sistemi critici, dovranno essere periodicamente effettuati salvataggi dei file di sistema e di tutti quelli necessari per il ripristino degli stessi e di eventuali applicativi rilevanti ai fini della continuità delle operazioni;
- prevedere con cadenza periodica, al fine di garantire efficienza e livelli di sicurezza adeguati ai sistemi utilizzati:
 - attività di hardening;
 - attività di patching;
 - vulnerability assessment/penetration test e relativo piano di trattamento.
- verificare periodicamente i sistemi e le procedure di backup e restore in tutte le loro componenti e funzionalità, sia in condizioni di normale operatività che in condizioni di emergenza. In particolare, dovranno essere condotti dei test di ripristino dei salvataggi effettuati;
- conservare in luoghi sicuri opportunamente protetti i supporti utilizzati per eseguire i backup. Il tempo di mantenimento dei dati dovrà essere compatibile con le esigenze del Titolare e con la Normativa Privacy;
- verificare con regolarità la conformità dei sistemi informativi, servizi e applicazioni agli standard di sicurezza e ai requisiti richiesti dal Titolare e dalle normative di riferimento.

Relativamente agli ambienti di sviluppo, qualora richiesto dal Titolare, il Fornitore dovrà:

- predisporre in casa propria tutti gli ambienti di sviluppo necessari;
- verificare che, in nessun caso, siano presenti dati reali o riconducibili a persone fisiche realmente esistenti;
- prevedere opportuni allineamenti dei codici sorgente sviluppati presso le proprie sedi, con gli strumenti di versioning del codice sorgente sviluppato.

Relativamente agli strumenti di lavoro, il Fornitore dovrà:

- dotare le postazioni di lavoro utilizzate per accedere alla rete e ai sistemi del Titolare (ove applicabile) di opportuni meccanismi di sicurezza (antivirus, patch di sicurezza, ecc.) e segregarle dal resto della rete del Fornitore;
- utilizzare sistemi antivirus, controllo malware e meccanismi di sicurezza per i media rimovibili, per tutti i sistemi, postazioni e reti;
- garantire che tutti gli strumenti di lavoro introdotti, come ad esempio laptop e dispositivi di memorizzazione usati dalle persone autorizzate del Fornitore, siano stati preventivamente autorizzati e dotati di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie e adeguate in conformità con gli standard vigenti presso il Titolare, documentando le misure di sicurezza applicate;
- garantire che su tutti gli strumenti di lavoro, anche su quelli eventualmente forniti dal Titolare, non sia installato software e/o modificata la configurazione dei sistemi senza preventiva autorizzazione scritta;
- consentire l'esecuzione di controlli da parte del Titolare volti a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni, anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici che saranno preventivamente comunicati al Fornitore;

- consentire l'installazione sulle proprie postazioni di lavoro di componenti software, preventivamente comunicati al Fornitore, necessari per assicurare una connessione sicura alla rete del Titolare;
- non lasciare incustodita la postazione di lavoro e nel caso, prima di allontanarsi, assicurarsi di chiudere le eventuali sessioni aperte e di attivare lo screensaver con password.

Al Fornitore non è consentito l'uso di dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) propri o aziendali per l'accesso ai dati e informazioni del Titolare, qualora questi non prevedano le misure di sicurezza analoghe a quelle previste per gli altri strumenti di lavoro, se non preventivamente richiesto al Titolare e dal Titolare espressamente autorizzato.

8.2.7. Analisi e gestione dei rischi

Ove richiesto dal Titolare, il Fornitore è tenuto a svolgere attività di analisi dei rischi rispetto alla sicurezza delle informazioni sull'intero oggetto del contratto.

I risultati dell'analisi dei rischi dovranno essere presentati al Titolare dal Fornitore nei tempi e nei modi che saranno concordati opportunamente tra le parti e dovranno almeno prevedere:

- l'identificazione e la descrizione del rischio;
- il livello di gravità del rischio;
- l'eventuale impatto sui servizi;
- le indicazioni sulle possibili soluzioni congiuntamente alle relative stime sui tempi e costi.

Il documento dovrà essere aggiornato con cadenza periodica o ove dovessero intervenire eventi/circostanze impattanti sul contenuto e di tali variazioni dovrà essere data evidenza al Titolare.

Il Fornitore, condividendolo con il Titolare, definirà, ove necessario, le modalità di gestione del rischio (ovvero mitigazione, esternalizzazione ed accettazione) e sarà responsabile della redazione di un Piano di Trattamento dei Rischi da attuare nei tempi concordati con il Titolare.

Il piano di trattamento del rischio deve prevedere:

- le scelte operate e le misure di trattamento di ciascun rischio;
- il personale o ufficio coinvolto nell'attuazione delle misure di trattamento dei rischi e la tempistica per tale attuazione;
- la chiara descrizione e le ragioni che giustificano l'accettazione di eventuali rischi residui al trattamento.

8.2.8. Gestione degli eventi anomali, degli incidenti e della Business Continuity

Il Fornitore dovrà garantire che le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza, siano tempestivamente riconosciuti e correttamente gestiti attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione, per minimizzare l'impatto sul business, anche monitorando i canali di comunicazione del CSIRT Italia, nonché di eventuali CERT e Information Sharing & Analysis Centre (ISAC) di riferimento. Deve essere ivi gestito un sistema di Disaster Recovery, indicando il piano e le opportune tempistiche di risoluzione. Il sistema, in mancanza di rete o guasti regionali o locali o di altro tipo, dovrà permettere al

AZIENDA_ZERO – Appalto Specifico ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della Regione Veneto – ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2365 - LOTTO 3 Capitolato Tecnico

dipartimento di poter svolgere le funzionalità indicate e, al momento di ripristino del collegamento, dovranno essere previste delle funzionalità di allineamento evitando problematiche di conflitto o di perdita di dati.

È fatto obbligo al Fornitore di una altrettanto tempestiva notifica nei confronti del Titolare degli eventi anomali e/o incidenti di sicurezza che coinvolgono sistemi del Fornitore che contengono o trattano dati o codice del Titolare.

Nel dettaglio il Fornitore dovrà:

- implementare e documentare le procedure di gestione degli incidenti di sicurezza e di comunicazione degli stessi al Titolare, in particolare il piano per la gestione degli incidenti dovrà comprendere almeno:
 - le finalità e l'ambito di applicazione;
 - i ruoli e le responsabilità;
 - i contatti principali e canali di comunicazione (interni ed esterni);
 - le condizioni per l'attivazione e la disattivazione del piano;
 - l'ordine di ripristino delle operazioni;
 - le procedure di ripristino per operazioni specifiche, compresi gli obiettivi di ripristino;
 - le risorse necessarie, compresi i backup e le ridondanze;
- rilevare gli incidenti che possano avere un impatto sui livelli di sicurezza. Dovrà altresì garantire la completa gestione degli eventuali effetti, reali o potenziali, derivanti dall'incidente, ove possibile in tempi brevi, garantendo il rispetto delle procedure, ove presenti o definite, sempre in accordo con il Titolare;
- prevedere un sistema di registrazione e classificazione degli incidenti e degli eventi anomali per effettuare analisi volte al miglioramento dei livelli di sicurezza coerente con le reali problematiche riscontrate;
- raccogliere le evidenze a seguito di un incidente di sicurezza, conservarle e presentarle qualora sussista la necessità di azioni legali di natura civile o penale;
- attivare e mantenere idonee procedure di Business Continuity nella misura ed in relazione al servizio prestato al Titolare, in coerenza con i livelli di servizio previsti dal contratto (SLA);
- concorrere all'attivazione e al coordinamento dei gruppi operativi del proprio personale dedicato alla gestione delle emergenze e della crisi comunicandolo al Titolare e tenendo aggiornati i nominativi e i recapiti che garantiscano la pronta rintracciabilità delle figure competenti individuate; dovrà partecipare ai test tecnici e organizzativi di Business Continuity e di Disaster Recovery, per quanto di competenza. Una volta conclusi i test, o periodicamente, aggiornare il piano per la gestione degli incidenti.

8.2.9. Rispetto delle procedure di sicurezza

Il Fornitore si impegna a rispettare le procedure di sicurezza del Titolare.

Il rispetto delle procedure di sicurezza e di qualsiasi loro modifica introdotta dal Titolare, anche durante il corso della fornitura, è sempre parte integrante della Fornitura stessa. Il Fornitore non potrà avanzare richieste di estensione contrattuale o pagamenti specifici connessi a questo specifico ambito.

8.2.10. Report da parte del Fornitore

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il Fornitore dovrà predisporre una proposta di documento di autocertificazione periodica delle regole e delle policy relative alla sicurezza delle informazioni.

In particolare, tale documentazione dovrà includere:

- la descrizione delle azioni implementate e delle regole definite;
- il risultato dei test effettuati, atti a garantire l'effettivo rispetto di tali regole, in particolare i Vulnerability assessment/penetration test e relativo piano di trattamento oltre ai test di Continuità Operativa svolti.

Una volta approvato il documento da parte del Titolare, il Fornitore dovrà, mediante lo stesso o altro documento di rendiconto previsto dal Titolare, autocertificare, annualmente o su richiesta del Titolare, il rispetto delle regole e delle policy relative alla sicurezza delle informazioni. Questa documentazione è considerata parte del sistema complessivo di monitoraggio della Fornitura.

8.2.11. Attività di verifica e controllo

Il Titolare avrà facoltà di effettuare attività di verifica e controllo sull'applicazione, da parte del Fornitore ed eventualmente dei sub-fornitori, di quanto sopra esposto e di qualsiasi altra misura di sicurezza che dovrà essere successivamente definita a fronte di eventuali evoluzioni e/o modifiche normative o standard di settore. La verifica può essere effettuata sia tramite visita presso il Fornitore o, congiuntamente, presso i suoi sub-fornitori, sia tramite richiesta di idonea documentazione attestante la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti contrattualmente nonché dalla normativa di riferimento e successive modifiche.

A fronte di difformità rilevate, il Fornitore si impegna ad eseguire gli interventi per il superamento delle stesse previa validazione da parte del Titolare delle soluzioni identificate.

8.2.12. Deroghe

In casi straordinari e con le dovute autorizzazioni opportunamente documentate sarà possibile operare in deroga alle regole di sicurezza qui stabilite.

Le richieste da parte del Fornitore dovranno essere formalizzate e tracciate, oltre che adeguatamente documentate. In particolare, dovranno essere esplicitate le motivazioni che giustificano la deroga, gli ambiti operativi e temporali di intervento, l'identificazione del personale esterno e le attività da autorizzare.

La richiesta dovrà essere indirizzata agli specifici referenti operativi del Titolare che provvederanno, coinvolgendo le opportune strutture aziendali interne, ad ottenere autorizzazione scritta per le richieste ammissibili.

8.2.13. Reperibilità

Il Fornitore è tenuto a comunicare i numeri di reperibilità relativi alle figure di Security Manager, a garanzia di una corretta e tempestiva erogazione di tutti i servizi a suo carico, di cui viene riportato di seguito un elenco esemplificativo, ma non esaustivo:

- comunicazione e gestione di incidenti di sicurezza;
- comunicazione e gestione di eventi di data breach;
- test tecnici e/o organizzativi di Disaster Recovery;
- attivazione dei servizi in Disaster Recovery;
- piano di rientro dal Disaster Recovery;
- la reperibilità per tale figura è da intendersi 24x7x365.

9. REALIZZAZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E DELIVERY DEL SISTEMA

9.1. Generalità

Le indicazioni fornite nelle prossime sezioni devono essere considerate mandatorie dal Fornitore, il quale dovrà organizzare le proprie attività nel rispetto dei vincoli temporali e secondo le modalità di azione descritte a livello generale.

Nelle attività di gestione si intendono inclusi:

- il completamento del programma definito nella presente parte nei tempi previsti, monitorandone puntualmente l'avanzamento complessivo e coordinandone le diverse aree;
- il coordinamento con eventuali altri progetti già in essere presso gli ES e Azienda Zero per evitare dinamiche contrastanti e gestire le interrelazioni reciproche;
- la progettazione dell'organizzazione e la definizione dei ruoli e dei team di progetto, favorendo la collaborazione tra le persone degli ES e del Fornitore;
- la definizione degli standard e delle procedure comuni all'intera Fornitura, al fine di garantire un coordinamento efficace e comunicazioni trasparenti, strutturando e attivando flussi informativi e di comunicazione efficienti tra i diversi soggetti coinvolti nell'iniziativa. Ciò comprende:
 - procedure decisionali, di validazione, di comunicazione;
 - procedure di analisi, risoluzione e trasferimento delle criticità;
 - procedure di controllo delle modifiche e delle revisioni;
 - organizzazione, processi e standard di documentazione e di rilascio;
 - modello di reporting.
- la definizione di piani di lavoro, di contingenza e di continuità operativa chiari e dettagliati;
- l'adeguata gestione del periodo transitorio di cambiamento in modo di garantire continuità nei processi sanitari, senza causare rallentamenti nei processi primari di cura del paziente.

In seguito all'assegnazione della Fornitura, il Fornitore sarà chiamato a concordare con Azienda Zero e gli ES, formalizzare e condividere opportuni documenti di sintesi che normino ruoli, responsabilità, funzioni e meccanismi di comunicazione e interazione tra i diversi attori coinvolti, nel rispetto delle linee guida del presente documento.

Pertanto, per rendere efficienti le attività di gestione e di condivisione delle informazioni il Fornitore dovrà predisporre un repository dedicato e strumenti per la gestione in formato elettronico della documentazione, del relativo cronoprogramma (generale ed esecutivo di dettaglio) e di ogni documento tecnico di comune interesse (Project Management Information System – PMIS).

Nei Paragrafi successivi sono quindi descritti:

- le fasi progettuali e le relative tempistiche per l'attuazione del sistema;
- la struttura organizzativa, intesa come gli organi di governo preposti per la gestione della Fornitura coinvolti nell'erogazione dei servizi;
- le caratteristiche dei servizi di manutenzione, assistenza e rendicontazione;

- le attività di Exit Strategy e il trasferimento del Know-How.

9.2. Fasi progettuali e relative tempistiche

La presente sezione contiene le informazioni connesse all'introduzione del nuovo sistema definendo le principali attività che dovranno essere svolte presso ogni ES, le tempistiche massime e i vincoli a cui il Fornitore dovrà attenersi. **Si sottolinea che le attività di introduzione del nuovo sistema dovranno essere svolte garantendo il minor disservizio possibile per operatori e pazienti.** Di seguito sono descritte le attività che il Fornitore sarà tenuto a svolgere per gli ES in cui inserirà il nuovo sistema:

- assessment e preparazione dell'avvio ivi inclusa la formalizzazione di un Piano di Lavoro di Obiettivo;
- sviluppo del sistema e personalizzazione di soluzioni;
- test e collaudo del sistema per ogni ES;
- formazione, avviamento e completamento della diffusione del sistema in tutti gli ES;
- gestione a regime del sistema.

Durante le attività previste nelle diverse fasi sarà fondamentale il continuo confronto con i referenti degli ES, al fine di mantenere costantemente allineati gli obiettivi dell'intervento con le esigenze raccolte.

La Tabella seguente riassume le tempistiche previste per la realizzazione di tali attività.

Tabella 4 - Tempistiche previste per le fasi progettuali

Elapsed dall'avvio del progetto	Fase progettuale
Entro il 30/11/2025	Assessment e preparazione dell'avvio ivi inclusa la formalizzazione di un Piano di Lavoro di Obiettivo.
Entro Marzo 2026	Test e collaudo dei moduli relativi a Consultorio, Ospedale di Comunità, URT, Cure Domiciliari.
Entro Giugno 2026	Formazione e avvio in esercizio dei moduli relativi a Consultorio, Ospedale di Comunità e URT su tutti gli ES
Entro Dicembre 2026	Formazione e avvio in esercizio del modulo relativo alle Cure Domiciliari su tutti gli ES.
Entro Dicembre 2026	Test e Collaudo dei moduli Salute Mentale, Prescrizione elettronica, Hospice e COT
Entro Giugno 2027	Formazione e avvio in esercizio dei moduli relativi a Salute Mentale, Prescrizione elettronica, Hospice e COT su tutti gli ES
Fino al termine della fornitura	Gestione a regime del sistema

Il momento di avvio del progetto sarà definito da Azienda Zero di concerto con gli ES a seguito della firma del contratto esecutivo, coerentemente con il fabbisogno indicato nel Capitolo 12.

9.2.1. Assessment e definizione del Piano di Lavoro di Obiettivo

La prima attività consiste nell'**assessment** del Sistema Informativo degli ES. Il **Piano di Lavoro di Obiettivo** di dettaglio descrive tutte le attività inerenti al singolo cantiere di lavoro presso ciascun ES.

L'attività di assessment dell'ecosistema dei Sistemi Informativi ha l'obiettivo di delineare una fotografia del patrimonio informativo delle unità organizzative afferenti a ciascun ES, evidenziando la copertura funzionale AS/IS, le modalità di accesso normate dagli scenari applicativi e le integrazioni interne necessarie per mettere in comunicazione le applicazioni che compongono il Sistema Informativo dell'ES. Tale attività, che dovrà essere svolta in stretta collaborazione e condivisione con i referenti degli ES, dovrà produrre un **Documento di Assessment** che riporti:

- una mappatura dei processi che interessano l'introduzione del sistema, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder;
- una descrizione dei servizi complessivamente presenti all'interno del Sistema Informativo socio-sanitario della Regione Veneto (e delle peculiarità di ciascun ES);
- una mappa delle integrazioni presenti (sia HL7 che di altro tipo) tra le applicazioni dell'ecosistema dei sistemi informativi presenti presso gli ES sopra rilevati;
- una gap analysis finalizzata a identificare le differenze tra lo stato attuale e i requisiti attesi.

La seconda attività da svolgere in questa fase riguarda la redazione di un **Piano di Lavoro di Obiettivo**, redatto e condiviso in collaborazione con gli ES, che riporti, tempi e modi di azione sugli ES, ed in particolare il piano delle attività previste per l'introduzione del sistema e dei suoi moduli e le tempistiche necessarie. Relativamente al Piano di Lavoro di Obiettivo, si prega di far riferimento a quanto indicato al Capitolo 4.6 dell'Allegato 3 ("Cicli e prodotti") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

Inoltre, dovrà essere formalizzato un piano di rollback contenente le azioni puntuali da attuare in caso di anomalie gravi per ripristinare i moduli e le integrazioni presenti prima dell'introduzione del sistema e riportare il Sistema Informativo complessivo ad una condizione di piena operatività.

Il Documento di Assessment e il Piano di Lavoro di Obiettivo dovranno essere condivisi con gli ES e Azienda Zero, che si occuperanno di verificarne la coerenza. A valle delle verifiche effettuate sugli output prodotti si potrà:

- accettare la documentazione;
- richiedere delle modifiche/integrazioni.

Nel primo caso il Fornitore potrà avviare le attività operative connesse alla realizzazione progettuale descritte nelle prossime sezioni.

Nel secondo caso, il Fornitore sarà tenuto a recepire le indicazioni ricevute dagli ES e Azienda Zero ed a presentare nuovamente i documenti di Assessment e Piano di Lavoro di Obiettivo entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

Azienda Zero e gli ES potranno richiedere nuovamente una revisione di quanto prodotto e presentato dal Fornitore formalizzando gli elementi che non sono coerenti con quanto previsto contrattualmente o rispetto alle modifiche/integrazioni richieste. Si precisa che resta salvo il termine

previsto dal Capitolato Tecnico per il completamento della fase, il non rispetto del quale comporta l'applicazione delle relative penali.

Salvo future comunicazioni da parte della Committenza, atte a declinare ulteriormente le attività appena descritte, le medesime si intendono come afferenti ai servizi previsti dall'AQ "Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati" e "Servizi Infrastrutturali - Servizio di Conduzione Tecnica".

9.2.2. Sviluppo del sistema e personalizzazione di soluzioni

Questa fase prevede lo sviluppo del sistema e la personalizzazione di soluzioni, nonché quanto necessario al funzionamento dello stesso, coerentemente con quanto previsto nel Piano di Lavoro di Obiettivo accordato con gli ES e Azienda Zero.

La realizzazione del sistema è da intendersi come comprensiva dello sviluppo delle integrazioni tra i moduli del sistema e con gli altri applicativi del Sistema Informativo dell'ES necessari al corretto funzionamento del sistema stesso. Per maggiore dettaglio in merito alle integrazioni si rimanda al Capitolo 5.2.

Salvo future comunicazioni da parte della Committenza, atte a declinare ulteriormente le attività appena descritte, le medesime si intendono come afferenti ai servizi previsti dall'AQ "Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field" e "Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)".

9.2.3. Test e collaudo del sistema

Questa fase racchiude tutte le attività di verifica funzionale e tecnica del sistema predisposto. Le attività di test dovranno riguardare tutte le funzionalità del sistema e dei suoi moduli. Il Fornitore, prima di iniziare la fase di collaudo, dovrà produrre un **Piano di Collaudo** contenente modalità di svolgimento di ogni tipologia di test, i casi d'uso coperti dal test e le funzionalità impattate. Il Piano dovrà inoltre comprendere le tempistiche previste per lo svolgimento di ogni test, e ogni singolo collaudo dovrà rispettare le tempistiche condivise e approvate dalla Committenza in merito alla diffusione del sistema e dei suoi moduli a livello di ciascun ES. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Collaudo potrà contemplare i test riassunti nella Tabella seguente, definiti in accordo con l'Amministrazione.

Tabella 5 - Test e deliverable previsti nel Piano di Collaudo

Tipo di test	Deliverable
Funzionali	Verbale di esecuzione dei test funzionali con il relativo esito
Prestazionali	Verbale di esecuzione dei test prestazionali riportante i servizi e le funzionalità e i tempi di risposta registrati
Processuali	Verbale di esecuzione dei test processuali riportante i processi ed i percorsi organizzativi dell'ES
Di sicurezza	Verbale di esecuzione dei test di sicurezza
Di integrazione	Verbale di esecuzione dei test di integrazione con i SI dell'ES
Test di non regressione	Verbale di esecuzione dei test di non regressione

Test del modello fisico della base dati	Verbale di esecuzione dei test del modello fisico della base di dati
---	--

A valle delle verifiche effettuate sul Piano di Collaudo prodotto da parte di Azienda Zero di concerto con gli ES potranno:

- accettare il Piano;
- richiedere delle modifiche/integrazioni.

Nel primo caso il Fornitore potrà avviare le attività operative previste.

Nel secondo caso, il Fornitore sarà tenuto a recepire le indicazioni ricevute ed a presentare nuovamente il Piano entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

Azienda Zero e gli ES potranno richiedere nuovamente una revisione di quanto prodotto e presentato dal Fornitore formalizzando gli elementi che non sono coerenti con quanto previsto contrattualmente o rispetto alle modifiche/integrazioni richieste. Si precisa che resta salvo il termine previsto dal Capitolato Tecnico per il completamento della fase, il non rispetto del quale comporta l'applicazione delle relative penali.

Il collaudo sarà effettuato con la partecipazione dei referenti operativi degli ES e del Fornitore.

Tutti i verbali/documenti prodotti a seguito delle diverse sessioni di test andranno consegnati ad Azienda Zero e agli ES. Eventuali test con esito negativo dovranno essere ripetuti fino al completo successo di tutti i test definiti.

L'avvio della gestione a regime della Fornitura sul singolo ES sarà subordinato al superamento del collaudo del nuovo sistema, nonché alla verifica dell'adempimento degli obblighi amministrativi ed organizzativi.

L'esito del collaudo sarà oggetto di un verbale/documento riportante le prove superate e gli eventuali fallimenti riscontrati, firmato dai Referenti operativi coinvolti.

Inoltre, l'esito positivo del collaudo definirà conseguentemente anche i tempi nei quali il sistema sarà ritenuto sotto garanzia, ovvero nei 12 mesi (come anche citato nel Capitolato Generale dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi in ambito "SANITÀ DIGITALE – Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino" Per Le Pubbliche Amministrazioni del SSN") successivi al collaudo stesso.

Salvo future comunicazioni da parte della Committenza, atte a declinare ulteriormente le attività appena descritte, le medesime si intendono come afferenti ai servizi previsti dall'AQ "Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field" e "Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)".

9.2.4. Formazione, Avviamento e completamento della diffusione del sistema in tutti gli ES

Il **Piano Formativo** deve comprendere tutte le attività di formazione e avvio all'utilizzo del nuovo sistema. Il piano di formazione può includere le seguenti informazioni:

- la metodologia adottata, tenendo conto che la formazione deve necessariamente essere erogata presso ciascuna struttura dove sarà presente il nuovo sistema, distinguendo i diversi livelli di formazione in funzione della operatività del profilo professionale;
- la descrizione dei corsi, con evidenza in dettaglio dei rispettivi contenuti, della durata, del numero minimo e massimo di docenti e partecipanti, degli obiettivi formativi ecc.; il numero di giornate e ore erogate complessivamente e per ciascuna sessione di ciascun corso;
- la documentazione, la manualistica, il materiale informativo ed i video messi a disposizione all'interno del sistema; si precisa che la documentazione deve essere quella dell'impianto proposto nel progetto e non quella generica del prodotto;
- sistemi di formazione on-line e sistemi di autoapprendimento a integrazione della formazione in aula e per la formazione di nuovi operatori.

La modalità di erogazione della formazione dovrà avvenire secondo quanto concordato con gli ES e Azienda Zero.

A valle del superamento del collaudo avrà avvio la diffusione del nuovo sistema, la quale avverrà secondo le modalità definite dal Piano di Lavoro di Obiettivo concordato con ciascun ES.

In seguito, all'avviamento del sistema avrà inizio la fase di gestione a regime presso ciascun ES del sistema in oggetto.

Poiché nelle strutture dei vari ES possono essere presenti vari sistemi software che comprendono gran parte delle funzionalità, la sostituzione degli attuali software con quello offerto, dovrà avvenire assicurando la completa continuità operativa. Dovrà essere presentato, pertanto, un piano di avvicinamento che dovrà individuare e descrivere le modalità con cui il fornitore intenda garantire questo risultato.

Salvo future comunicazioni da parte della Committenza, atte a declinare ulteriormente le attività appena descritte, le medesime si intendono come afferenti ai servizi previsti dall'AQ "Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati" e "Servizi Infrastrutturali - Servizio di Conduzione Tecnica".

9.2.5. Gestione a regime

A seguito dell'avviamento a regime del nuovo sistema, il Fornitore dovrà garantire, fino al termine dell'incarico tutte quelle attività e servizi necessari ad assicurare il corretto funzionamento del sistema in oggetto, nel rispetto degli opportuni Livelli di servizio come descritto nel Capitolo 10.

In particolare, le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema dovranno essere erogate dai gruppi di lavoro che il Fornitore metterà a disposizione per i servizi di:

- **gestione della domanda e Supporto per la pianificazione delle evoluzioni dei servizi:** in particolare per quanto riguarda le attività necessarie a monitorare e garantire nel tempo l'allineamento fra le esigenze degli ES e l'evoluzione dei servizi stessi;
- **gestione operativa delle installazioni:** per quanto riguarda le attività di gestione di servizi applicativi e dell'infrastruttura connessa all'esercizio del sistema;
- **supporto e Manutenzione dei servizi del sistema:** per quanto riguarda le attività di manutenzione di servizi applicativi esistenti e servizi di supporto connessi;

- **assistenza e supporto applicativo:** per quanto riguarda le attività di assistenza specialistica di servizi applicativi, Help Desk di II° Livello;
- **delivery del sistema:** per le attività necessarie a far evolvere i sistemi in esercizio negli ES (ad es. effettuare i rilasci delle versioni del sistema contenenti migliorie ed evoluzioni).

Resta inteso che durante la fase di esercizio e dunque per tutta la durata del contratto il Fornitore dovrà garantire i servizi necessari ad assicurare il corretto funzionamento del sistema, nel rispetto degli opportuni Livelli di servizio come descritto nel Capitolo 10.

Salvo future comunicazioni da parte della Committenza, atte a declinare ulteriormente le attività appena descritte, le medesime si intendono come afferenti ai servizi previsti dall'AQ in ambito manutentivo, ossia *“Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva”* e *“Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti”*; nonché ai servizi in ambito di conduzione applicativa e infrastrutturali, *“Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati”* e *“Servizi Infrastrutturali - Servizio di Conduzione Tecnica”*.

9.3. Gestione della Fornitura

L'impianto contrattuale con il fornitore individuato sarà organizzato mediante adesione all'AQ CONSIP ID2365 e conseguente sottoscrizione di un contratto esecutivo con Azienda Zero. Inoltre, la proprietà intellettuale del sistema, come precisato anche nell'articolo 22 “Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere” dell'AQ, sarà governata come segue: il software installato per tutti i moduli si intende di proprietà di Azienda Zero, e pertanto, dovrà essere rilasciato con documentazione dettagliata.

9.3.1. Governo della Fornitura

Il modello organizzativo atto ad indicare ruoli e responsabilità di alcune figure chiave all'interno Fornitura stessa verrà concordata con il Fornitore durante la fase esecutiva del progetto.

Tuttavia, vengono di seguito date alcune linee guida al fine di garantire dei chiari ruoli di interfaccia e chiare responsabilità in sede progettuale. In questa sede non verranno quindi imposti vincoli sull'organizzazione che il Fornitore dovrà dare alle proprie risorse, ma solo per quanto riguarda Centri di Competenza/Ruoli chiave e Interfacce rilevanti verso i singoli Enti Sanitari, nonché per quanto riguarda i livelli qualitativi minimi delle risorse fornite.

Nella definizione della struttura organizzativa finalizzata alla gestione del contratto e della fornitura, il Fornitore dovrà seguire i seguenti principi-guida:

- esplicitazione chiara delle responsabilità dei contraenti, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- adozione di sistemi di pianificazione e controllo consistenti, basati su evidenze oggettive;
- garanzia di efficaci meccanismi di comunicazione e stabili ruoli interfaccia/coordinamento interni, verso Enti Sanitari;
- implementazione di procedure e soluzioni organizzative mutate da best practice riconosciute dai framework internazionali di riferimento sul tema del project management;
- istituzione di team di progetto e ruoli organizzativi con prerogative, oneri e responsabilità ben definiti e non sovrapposti tra loro;

- coinvolgimento di opportuni profili professionali e competenze nelle varie posizioni dell'organizzazione che verrà disegnata;
- attenzione alle tematiche di formazione del personale tecnico ed utente dei nuovi servizi e sistemi, consapevoli della fondamentale importanza di tali attività per il successo delle fasi di cambiamento;
- documentazione, chiara ed evidente, di attività svolte verso gli Enti Sanitari e dei sistemi realizzati.

Allo stesso modo, sarà imprescindibilmente necessaria l'adozione, documentata, di un modello di governo secondo metodologie di riferimento quali il Framework PMBoK (Project Management Body of Knowledge del Project Management Institute), PRINCE/PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments), o analogo framework riconosciuto di project management per la pianificazione e successiva gestione di ogni fase dell'iniziativa. Coerentemente con la metodologia scelta, sarà poi opportuno effettuare, fin dall'inizio della Fornitura, un tailoring sulla base delle specifiche esigenze e del contesto organizzativo in essere.

Sarà, inoltre, necessario l'utilizzo, documentato, del Framework ITIL, COBIT (Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), CMMI (Capability Maturity Model Integration)) o analogo framework di gestione dei processi per l'implementazione dei processi di erogazione dei servizi richiesti. Il Fornitore è tenuto a documentare come ha adottato e intende implementare una metodologia di lavoro strutturata per la gestione operativa dei servizi applicativi e dei servizi professionali richiesti.

Nel corso della Fornitura, il Fornitore si impegnerà a garantire la stabilità del gruppo di lavoro attivo sullo stesso. Sarà responsabilità del Fornitore adeguare in termini qualitativi e quantitativi, per tutta la durata del contratto, le risorse utilizzate in modo tale da garantire i Livelli di servizio di Capitolato Tecnico. Analogamente, nel caso in cui gli Enti Sanitari ritenessero insufficiente il livello qualitativo dei servizi erogati e/o inadeguato il livello di responsività del Fornitore alle richieste, potrà richiedere l'adeguamento in termini qualitativi e quantitativi delle risorse erogate.

Azienda Zero e gli ES si riservano di valutare e segnalare incompatibilità del personale predisposto dal Fornitore per l'erogazione della Fornitura e richiederne la sostituzione, con istanza insindacabile.

In caso di variazione al gruppo di lavoro, il Fornitore dovrà assicurare alle nuove risorse un periodo di affiancamento come da Livelli di servizio, senza ulteriori oneri.

9.3.2. Gestione del contratto con il Fornitore e relative tempistiche

Come già precedentemente descritto, l'impianto contrattuale con il Fornitore individuato tramite procedura di gara sarà organizzato mediante adesione all'AQ CONSIP ID2365 e conseguente sottoscrizione di un contratto esecutivo con Azienda Zero.

Incontro di Kick-off

L'avvio dell'esecuzione del contratto esecutivo, successivamente alla data di stipula, avverrà con una riunione di Kick-off convocata da Azienda Zero/Regione del Veneto congiuntamente alla struttura competente dell'Ente Sanitario. In tale incontro l'Ente Sanitario presenterà i Referenti dei

servizi in oggetto e l'aggiudicatario dovrà a sua volta comunicare i nominativi dei propri Responsabili e Referenti. Inoltre, verranno esposte nel dettaglio le modalità di assegnazione delle attività e le modalità operative di attivazione dei servizi sul perimetro di fornitura.

Monitoraggio dell'esecuzione del contratto

Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del contratto esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, saranno svolte e rientreranno nella responsabilità di Azienda Zero con il supporto dei singoli Enti Sanitari.

Azienda Zero svolgerà un'azione di monitoraggio del contratto esecutivo e potrà avere la funzione di supporto agli Enti Sanitari nella gestione della fornitura prevista. Resterà salva in particolare la facoltà di Azienda Zero/Regione del Veneto, in collaborazione con gli Enti Sanitari, attraverso una cabina di regia centrale, di:

- controllare l'attuazione della strategia generale di erogazione del servizio;
- prendere visione, a livello di sintesi, degli avanzamenti generali durante le fasi realizzative e di esecuzione del servizio;
- verificare, sempre a livello di sintesi, gli avanzamenti del servizio presso i singoli Enti Sanitari;
- verificare, con periodicità mensile i consuntivi sulle quantità e le caratteristiche lavorate dal servizio presso il singolo Ente Sanitario;
- monitorare, congiuntamente agli Enti Sanitari, i LdS realizzati dal Fornitore e verificare l'eventuale applicazione delle penali.

Nell'esecuzione dei servizi il Fornitore dovrà garantire il supporto e la continua disponibilità di un numero di telefono e di un indirizzo e-mail dedicati per le interlocuzioni formali con l'Ente Sanitario. Tali contatti dovranno essere comunicati all'Ente Sanitario entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto esecutivo.

I momenti di controllo e verifica dell'andamento della fornitura sono costanti per tutta la durata del contratto esecutivo e garantiscono una visibilità completa e dettagliata dell'avanzamento delle attività. Le attività di verifica e controllo riguardano:

- verifica dell'andamento operativo della fornitura (SAL Operativo);
- verifica dell'andamento economico e generale del contratto (SAL Economico-Generale).

Il dettaglio è riportato nella tabella che segue.

Tabella 6 - Elementi del SAL Operativo e del SAL Economico-Generale

Attività di verifica	Oggetto	Finalità	Attori	Frequenza	Output
OPERATIVO	Uno o più Servizi/ attività	Monitoraggio attività operative, controllo costi e attestazione di consegna dei rilasci, controllo della qualità della fornitura e del rispetto degli LdS definiti	Referente nominato dall'Ente Sanitario e referente del Fornitore, con il coordinamento di Azienda Zero	Settimanale o su richiesta dell'Ente Sanitario	Verbale di SAL
SAL ECONOMICO - GENERALE	Intero contratto esecutivo	Verifica costi, consumi e andamento generale del contratto	Referente di Azienda Zero/Regione del Veneto, Referente nominato dall'Ente Sanitario e referente del Fornitore	Mensile	Verbale di SAL

9.3.3. Ruoli di Governo

Come già anticipato, il modello organizzativo atto ad indicare ruoli e responsabilità di alcune figure chiave all'interno Fornitura stessa verrà concordata con il Fornitore durante la fase esecutiva del progetto.

Tuttavia, di seguito sono descritti i principali attori coinvolti nel governo della Fornitura.

Responsabile del Contratto del Fornitore

Il Fornitore dovrà individuare un proprio Responsabile del Contratto che costituirà il suo punto di riferimento nei confronti di Azienda Zero/Regione del Veneto e degli ES per tutte le necessità di governo del contratto.

Rientra tra i compiti del Responsabile del Contratto comunicare ad Azienda Zero e agli ES la presenza di criticità nell'erogazione della Fornitura riscontrate dai propri Referenti operativi.

Il Responsabile del Contratto dovrà essere dotato dell'autorità necessaria ad assumere impegni vincolanti per il Fornitore che rappresenta e attuare l'esecuzione di quanto concordato.

Responsabile del Contratto di Azienda Zero e referenti degli ES

Azienda Zero / Regione Veneto, individueranno un Responsabile del Contratto che diventerà punto di riferimento del Fornitore per tutte le necessità di governo del contratto esecutivo.

Gli ES, invece, individueranno i propri referenti del Contratto che costituiranno per ciascun ES il punto di riferimento nei confronti di Azienda Zero / Regione del Veneto.

Comitato di Direzione - PMO

Al fine di esercitare il controllo sull'attuazione generale del Servizio, Azienda Zero/Regione del Veneto avrà facoltà di definire un Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione eserciterà il controllo strategico sul Servizio e sarà incaricato della valutazione dello stato di avanzamento complessivo. Il Comitato di Direzione sarà costituito principalmente da rappresentanti di Azienda Zero e di Regione Veneto, dei singoli ES e del Fornitore. Inoltre, potranno essere coinvolti, in funzione degli obiettivi di discussione, anche altri soggetti interessati.

Il Comitato di Direzione dovrà, infine, definire un Regolamento che delinei le attività che saranno gestite centralmente dal Comitato di Direzione e sviluppate in modo comune per tutti gli ES coinvolti.

Il Fornitore è tenuto a sottoporre in verifica e approvazione al Comitato di Direzione eventuali richieste specifiche che riguardino sia aspetti funzionali che non funzionali che possano non garantire l'unicità del sistema per tutti gli ES.

Project Manager

Le funzioni di erogazione dei servizi agiscono sotto il coordinamento dei ruoli di governo. Hanno un'autonomia organizzativa e operativa, ma sono al tempo stesso allineate tra loro e alle funzioni di governo da un framework di obiettivi coerente. È necessario, tuttavia, identificare una figura (**"Project Manager"**) che si ritiene essere chiave in termini di interfaccia operativa tra fornitore ed Azienda Zero, eventualmente coinvolgendo il singolo ES. Di seguito si descrivono le competenze del **Project Manager** di cantiere che il Fornitore dovrà indicare quale referente operativo per la realizzazione di quanto previsto contrattualmente:

- al fine di garantire un efficace coordinamento e monitoraggio delle attività effettuate il singolo Project Manager di cantiere dovrà garantire un supporto continuativo e dedicato; pertanto, il Fornitore dovrà considerare il suo impegno, nel periodo compreso tra la data di avvio del progetto e la conclusione della diffusione del sistema e dei suoi moduli per ogni ES negli anni successivi;
- il Project Manager di cantiere dovrà essere il riferimento di più alto livello per la gestione del progetto nel suo complesso e per la risoluzione delle potenziali problematiche che potrebbero presentarsi;
- relativamente alle caratteristiche richieste per tale tipologia di profilo (Project Manager) si prega di far riferimento a quelle esplicitate all' Appendice 1A ("Profili Professionali") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

9.3.4. I processi di Governo

Di seguito vengono descritti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni processi di Governo che regolamentano la gestione dei rapporti fra i singoli ES e il Fornitore. Gli organismi di Governo gestiranno almeno i seguenti processi principali:

– Determinazione delle penali:

Per quanto riguarda la gestione degli LdS si rimanda a quanto riportato nel Capitolo 10 del presente Capitolato Tecnico e quindi a quanto indicato all'Appendice 2 ("Livelli di Servizio") al CTS dell'AQ CONSIP ID 2365. Sulla base, infatti, dei risultati dei rapporti di valutazione dei Livelli di servizio, prodotti con le modalità descritte, Azienda Zero applicherà le eventuali penali maturate nel periodo

di erogazione della Fornitura dandone comunicazione agli Enti Sanitari. Le attività inerenti all'applicazione delle eventuali penali saranno ulteriormente dettagliate nel Contratto Esecutivo.

– **Processi di audit:**

Azienda Zero si riserva la facoltà di effettuare audit verso il Fornitore. Tali audit saranno finalizzati a monitorare e verificare che le attività e/o i processi siano svolti dal Fornitore nel rispetto di quanto definito a livello contrattuale, ed in particolare rispetto ai requisiti di Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

9.4. Manutenzione, Assistenza e Conduzione Applicativa

9.4.1. Manutenzione

Il Fornitore dovrà garantire la manutenzione sui sistemi e applicativi preposti all'erogazione della Fornitura di natura correttiva, adeguativa ed evolutiva, definite come:

Manutenzione correttiva (MAC): comprende tutti gli interventi atti ad indagare e rimuovere le cause e gli effetti di eventuali malfunzionamenti dei sistemi e applicativi preposti all'erogazione della soluzione applicativa che determinano un comportamento del sistema difforme da quello definito in specifica, anche in termini di prestazioni, assicurando il ripristino dell'operatività. Sono parte di tali interventi:

- la presa in carico delle segnalazioni di malfunzionamento, la loro gestione e risoluzione;
- i contributi di competenza sistemistica e specialistica necessari alla corretta soluzione del malfunzionamento;
- il ripristino di basi dati danneggiate dagli errori;
- il ripristino di software malfunzionanti;
- la modifica della documentazione per il mantenimento della coerenza con quanto erogato.

Manutenzione adeguativa (MAD): comprende tutti gli interventi atti ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo. Comprende tutti gli interventi sul software che non rientrano nella correttiva e nella evolutiva, conseguenti al cambiamento dei requisiti organizzativi, normativi derivanti da atti legislativi regionali e/o nazionali, d'ambiente, di prodotto-tecnologia-ambienti-piattaforma. Nel caso di manutenzione normativa, il Fornitore è responsabile delle scelte interpretative e dei criteri di adeguamento che saranno implementati nell'ambito della Fornitura, fermi restando la conformità alla normativa e l'obbligo per il Fornitore ad informare preventivamente gli ES e Azienda Zero dei criteri adottati e dei tempi e delle modalità di adeguamento dei sistemi nel rispetto dei Livelli di servizio definiti.

La manutenzione adeguativa viene, tipicamente, innescata dall'esigenza di:

- adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno;
- adeguamenti necessari a seguito di innalzamento di versioni dei container, del software base e middleware;
- adeguamenti tesi all'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
- modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni;

- adeguamenti finalizzati a migliorare l'interoperabilità, l'integrazione e lo scambio dei dati;
- adeguamenti finalizzati a migliorare la standardizzazione delle informazioni;
- miglioramento dell'accessibilità e usabilità delle applicazioni.

Manutenzione evolutiva (MEV): comprende tutti gli interventi atti ad introdurre nel sistema corrente nuove funzionalità o modificare e rimuovere funzionalità esistenti. L'intervento sarà realizzato su richiesta degli ES tramite interventi del Fornitore "a corpo". Il Fornitore sarà tenuto a rispondere alla richiesta di intervento proponendo un progetto di lavoro e la stima dell'impegno necessario, che saranno oggetto di validazione da parte di Azienda Zero di concerto con gli ES.

Tali servizi saranno definiti e dimensionati sulla base delle metriche definite in AQ. Tali servizi saranno comunque remunerati a consuntivo al buon esito delle verifiche di conformità e, pertanto, solo se il servizio prestato soddisfa tutti i requisiti espressi dall'Amministrazione, nei modi e tempi da essa indicati e rispettando tutti i livelli di qualità, di servizio e di obiettivo richiesti nonché gli impegni migliorativi offerti.

Relativamente ai servizi di manutenzione, si prega di far riferimento a quanto indicato nell'Allegato 2A ("Lotti Applicativi 1-2-3-4") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

9.4.2. Assistenza

Il Fornitore dovrà organizzare il proprio servizio di assistenza integrandosi con il modello organizzativo e operativo di assistenza erogato localmente dagli ES, schematizzato in Figura 2. Il modello prevede il punto di contatto tra utenza e servizio di Service Desk dedicato di I livello presso gli ES, per la presa in carico, la qualificazione e la soluzione, ove possibile, delle chiamate di assistenza, o l'eventuale inoltro ai II livelli di competenza.

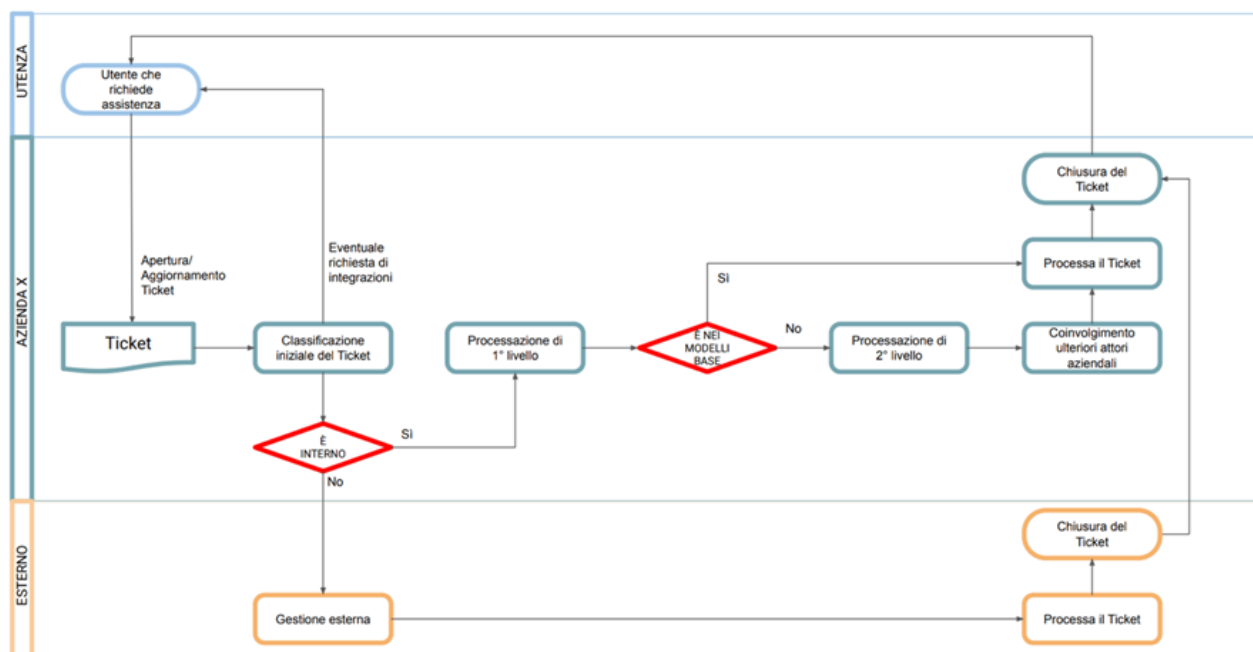


Figura 2 - Modello di Assistenza

Le chiamate di assistenza verranno tracciate sul sistema di Trouble Ticketing (TTS) presso gli ES, che garantirà:

- la presa in carico del ticket ad esso assegnato;
- l'inoltro del ticket al corrispondente II livello;
- tutte le comunicazioni intermedie sullo stato di lavorazione e/o le azioni/verifiche da attuare tra gli attori coinvolti;
- la chiusura del ticket con comunicazione di esito.

Il Fornitore sarà tenuto, ove richiesto dall'ES nel corso della esecuzione contrattuale e allo scopo di incrementare l'efficacia del processo di assistenza, a realizzare, con oneri a suo carico per quanto di propria competenza, una integrazione applicativa (ad es. attraverso Web Services/API) tra il proprio sistema di Trouble Ticketing e il TTS dell'ES stesso, in modo da consentire un passaggio automatico dei ticket in caso di interventi cross-boundaries.

Resta salva la facoltà da parte dell'ES di abilitare alcuni soggetti autorizzati (es. referenti dell'ES) in caso di specificate e motivate circostanze, alla apertura di segnalazioni direttamente al servizio di Assistenza del Fornitore tramite canali di contatto alternativi (ad es. mail, telefono, ecc.), da individuarsi in sede di predisposizione del servizio.

Il Fornitore, al fine di permettere agli operatori del Service Desk dell'ES di qualificare correttamente le richieste al II livello, dovrà mettere a disposizione del Service Provider idonee procedure operative di verifica sui sistemi/servizi oggetto di Fornitura, nonché raccogliere le casistiche di segnalazione/soluzione in una apposita Knowledge Base, appositamente destinate alla esecuzione semplice e rapida di operazioni basiche da parte degli operatori di I livello.

Nell'ottica di garantire la fruibilità del sistema, il fornitore dovrà garantire oltre alla assistenza di II livello, anche un servizio di supporto all'uso che dovrà:

- gestire direttamente le segnalazioni e le comunicazioni verso gli interlocutori in caso di anomalie/incidenti;
- supportare, ove necessario, gli ES nell'utilizzo del sistema;
- fornire supporto per l'affiancamento a primi gruppi di utenti ed eventuale partecipazione per la preparazione ed erogazione degli interventi formativi mirati all'utilizzo delle applicazioni in caso di avviamento di nuove funzionalità o di nuovi servizi;
- predisporre e realizzare tutti gli interventi di supporto nelle fasi di avviamento di una nuova funzionalità o di una personalizzazione di funzionalità già in esercizio;
- eseguire estrazioni estemporanee di dati.

In caso di problemi che richiedano modifiche di prodotto dovranno essere fornite, ove possibile, soluzioni temporanee (workaround) da comunicare al I livello competente.

L'assistenza del Fornitore dovrà inoltre garantire un costante e continuo allineamento delle strutture di I livello competenti durante la risoluzione delle problematiche più complesse o nei casi in cui siano richiesti tempi più lunghi di lavorazione per la risoluzione e la chiusura del problema segnalato (sempre nel rispetto dei Livelli di servizio contrattuali).

Per una corretta erogazione dell'assistenza, è necessario in collaborazione con l'ES giungere ad una classificazione dei possibili malfunzionamenti in modo da attribuire correttamente l'urgenza da associare ad ogni segnalazione.

Si riporta a titolo esemplificativo ma non esaustivo una classificazione che tiene conto, oltre che della rilevanza della funzionalità/servizio interessati e dell'impatto sugli utilizzatori dell'ES, di altre eventuali variabili di contesto (ad es. scadenze temporali, visibilità esterna, vincoli normativi):

Esempi di categorie bloccanti:

- **Categoria 1 – Critica:** malfunzionamenti con sospensione dell'erogazione o grave degrado prestazionale del sistema o di una o più funzioni del sistema, con impatto su tutti gli utenti di una medesima unità organizzativa aziendale. È incluso in questa categoria anche il malfunzionamento con sospensione dell'erogazione o grave degrado che impatta tutte le postazioni di lavoro utilizzate dalla medesima unità organizzativa aziendale. Sono inoltre ricomprese tutte le problematiche di sicurezza applicativa (compresi gli incidenti di sicurezza informatica);
- **Categoria 2: – Alta:** malfunzionamenti con sospensione dell'erogazione o grave degrado prestazionale del sistema o di una o più funzioni del sistema, con impatto su uno o più utenti di una medesima unità organizzativa aziendale. È incluso in questa categoria il malfunzionamento con sospensione dell'erogazione o grave degrado che impatta una o più postazioni di lavoro utilizzate da una medesima unità organizzativa aziendale.

Esempi di categorie non bloccanti:

- **Categoria 3: – Media:** malfunzionamenti con parziale degrado prestazionale del sistema o di una o più funzioni del sistema, con impatto su uno o più utenti.
- **Categoria 4: – Bassa:** malfunzionamenti di tipo marginale per i quali l'utilizzatore è in grado di svolgere la normale attività ricorrendo ad altre modalità operative.

Il Fornitore deve assicurare l'assistenza nella fascia oraria 8:00-20:00, 7 giorni su 7, con possibilità di estensione H24 ove richiesto dall'Amministrazione, ad esempio per applicativi destinati agli Ospedali di Comunità.

In generale, il modello di assistenza e le modalità di dettaglio dovranno essere concordate con l'Amministrazione nella fase di progettazione esecutiva della fornitura.

Le tempistiche per la risoluzione delle diverse categorie di malfunzionamento sono definite in Appendice 2 ("Livelli di Servizio") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

9.4.3. Conduzione applicativa

Al Fornitore è richiesto il servizio di "Conduzione Applicativa - Gestione applicativi e base di dati", secondo quanto descritto nell'Allegato 2A ("Lotti Applicativi 1-2-3-4") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

Le attività del servizio trovano collocazione rispetto alla maggior parte delle fasi previste. Sono parte integrante del servizio:

AZIENDA_ZERO – Appalto Specifico ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per gli Enti Sanitari della Regione Veneto – ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITÀ DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI – ID 2365 - LOTTO 3 Capitolato Tecnico

- indicare i parametri applicativi oggetto di monitoraggio e/o le modalità con cui devono essere configurati i sistemi di monitoraggio gestiti dall'Outsourcer di Azienda Zero, al fine di verificare la disponibilità dell'applicazione e misurare le performance.
- rendere disponibili le informazioni necessarie alla configurazione della Cloud Management Platform utilizzata dall'Outsourcer per l'automazione delle attività di gestione e dei change infrastrutturali.
- collaborare con l'Outsourcer per la corretta e ottimale gestione della piattaforma container Openshift.
- collaborare con l'Outsourcer per la verifica periodica del dimensionamento dell'infrastruttura a supporto del sistema garantendo gli interventi necessari al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di conseguenza i costi di esercizio.
- effettuare quanto necessario per le attività di configurazione del sistema e per il funzionamento della stessa negli ambienti di test/collaudo e produzione. A questo proposito si evidenzia che le policy di Azienda Zero prevedono una serie di attività e controlli da parte della funzione Configuration Management e che i processi sono differenziati in funzione della modalità realizzativa dell'applicazione:
 - sviluppo "ad hoc": il software sviluppato deve essere rilasciato su repository e l'immagine container è generata da Azienda Zero;
 - package: consegna dell'immagine ed esecuzione di controlli, fra cui controlli di sicurezza effettuati mediante scansione dell'immagine con il supporto di un tool CheckPoint, che potrebbe essere utilizzato anche dal Fornitore per verifiche preventive.
- garantire le condizioni necessarie per consentire le attività di gestione della sicurezza in carico all'Outsourcer, quali a titolo esemplificativo:
 - hardening dei sistemi;
 - patching;
 - security monitoring;
 - log analysis e log correlation;
 - controllo utenze.
- rendere disponibili e mantenere le procedure da applicare in caso di Disaster Recovery e garantire le necessarie attività per i test che saranno pianificati.
- gestire adeguatamente il versioning del codice.
- effettuare quanto necessario per la relocation del sistema e dei dati in caso di evoluzioni delle piattaforme di Azienda Zero dedicate all'erogazione del servizio.

9.4.3.1. Presidio on site

Per tutta la durata contrattuale deve essere garantita da parte dell'Aggiudicatario la presenza continuativa presso gli ES di un gruppo specializzato con adeguata esperienza tecnica e gestionale. La modalità di erogazione del presidio on-site dovrà essere concordata in fase esecutiva con gli ES e Azienda Zero. Il personale di presidio si intende direttamente coordinato da ciascun Ente Sanitario.

In fase di presentazione dell'offerta, l'Aggiudicatario deve riportare i profili delle risorse che intende impegnare lungo tutto l'arco temporale del contratto, che devono svolgere le attività di assistenza on-site. Il servizio di assistenza specialistica on-site può attivare il servizio di help desk e il servizio di assistenza.

Deve essere riportato nella proposta l'assetto organizzativo per supportare la gestione operativa del servizio, esplicitando tramite schede professionali gli FTE di presidio garantiti secondo il seguente schema professionale:

- titolo di studio;
- certificazioni attinenti al ruolo e all'attività assegnata all'interno della fornitura (non vincolante);
- eventuale durata dell'esperienza area ICT attinente al progetto in ambito sanitario pubblico;
- eventuale durata dell'esperienza area ICT attinente al progetto in ambito sanitario privato.

Il gruppo di risorse deve essere costituito indicativamente da un numero di referenti, specializzati per ogni singola area di intervento: la copertura oraria di tale personale deve essere tale da garantire lo svolgimento delle attività necessarie anche alla corretta gestione progettuale (qualora necessario anche in orari notturni e/o in giornate prefestive e festive, comunque all'interno degli FTE previsti e concordati in sede esecutiva di progetto).

È altresì richiesto che sia definito il coordinamento delle figure professionali dell'intero team (Project Manager), fermo restando che le attività decisionali saranno indirizzate da uno o più referenti interni individuati dall'ES.

Il Project Manager deve assicurare nel corso dell'anno un presidio minimo di tale personale per garantire il rispetto dei livelli minimi di servizio. L'ES potrà richiedere al Project Manager di produrre mensilmente un report che specifica per ogni figura professionale l'impegno erogato mensilmente sulle diverse attività, che deve essere controfirmato dal responsabile preposto dall'ES.

In caso di avvicendamento del personale sarà responsabilità dell'Aggiudicatario adeguare in termini qualitativi e quantitativi, per tutta la durata del contratto, le risorse utilizzate.

Le Aziende si riservano di valutare e segnalare incompatibilità/inadeguatezza del personale predisposto dall'Aggiudicatario per l'erogazione del servizio e richiederne la sostituzione, con istanza insindacabile.

In caso di variazione al gruppo di lavoro l'Aggiudicatario deve assicurare alle nuove risorse un periodo di affiancamento per lo meno di quattro settimane lavorative, senza oneri per le Aziende.

9.5. Exit Strategy

Relativamente alle attività di Exit strategy, si prega di far riferimento a quanto indicato al Capitolo 7.5 dell'Allegato 2A ("Lotti Applicativi 1-2-3-4") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella presente sezione vengono comunque descritte le attività e le procedure che saranno richieste al Fornitore nella fase finale del rapporto contrattuale, per il passaggio delle consegne al personale del Committente, per le aree di competenza previste,

e per il trasferimento di tutte le conoscenze necessarie a garantire la fluida transizione nella erogazione e la continuità operativa per l'utenza dei servizi in fornitura del Committente.

Alla scadenza del contratto il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi al Committente o ad una terza parte da esso individuata per un periodo pari al minimo agli ultimi due (2) mesi di contratto.

La fase di Exit strategy, oltre a quanto detto, contempla i seguenti aspetti:

- fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
- gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
- diritti di proprietà intellettuale: accordi necessari, licenze, codice (ove previsto), etc.;
- due diligence: definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire ad un altro Fornitore subentrante, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
- contratti e licenze;
- sicurezza;
- piano di comunicazione.

In particolare, sulla base dei contenuti e delle caratteristiche qualificanti dell'attività di Exit Strategy, il Fornitore si deve impegnare durante la fase finale, fino al termine del periodo contrattuale a soddisfare i seguenti requisiti generali:

- non vi saranno impatti o interruzioni del servizio causate specificamente dalle attività di passaggio di consegne;
- non vi saranno decadimenti dei livelli di servizio, specificamente imputabili al passaggio delle consegne e all'affiancamento del personale del Fornitore con quello subentrante;
- non vi saranno modifiche agli ambienti operativi e applicativi gestiti;
- dal punto di vista dell'utente finale, non vi saranno significativi cambiamenti, specificamente imputabili al passaggio delle consegne, che possano inficiare le attività operative.

La proposta di un'adeguata Exit Strategy sarà oggetto di approfondita valutazione tecnica.

Di seguito si riporta una traccia dei contenuti e delle caratteristiche qualificanti dell'attività di Exit Strategy, che dovranno essere progettate e gestite di concerto con il Committente:

- **piano di Trasferimento:** Le attività di affiancamento e rilascio sono specificate e governate da uno specifico Piano di Trasferimento, in cui saranno riportate tutte le attività previste in termini di tempi, risorse impiegate, punti di verifica e controllo dei risultati attesi, criteri di accettazione, i rischi, la cadenza degli incontri per la verifica dello stato di avanzamento delle attività;
- **responsabilità:** durante il periodo di affiancamento e migrazione al termine del Contratto, la responsabilità del Servizio viene mantenuta dal Fornitore fino al termine previsto contrattualmente;

- **governo del processo:** il Fornitore assicura tutte le attività finalizzate a coordinare e verificare la corretta ed efficace esecuzione delle attività di Affiancamento e Rilascio nel rispetto dei termini concordati nonché la coerenza con i requisiti, i vincoli ed i termini stabiliti nei documenti contrattuali; a tale scopo viene individuata una figura unica per il Fornitore (Project Manager) che coordinerà tutte le attività e che interfacerà il Committente ovvero l'eventuale Fornitore terzo subentrante;
- **continuità dei servizi:** al fine di garantire al Committente il mantenimento dei richiesti livelli di servizio da parte del subentrante, nel Piano di Trasferimento sono previste fasi di verifica e validazione sia del trasferimento di know-how che del rilascio della documentazione; altresì, contestualmente al trasferimento delle conoscenze, si prevede un adeguato periodo di affiancamento delle risorse del subentrante nella operatività corrente del Fornitore uscente;
- **risorse professionali:** un gruppo di risorse del Fornitore appositamente designato affiancherà le risorse del Committente e/o del Fornitore subentrante per il trasferimento delle conoscenze sui servizi e sulle relative attività di gestione; il team sarà composto da personale già impegnato nell'erogazione dei servizi.

9.6. Rendicontazione

La rendicontazione avverrà con cadenza concordata con l'Amministrazione contraente (di norma bimestrale) sulla base di rapporti di "stato avanzamento lavori" (SAL) prodotti dal Fornitore per il periodo di riferimento e approvati dall'Amministrazione. Il rapporto di SAL dovrà indicare puntualmente le attività svolte e i deliverable consegnati dal Fornitore nel periodo di riferimento, in coerenza con le milestone previste per il medesimo periodo nelle pianificazioni periodiche (di natura normalmente semestrale) che dovranno essere predisposte dal Fornitore e approvate dalla scrivente Amministrazione. Si dovrà esplicitare chiaramente ed evidenziare come le suddette milestone siano direttamente connesse con i rilasci, i collaudi e gli avvii dei moduli del sistema riportati nel Piano di Lavoro di Obiettivo.

L'importo di rendicontazione sarà pertanto dato dalla somma dei valori di corrispettivo associati a ciascuna milestone prevista nel medesimo periodo e, solo a scadenza del periodo di garanzia, ove previsto, anche dei canoni di manutenzione concordati con la Committenza, come descritto nei Capitoli 11 e 12. La fatturazione sarà consentita dopo l'approvazione del SAL da parte dell'Amministrazione a seguito della verifica del corretto funzionamento delle funzionalità previste dal sistema (e a fronte della necessaria documentazione attestante) e alla verifica di conformità delle prestazioni erogate e positivamente accertate. Le modalità operative di dettaglio di tale verifica saranno concordate con l'Amministrazione durante la fase esecutiva del progetto. Con riferimento alle condizioni di pagamento dei corrispettivi su indicati, si rimanda al Contratto esecutivo che sarà attivato a fronte della presente procedura.

10. LIVELLI DI SERVIZIO

Per quanto concerne i Livelli di servizio, oltre a quanto sotto riportato, si faccia interamente riferimento a quanto indicato all'Appendice 2 ("Livelli di Servizio") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365.

Il sistema deve dare garanzia di elevate performance anche in presenza di notevoli livelli carico e un elevato numero di contatti giornalieri. Dovranno essere messi in opera sistemi di monitoraggio finalizzati al controllo puntuale dei livelli di servizio.

Si ricorda che il Fornitore, durante l'intera durata dell'incarico, dovrà periodicamente produrre e consegnare specifici rapporti di dettaglio che verranno utilizzati per la valutazione del rispetto dei Livelli di servizio costruiti secondo formati e contenuti coerenti con la tipologia dell'indicatore in esame e con periodicità congruente con il relativo periodo di riferimento. La struttura dei rapporti dovrà essere prodotta dal Fornitore secondo uno schema condiviso e approvato dagli Enti Sanitari/Azienda Zero.

Per alcuni Livelli di servizio, esplicitamente indicati, le informazioni elementari raccolte dal Fornitore per il calcolo degli stessi dovranno essere registrate in specifici file in formato .csv, che dovranno:

- possedere un identificativo progressivo;
- essere marcati temporalmente.

Si precisa che tali file dovranno essere prodotti, su un template condiviso e approvato dagli Enti Sanitari/Azienda Zero, e inviati agli stessi e potranno essere utilizzati per verificare la correttezza dei report dei Livelli di servizio.

In caso di discordanze tra le tempistiche di lavorazione dei ticket registrate nel sistema di TTS del Fornitore rispetto a quelle presenti nel TTS dello SPOC, tali da comportare una diversa valutazione del rispetto dei Livelli di servizio erogati, l'ES potrà richiedere il ricalcolo dei Livelli di Servizi erogati utilizzando le informazioni registrate a livello di SPOC.

Indipendentemente dal periodo di consuntivazione (variabile in relazione allo specifico indicatore) il Fornitore è tenuto ad uno stretto controllo dell'andamento dei livelli qualitativi dei servizi offerti per intervenire tempestivamente nel ripristino dei valori target non appena si rilevino deviazioni significative.

Il non rispetto dei Livelli di servizio in seguito alla rilevazione del superamento dei valori di soglia crea le condizioni per azioni contrattuali.

Trovano applicazione i Livelli di servizio, come previsto all'Appendice 2 ("Livelli di Servizio") al CTS dell'AQ CONSIP ID2365, nelle seguenti macrocategorie:

- governo della fornitura;
- servizi di sviluppo;
- manutenzione Correttiva (MAC) e Adeguativa (MAD);
- conduzione Applicativa;
- servizio Conduzione Tecnica.

Si precisa che qualora il Fornitore abbia dichiarato nella propria Offerta Tecnica il miglioramento dei valori di soglia rispetto a quanto indicato all'Appendice 2 ("Livelli di Servizio") al CTS dell'AQ

CONSIP ID2365, gli scostamenti al fine dell'applicazione delle penali saranno calcolati rispetto ai valori soglia dichiarati nell'Offerta Tecnica.

I Livelli di servizio descritti ai punti precedenti saranno misurati negli orari di seguito indicati, fatto salvo dove diversamente specificato.

- punti 1) e 2): dalle ore 8.00 alle ore 20.00, giorni feriali;
- punti 3), 4) e 5): dalle ore 8:00 alle 20:00 (senza interruzione), 365 gg./anno, con estensione H24, ove concordato.

11. GESTIONE DEI CORRISPETTIVI

11.1. Organizzazione dei corrispettivi

I corrispettivi saranno parametrizzati in accordo con quanto indicato nel Capitolato tecnico generale (Capitolo 6.3.2 "Adesione all'Accordo Quadro con Rilancio Competitivo (Lotti Applicativi) CONSIP ID2365). L'Accordo Quadro prevede di determinare i corrispettivi per il sistema partendo dai prezzi unitari relativamente a ciascuno dei servizi richiesti nel CTS dell'AQ CONSIP ID2365. Si procederà al calcolo della base d'asta complessiva moltiplicando i prezzi unitari suddetti per i quantitativi espressi dall'Amministrazione.

A livello generale l'ipotesi di distribuzione dei costi prevede:

- oneri iniziali di progetto per il dispiegamento dell'organizzazione necessaria alla conduzione di progetto, nonché alla predisposizione del sistema e sua istanziazione nel contesto veneto;
- oneri di servizi di conduzione applicativa per l'avviamento delle implementazioni specifiche per ogni singolo Ente Sanitario (analisi, servizi di implementazione, formazione, ...). Il Fornitore entrante sarà vincolato alla interazione con gli attuali fornitori del servizio presso gli Enti Sanitari per gestire la fase di transitorio al nuovo sistema regionale.
- oneri inerenti ai costi di erogazione dei servizi dei sistemi implementati (es. manutenzione, aggiornamenti tecnologici, assistenza, gestione operativa, ...), da sostenersi coerentemente con l'avanzamento delle attività implementative sul territorio.

In particolare, si richiede l'erogazione, a livello complessivo di fornitura, dei seguenti servizi:

- **Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field (GF)** (Capitolo 4.1.1 CTS Lotti Applicativi): rientrano in questo servizio tutti i progetti il cui obiettivo è creare intere nuove applicazioni non esistenti precedentemente, e i progetti di rifacimento e/o di reingegnerizzazione completa di applicazioni esistenti che richiedano la riprogettazione dell'architettura applicativa, delle basi dati e delle interfacce, al fine di realizzare un'applicazione completamente differente da quella di partenza. Il servizio prevede le attività di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento di tutte le componenti –e artefatti– del nuovo sistema, compreso il supporto alle attività di collaudo e testing.

Per la remunerazione delle attività legate a questo servizio si applicherà il ciclo tradizionale ridotto (§ Appendice 3 al CTS Lotti applicativi, § Allegato 4A Schema di Contratto Esecutivo, art. 11.3) con il riconoscimento dell'80% della quota fissa dell'importo stabilito per il singolo modulo e per ogni singolo Ente Sanitario (corrispondente al 30% della fase di analisi e disegno, e 50% dell'esito positivo del collaudo), al momento dell'avvio post-collaudo del singolo modulo per il singolo ES. Il restante 20% della quota fissa verrà riconosciuto in un'unica soluzione solo al completamento ed alla verifica di conformità di tutte le attività di avvio post-collaudo in tutti gli Enti Sanitari impattati.

- **Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)** (Capitolo 4.1.4 CTS Lotti Applicativi): rientrano in questo servizio tutti gli interventi di configurazione e personalizzazione di prodotti software di terze parti, quali realizzazione di ulteriori moduli software su richiesta dell'Amministrazione, determinazione

delle caratteristiche necessarie alla messa a punto del software affinché risulti correttamente installato presso gli ES e copertura di ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dal sistema.

Per la remunerazione delle attività legate a questo servizio si applicherà il ciclo tradizionale ridotto (§ Appendice 3 al CTS Lotti applicativi, § Allegato 4A Schema di Contratto Esecutivo, art. 11.3) con il riconoscimento dell'80% della quota fissa dell'importo stabilito per il singolo modulo e per ogni singolo Ente Sanitario (corrispondente al 30% della fase di analisi e disegno, e 50% dell'esito positivo del collaudo), al momento dell'avvio post-collaudo del singolo modulo per il singolo ES. Il restante 20% della quota fissa verrà riconosciuto in un'unica soluzione solo al completamento ed alla verifica di conformità di tutte le attività di avvio post-collaudo in tutti gli Enti Sanitari impattati.

- **Servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV)** (Capitolo 4.1.2 CTS Lotti Applicativi): comprende gli interventi volti ad arricchire le applicazioni esistenti di nuove funzionalità, o comunque volti a modificare e/o integrare le funzionalità già esistenti. La remunerazione delle attività legate a questo servizio prevede un importo commisurato secondo le prestazioni effettivamente erogate, previa accettazione da parte degli Enti Sanitari/Azienda Zero della stima economica indicata dal fornitore; l'importo verrà corrisposto a corpo in base alle prestazioni erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità al termine delle attività previste nel periodo. Si ricorda che questo servizio prevede una prima richiesta da parte degli Enti Sanitari/Azienda Zero, seguita da una stima da parte del fornitore, che dovrà essere accettata per iscritto prima dell'avvio delle attività di sviluppo.
- **Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAD – MAC)**: il servizio MAD (Capitolo 4.2.1 CTS Lotti Applicativi) comprende l'attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo. Comprende tutti gli interventi sul software che non rientrano nella correttiva e nella evolutiva, conseguenti a cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente, di prodotto-tecnologia-ambienti-piattaforma) che non richiedano una variazione dei requisiti funzionali. Il servizio MAC (Capitolo 4.2.2 CTS Lotti Applicativi) viene attivato da una segnalazione di malfunzionamento da parte degli Enti Sanitari/Azienda Zero. La remunerazione del servizio MAD-MAC è prevista attraverso l'erogazione di un canone mensile per ciascun Ente Sanitario. Si precisa che tale canone verrà concordato con la Committenza in fase esecutiva e riconosciuto solo per le mensilità di effettiva erogazione e solo a scadenza del periodo di garanzia (12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo del singolo Ente) sul software sviluppato e modificato/integrato. A fronte di collaudi parziali dei servizi erogati e previsti dal contratto, tale canone verrà rimodulato in quota parte proporzionale a quanto collaudato positivamente. In caso di mancata erogazione del servizio di MAD-MAC, totale o parziale, al termine del periodo contrattuale, nulla sarà dovuto al fornitore per la quota parte non erogata. Si ricorda inoltre che la garanzia si applica, per tutta la durata dell'erogazione dei servizi, su tutto il software rilasciato dal servizio di Sviluppo Ex-novo – Progetti Green Field (GF) e sul software modificato/integrato per i servizi di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP) di Evoluzione Applicazioni Esistenti.

- **Servizi di Conduzione Applicativa – Servizi di gestione applicativi e basi dati (GAB)** (Capitolo 4.3.1 CTS Lotti Applicativi): comprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni prevalentemente gestionali, delle loro relative basi dati e data services.

La remunerazione dell'attività sarà concordata con la Committenza in fase esecutiva di progetto, in coerenza con quanto descritto nel Piano di Lavoro di Obiettivo concordato. Tale remunerazione è prevista a misura, previa accettazione della stima economica indicata dal fornitore; l'importo verrà corrisposto al termine delle attività previste all'interno del periodo di SAL di riferimento.

- **Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica (CT)** (Capitolo 4.4.1 CTS Lotti Applicativi): comprendono le attività, pianificabili e non, finalizzate alla presa in carico e gestione ordinata ed efficiente delle architetture e di tutte le infrastrutture tecnologiche dell'Amministrazione a supporto del sistema informativo della sanità, nonché la loro evoluzione. Si precisa che questa categoria di servizio comprende i Servizi Sistemistici, in particolare per quanto riguarda l'analisi, la conduzione e il conseguente monitoraggio delle componenti tecnologiche necessarie affinché la piattaforma software messa a disposizione possa erogare correttamente il servizio.

La remunerazione dell'attività sarà concordata con la Committenza in fase esecutiva di progetto, in coerenza con quanto descritto nel Piano di Lavoro di Obiettivo concordato. Tale remunerazione è prevista a misura, previa accettazione della stima economica indicata dal fornitore; l'importo verrà corrisposto al termine delle attività previste all'interno del periodo di SAL di riferimento.

La suddivisione e categorizzazione degli importi previsti per singolo servizio sono illustrate al Capitolo 12 "Elementi dimensionali".

12. ELEMENTI DIMENSIONALI

Il Capitolo riassume gli elementi dimensionali della Fornitura. Tutte le quantità riportate nel presente Capitolo sono da considerarsi indicative del fabbisogno stimato e rappresentano i driver di definizione del valore, predeterminato, del contratto esecutivo che Azienda Zero sottoscriverà con il fornitore.

Intervento n°1: Implementazioni moduli per la gestione clinico-gestionale della Riabilitazione Territoriale, dell'Ospedale di Comunità, del Consultorio e dell'Assistenza Domiciliare, e per la generazione dei relativi flussi informativi. Comprende i seguenti servizi:

- servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field (GF);
- servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP);
- servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV);
- servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica (CT);
- servizi di Conduzione Applicativa - Servizi di gestione applicativi e basi dati (GAB).

Tabella 7 - Dimensionamento dei servizi per l'Intervento n°1

Servizio	# unità richieste	Metrica	Prezzo maggiorato offerto in AQ	Totale prezzo in AS (IVA esclusa)
Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo-Green Field (GF)	1.776	GG/team ottimale	232,04 €	412.103,04 €
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	2.418	GG/team ottimale	211,32 €	510.971,76 €
Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)	496	GG/team ottimale	202,35 €	100.365,60 €
Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica (CT)	1.457	GG/team ottimale	212,70 €	309.903,90 €
Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	4.784	GG/team ottimale	192,40 €	920.441,60 €
TOTALE				2.253.785,90 €

Si ricorda che la suddivisione degli importi per le Aziende impattate sarà concordata con l'Amministrazione contraente durante la fase esecutiva dell'intervento.

Intervento n°2: Completamento, diffusione, formazione, import dati dai precedenti applicativi, supporto di presidio locale e sviluppi evolutivi di tutti i moduli COT, ADI, OdC, URT, HOSPICE, CONSULTORIO, SALUTE MENTALE per tutte le Aziende. Comprende i seguenti servizi:

- servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field (GF);
- servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP);
- servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV);
- servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica (CT);

– **servizi di Conduzione Applicativa - Servizi di gestione applicativi e basi dati (GAB).**

I servizi sono quindi così dimensionati:

Tabella 8 - Dimensionamento dei servizi per l'Intervento n°2

Servizio	# unità richieste	Metrica	Prezzo maggiorato offerto in AQ	Totale prezzo in AS (IVA esclusa)
Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo-Green Field (GF)	1.776	GG/team ottimale	232,04 €	412.103,04 €
Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	1.931	GG/team ottimale	211,32 €	408.058,92 €
Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)	1.625	GG/team ottimale	202,35 €	328.818,75 €
Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica (CT)	1.459	GG/team ottimale	212,70 €	310.329,30 €
Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	4.784	GG/team ottimale	192,40 €	920.441,60 €
TOTALE				2.379.751,61 €

Si ricorda che la suddivisione degli importi per le Aziende impattate sarà concordata con l'Amministrazione contraente durante la fase esecutiva dell'intervento.

Intervento n° 3: Servizio di Help-Desk dedicato + Canoni di Manutenzione Ordinaria per tutti i moduli COT, ADI, OdC, URT, HOSPICE, CONSULTORIO, SALUTE MENTALE per tutte le Aziende. Comprende i seguenti servizi:

- **servizi di Conduzione Applicativa - Servizi di gestione applicativi e basi dati (GAB);**
- **servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAD-MAC).**

I servizi sono quindi così dimensionati:

Tabella 9 - Dimensionamento dei servizi per l'Intervento n°3

Servizio	# unità richieste	Metrica	Prezzo maggiorato offerto in AQ	Totale prezzo in AS (IVA esclusa)
Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	3.424	GG/team ottimale	192,40 €	658.777,60 €
Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva (MAD-MAC)	485	FTE/mese	3.884,30 €	1.883.885,50 €
TOTALE				2.542.663,10 €

Si ricorda che la suddivisione degli importi per gli ES impattati sarà concordata con l'Amministrazione contraente durante la fase esecutiva dell'intervento.